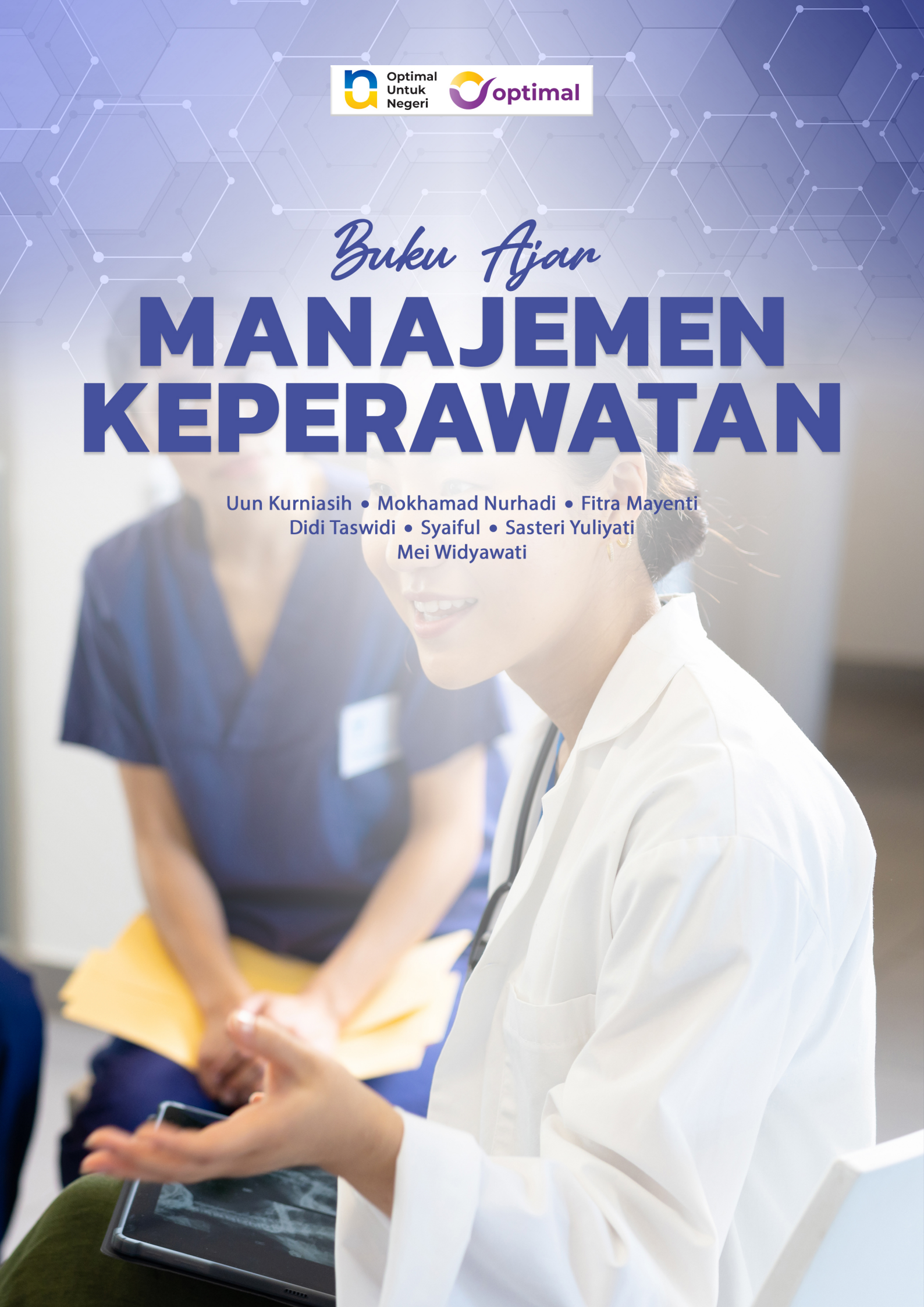


Buku Ajar

MANAJEMEN KEPERAWATAN

Uun Kurniasih • Mokhamad Nurhadi • Fitra Mayenti
Didi Taswidi • Syaiful • Sasteri Yuliyati
Mei Widyawati



BUKU AJAR

MANAJEMEN KEPERAWATAN

Penulis:

Uun Kurniasih, S.Kep., Ns., M.M.

Mokhamad Nurhadi, S.Kep., Ns., M.Kep., MM.

Ns. Fitra Mayenti, S.Kep., M.Kep.

Didi Taswidi S.Kep., Ners., M.Kep.

Syaiful, S.Pd., S.Kep., Ns., M.Pd., M.Kes.

Ns. Sasteri Yuliyati, S.Kep., M.Kep.

Mei Widyawati, S.Kep., Ns., M. Kep.



Buku Ajar Manajemen Keperawatan

Penulis: Uun Kurniasih, SmKep., Ns., M.M.
Mokhamad Nurhadi, S.Kep., Ns., M.Kep., MM.
Ns. Fitra Mayenti, S.Kep., M.Kep.
Didi Taswidi S.Kep., Ners., M.Kep.
Syaiful, S.Pd., S.Kep., Ns., M.Pd., M.Kes.
Ns. Sasteri Yuliyati, S.Kep., M.Kep.
Mei Widyawati, S.Kep., Ns., M. Kep.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Rizki Alamsyah

ISBN: 978-634-96049-8-7

Cetakan Pertama : Juni, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan buku ajar ini dengan judul "Manajemen Keperawatan". Buku ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan akan sumber referensi yang komprehensif, relevan, dan aplikatif dalam bidang manajemen keperawatan, yang merupakan salah satu pilar penting dalam praktik pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada mutu.

Di era transformasi sistem pelayanan kesehatan saat ini, profesi keperawatan dituntut untuk tidak hanya menguasai keterampilan klinis, tetapi juga memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola sumber daya, mengatur prioritas, dan mengambil keputusan yang tepat di tengah berbagai dinamika lapangan. Peran perawat telah berkembang dari sekadar pelaksana asuhan keperawatan menjadi pemimpin tim kesehatan, manajer unit pelayanan, bahkan pengambil kebijakan di berbagai tingkat sistem kesehatan.

Manajemen keperawatan adalah suatu proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan yang bertujuan untuk mencapai asuhan yang berkualitas dan aman bagi pasien. Oleh karena itu, pemahaman yang kuat mengenai konsep, prinsip, serta praktik manajemen sangat dibutuhkan bagi mahasiswa, dosen, maupun tenaga perawat profesional.

Buku ini disusun dengan mengintegrasikan teori-teori dasar manajemen, pendekatan praktik manajerial yang kontekstual dengan dunia keperawatan, serta refleksi dari pengalaman-pengalaman lapangan yang aktual. Materi disajikan secara sistematis mulai dari konsep dasar manajemen keperawatan, fungsi-fungsi manajerial, peran dan tanggung jawab manajer keperawatan, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan konflik, pengambilan keputusan, hingga manajemen mutu dalam pelayanan keperawatan. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi pedoman praktis sekaligus landasan teoritis yang kuat bagi para pembaca.

Penulis juga berupaya menyelaraskan isi buku ini dengan perkembangan terkini dalam dunia kesehatan, termasuk penerapan evidence-based practice, teknologi informasi dalam keperawatan, serta pendekatan holistik yang berpusat pada pasien (patient-centered care). Harapannya, buku ini dapat membekali pembaca dengan wawasan dan keterampilan manajerial yang sesuai dengan tuntutan profesi masa kini dan masa depan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak lepas dari berbagai kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, masukan, kritik, dan saran yang konstruktif dari pembaca sangat penulis harapkan demi perbaikan dan

penyempurnaan di masa mendatang. Penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moral maupun ilmiah dalam proses penulisan buku ini, termasuk rekan sejawat, dosen pembimbing, mahasiswa, serta praktisi keperawatan yang telah banyak memberikan inspirasi.

Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang luas, menjadi sumber referensi yang bermanfaat, serta turut berkontribusi dalam pengembangan pendidikan keperawatan dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan di Indonesia.

Penulis

Juni, 2025

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB 1 KONSEP DASAR MANAJEMEN	1
A. Pengertian Dan Sejarah Manajemen.....	3
B. Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen	12
C. Latihan Soal	15
D. Rangkuman Materi	18
E. Glosarium.....	19
F. Daftar Pustaka.....	21
BAB 2 MANAJEMEN KEPERAWATAN DAN ASUHAN KEPERAWATAN	25
A. Manajemen Keperawatan	28
B. Manajemen Asuhan Keperawatan.....	37
C. Latihan Soal	48
D. Rangkuman Materi	52
E. Glosarium.....	52
F. Daftar Pustaka.....	53
BAB 3 MANAJEMEN PERENCANAAN KEPERAWATAN	55
A. Hakikat perencanaan	57
B. Tujuan Perencanaan.....	58
C. Unsur-unsur Dalam Perencanaan.....	58
D. Jenis Perencanaan dalam manajemen Keperawatan.....	59
E. Latihan Soal	63
F. Rangkuman Materi	64
G. Glosarium.....	64
H. Daftar Pustaka.....	65
BAB 4 PENGARAHAN DALAM KEPERAWATAN	66
A. Konsep Dasar Pengarahan.....	68
B. Tujuan Pengarahan dalam Manajemen Keperawatan.....	68
C. Kegiatan Manajemen Keperawatan Sebagai Fungsi Pengarahan	69

D. Rambu-rambu Kegiatan Pengarahan Menurut Douglas.....	73
E. Indikator Pengarahan yang Baik	73
F. Supervisi Keperawatan	74
G. Latihan Soal	74
H. Rangkuman Materi	74
I. Daftar Pustaka.....	75

BAB 5 KONSEP PRAKTIK KEPERAWATAN BERBASIS BUKTI (EVIDENCE-BASED NURSING PRACTICE)78

A. Berbagai pandangan tentang Definisi Praktik Keperawatan Berbasis Bukti.....	81
B. Elemen Utama Evidence-Based Nursing Practice (EBNP):.....	81
C. Tujuan Praktik Keperawatan Berbasis Bukti.....	81
D. Prinsip-Prinsip Dasar Evidence-Based Nursing Practice (EBNP)	82
E. Model Implementasi Evidence-Based Nursing Practice (EBNP).....	82
F. Jenis Bukti dalam EBNP (Hierarchy of Evidence)	82
G. Langkah-Langkah dalam Praktik Keperawatan Berbasis Bukti	83
H. Manfaat Praktik Keperawatan Berbasis Bukti (EBNP)	83
I. Tantangan dalam Implementasi Praktik Keperawatan Berbasis Bukti(EBNP).....	83
J. Strategi Implementasi Evidence-Based Nursing Practice (EBNP).....	83
K. Studi Kasus Sukses Implementasi EBNP	84
L. Contoh Kasus Penerapan Evidence-Based Nursing Practice (EBNP)	84
M. Latihan Soal	85
N. Rangkuman Materi	88
O. Glosarium.....	89
P. Daftar Pustaka.....	91

BAB 6 PRAKTIK MANAJEMEN ASUHAN KEPERAWATAN PADA KASUS KELOLAAN.....92

A. Konsep Dasar Praktik MAK pada Kasus Kelolaan.....	94
B. Tujuan Praktik Kasus Kelolaan.....	96
C. Tahapan Praktik Manajemen Asuhan Keperawatan.....	98
D. Prinsip Manajemen dalam Praktik Kasus Kelolaan	107
E. Studi Kasus.....	109
F. Latihan Soal	110

G. Rangkuman Materi	112
H. Glosarium.....	113
I. Daftar Pustaka.....	114

**BAB 7 PRAKTIK MANAJEMEN ASUHAN KEPERAWATAN SEBAGAI
ANGGOTA TIM KESEHATAN/KEPERAWATAN115**

A. Manajemen Keperawatan	118
B. Konsep Asuhan Manajemen Keperawatan	124
C. Latihan Soal	126
D. Rangkuman Materi	130
E. Glosarium.....	132
F. Daftar Pustaka.....	138

PROFIL PENULIS140

BAB 1

KONSEP DASAR MANAJEMEN

Tujuan Intruksional:

Menjelaskan tentang pengertian manajemen.

Menjelaskan tentang sejarah manajemen.

Menjelaskan Fungsi Manajemen

Menjelaskan Ruang Lingkup Manajemen

Menjelaskan Teori Dasar Manajemen

Menjelaskan Prinsip – Prinsip Dasar Manajemen

Menjelaskan Implementasi dan Pendekatan Manajemen dalam Konteks Modern

Capaian Pembelajaran:

Mampu menjelaskan tentang pengertian manajemen, sejarah manajemen, Fungsi Manajemen, Ruang Lingkup Manajemen, Teori Dasar Manajemen, Prinsip – Prinsip Dasar Manajemen, Implementasi dan Pendekatan Manajemen dalam Konteks Modern

Pendahuluan:

Pelayanan keperawatan merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan memberikan asuhan yang aman, berkualitas, dan berpusat pada pasien. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas kebutuhan kesehatan masyarakat dan perkembangan teknologi medis, peran perawat tidak lagi terbatas pada aspek klinis semata, melainkan juga mencakup kemampuan manajerial yang efektif dalam mengelola sumber daya, memimpin tim, serta menjamin mutu pelayanan.

Dalam konteks inilah, manajemen keperawatan memegang peranan strategis. Manajemen keperawatan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya—baik manusia, material, maupun informasi—dalam lingkungan pelayanan keperawatan, guna mencapai tujuan pelayanan yang optimal. Pemahaman yang baik terhadap konsep dasar manajemen keperawatan menjadi fondasi utama bagi perawat, khususnya mereka yang berada dalam posisi kepemimpinan atau memiliki tanggung jawab dalam pengambilan keputusan di unit kerja.

Buku ini disusun dengan tujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai Konsep Dasar Manajemen Keperawatan, mulai dari

pengertian dan ruang lingkup manajemen, fungsi-fungsi dasar manajemen, peran dan kompetensi manajer keperawatan, hingga pendekatan-pendekatan teoritis yang relevan dalam praktik keperawatan modern. Materi dalam buku ini disusun secara sistematis dan didukung oleh referensi terkini, sehingga dapat menjadi rujukan yang kredibel bagi mahasiswa keperawatan, dosen, serta tenaga perawat profesional di berbagai tingkat layanan.

Melalui buku ini, diharapkan pembaca dapat memahami pentingnya peran manajemen dalam menunjang efektivitas dan efisiensi pelayanan keperawatan, serta mengembangkan kemampuan kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang tepat dalam konteks praktik keperawatan yang dinamis. Dengan demikian, buku ini bukan hanya menjadi sumber belajar, tetapi juga sebagai bekal dalam menghadapi tantangan di dunia kerja, khususnya dalam meningkatkan mutu asuhan keperawatan yang berkesinambungan dan holistik.

A. Pengertian Dan Sejarah Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Menurut Robbins dan Coulter (2018), manajemen adalah koordinasi dan pengelolaan aktivitas untuk mencapai tujuan organisasi dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sementara itu, Griffin (2019) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses perencanaan dan pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mencapai tujuan dengan cara yang efisien dan efektif. Dalam literatur lain, Whetten dan Cameron (2020) menekankan bahwa manajemen bukan hanya sekadar mengatur sumber daya, tetapi juga melibatkan aspek kepemimpinan dan pengambilan keputusan strategis. Oleh karena itu, manajemen memiliki peran penting dalam menentukan arah dan keberhasilan suatu organisasi.

2. Sejarah Perkembangan Manajemen

Sejarah manajemen dapat ditelusuri sejak peradaban kuno, di mana manusia mulai menerapkan prinsip-prinsip organisasi dalam kegiatan sehari-hari. Perkembangan konsep manajemen dapat dikategorikan ke dalam beberapa periode penting:

- a. **Era Klasik (1900-an)** Pada era ini, konsep manajemen ilmiah mulai dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor yang dikenal dengan "Scientific Management". Taylor (2018) menyatakan bahwa efisiensi kerja dapat ditingkatkan melalui analisis ilmiah terhadap tugas-tugas pekerja. Selain itu, Henry Fayol (2019) memperkenalkan teori administrasi yang menekankan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian.
- b. **Era Hubungan Manusia (1930-an - 1950-an)** Periode ini ditandai dengan penelitian Elton Mayo yang dikenal dengan "Hawthorne Studies". Studi ini menunjukkan bahwa faktor sosial dan psikologis memiliki dampak besar terhadap produktivitas kerja. Menurut Mayo (2020), perhatian terhadap kesejahteraan dan kepuasan karyawan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja.
- c. **Era Manajemen Modern (1950-an - Sekarang)** Pendekatan manajemen modern mencakup berbagai teori seperti teori sistem, manajemen berbasis sumber daya manusia, dan manajemen strategis. Drucker (2021) menegaskan

bahwa manajemen tidak hanya tentang pengelolaan sumber daya, tetapi juga tentang inovasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis.

Seiring perkembangan teknologi dan globalisasi, manajemen terus mengalami transformasi. Konsep manajemen berbasis digital dan analisis data semakin berperan dalam pengambilan keputusan strategis di berbagai organisasi (Kotler & Keller, 2022).

3. Fungsi Manajemen

Menurut Griffin (2020), fungsi utama manajemen terdiri dari:

- a. Perencanaan (*Planning*): Menetapkan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapainya.

Perencanaan adalah suatu proses yang sistematis dalam menentukan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Wheelen dan Hunger (2019), perencanaan memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

- 1) Menentukan arah dan strategi organisasi.
- 2) Meningkatkan koordinasi dan efisiensi.
- 3) Mengurangi ketidakpastian dan risiko.
- 4) Meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan.

Perencanaan dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis, antara lain:

- 1) Perencanaan Strategis: Berfokus pada tujuan jangka panjang dan bagaimana organisasi mencapainya (Bryson, 2018).
- 2) Perencanaan Taktis: Menghubungkan perencanaan strategis dengan implementasi kebijakan secara lebih spesifik (Steiner, 2019).
- 3) Perencanaan Operasional: Melibatkan aktivitas dan prosedur harian yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan jangka pendek (Mintzberg et al., 2021).

perencanaan melibatkan beberapa tahapan penting, seperti:

- 1) Analisis Situasi: Mengidentifikasi kebutuhan, hambatan, dan peluang yang ada dalam lingkungan pendidikan (Johnson & Scholes, 2020).
- 2) Penetapan Tujuan: Menentukan hasil yang ingin dicapai dalam periode tertentu.
- 3) Pengembangan Strategi: Menyusun metode dan langkah-langkah yang akan digunakan.
- 4) Implementasi: Menerapkan strategi yang telah direncanakan dalam kegiatan pembelajaran.
- 5) Evaluasi dan Pengendalian: Mengukur efektivitas perencanaan dan melakukan perbaikan jika diperlukan (Kaplan & Norton, 2019).
- 6) Pengorganisasian (*Organizing*): Mengalokasikan sumber daya dan tugas kepada individu atau tim.

Menurut Griffin (2021), pengorganisasian adalah proses menyusun dan mengoordinasikan aktivitas serta sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup beberapa elemen utama:

- 1) Struktur organisasi – penentuan hierarki dan hubungan kerja dalam organisasi.
- 2) Spesialisasi tugas – pembagian kerja berdasarkan keahlian dan kompetensi individu.
- 3) Koordinasi – integrasi berbagai aktivitas untuk memastikan efisiensi operasional.
- 4) Delegasi wewenang – pemberian tanggung jawab kepada individu atau kelompok tertentu dalam organisasi.

Pengorganisasian memiliki peran penting dalam keberlangsungan organisasi. Menurut Daft (2021), manfaat utama dari pengorganisasian yang efektif meliputi:

- 1) Meningkatkan efisiensi operasional dengan membagi tugas sesuai dengan kompetensi.
- 2) Memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara berbagai departemen.
- 3) Memudahkan koordinasi dan pengambilan keputusan.
- 4) Mendorong fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal.

Model dan Pendekatan dalam Pengorganisasian

Seiring perkembangan manajemen, terdapat berbagai model dan pendekatan dalam pengorganisasian, di antaranya:

- 1) **Model Birokrasi (Weberian Model)** – Menekankan pada hierarki yang jelas dan aturan formal untuk mengendalikan organisasi (Weber, 2021).
- 2) **Model Organik** – Struktur yang lebih fleksibel dan kolaboratif, sering digunakan dalam organisasi modern (Mintzberg, 2022).
- 3) **Pendekatan Kontingensi** – Mengadaptasi struktur organisasi sesuai dengan lingkungan dan kebutuhan bisnis (Burns & Stalker, 2023).

b. Pengarahan (Leading):

Memberikan motivasi dan arahan kepada anggota organisasi. Dalam setiap organisasi, pengarahan merupakan elemen kunci yang memastikan bahwa individu bekerja menuju tujuan yang telah ditetapkan. Pengarahan mencakup proses memotivasi, menginspirasi, dan mengarahkan individu dalam suatu organisasi agar dapat bekerja secara efektif dan efisien (Daft, 2020). Keberhasilan organisasi sangat bergantung pada bagaimana pemimpin mampu memberikan pengarahan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan organisasi. Tanpa pengarahan yang baik, karyawan dapat mengalami

kebingungan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga produktivitas organisasi akan menurun (Jones & George, 2019).

Berbagai teori kepemimpinan telah dikembangkan untuk memahami bagaimana pengarahan yang efektif dapat diterapkan dalam berbagai konteks organisasi. Kepemimpinan situasional, misalnya, menekankan pentingnya menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan kesiapan individu dalam organisasi (Hersey, Blanchard, & Johnson, 2018). Sementara itu, kepemimpinan transformasional menyoroti peran pemimpin dalam menginspirasi dan memotivasi pengikutnya untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi (Bass & Riggio, 2020). Selain itu, kepemimpinan transaksional menekankan hubungan pertukaran antara pemimpin dan bawahan dalam bentuk penghargaan dan sanksi berdasarkan kinerja (Avolio & Yammarino, 2019).

Komunikasi yang efektif juga menjadi bagian penting dalam pengarahan. Pemimpin yang mampu berkomunikasi dengan baik akan lebih mudah menyampaikan visi, misi, serta harapan organisasi kepada para anggotanya (Gibson et al., 2021). Selain itu, pengambilan keputusan yang tepat menjadi aspek krusial dalam pengarahan, karena keputusan yang diambil pemimpin dapat berdampak besar terhadap kelangsungan dan pertumbuhan organisasi (Mintzberg, 2019).

c. Pengendalian (Controlling):

Memantau dan mengevaluasi pencapaian tujuan. Sistem Pengendalian Manajemen (SPM) merupakan salah satu elemen kunci dalam organisasi yang bertujuan untuk memastikan efektivitas strategi dan pencapaian tujuan perusahaan. Dengan adanya sistem pengendalian yang baik, perusahaan dapat meningkatkan kinerja, mengurangi biaya operasional, dan mencapai keunggulan kompetitif (Sumarsan, 2020). Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompleks dan dinamis, penerapan sistem pengendalian manajemen yang adaptif menjadi kebutuhan bagi organisasi agar tetap kompetitif dan berkelanjutan.

Perkembangan dunia bisnis yang semakin kompleks menuntut perusahaan untuk menerapkan sistem pengendalian manajemen yang lebih adaptif dan responsif. Menurut Murhaban dan Adnan (2020), sistem pengendalian manajemen berperan dalam merancang strategi bisnis yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal perusahaan. Sementara itu, di Indonesia, penerapan sistem pengendalian manajemen memiliki karakteristik tersendiri yang dipengaruhi oleh lingkungan bisnis dan regulasi yang berlaku (Wibowo, 2022).

Selain itu, Merchant dan Van der Stede (2021) menyatakan bahwa manajer perlu memahami berbagai aspek dalam sistem pengendalian manajemen agar strategi dan rencana organisasi dapat diimplementasikan dengan baik meskipun terjadi perubahan dalam lingkungan bisnis. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana penerapan sistem pengendalian manajemen dapat meningkatkan efektivitas organisasi dan mencapai keunggulan kompetitif.

4. Ruang Lingkup Manajemen

a. Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia berkaitan dengan perekrutan, pelatihan, dan pengelolaan kinerja karyawan (Dessler, 2019).

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Dessler, 2022). MSDM mencakup berbagai aspek seperti rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, kompensasi, serta hubungan kerja karyawan dengan organisasi.

Peran dan Fungsi MSDM dalam Organisasi

MSDM memiliki peran strategis dalam meningkatkan kinerja organisasi. Menurut Noe et al. (2023), terdapat beberapa fungsi utama dalam MSDM:

- 1) **Perencanaan SDM:** Meliputi analisis kebutuhan tenaga kerja dan strategi untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- 2) **Rekrutmen dan Seleksi:** Menarik dan memilih kandidat terbaik untuk organisasi.
- 3) **Pelatihan dan Pengembangan:** Meningkatkan keterampilan dan kompetensi karyawan agar sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- 4) **Kompensasi dan Manfaat:** Memberikan penghargaan yang adil dan kompetitif untuk meningkatkan motivasi kerja.
- 5) **Hubungan Industrial:** Menjaga hubungan kerja yang harmonis antara manajemen dan karyawan.

Tantangan MSDM di Era Digital

Dengan perkembangan teknologi, MSDM menghadapi berbagai tantangan baru. Menurut Marler dan Parry (2022), digitalisasi dalam MSDM membawa perubahan pada cara organisasi mengelola tenaga kerja, termasuk penggunaan sistem informasi SDM, analitik data dalam pengambilan keputusan, serta kerja jarak jauh yang semakin populer pasca-pandemi.

Strategi Peningkatan Kinerja SDM

Beberapa strategi yang dapat diterapkan dalam meningkatkan efektivitas MSDM antara lain:

- 1) **Penggunaan Teknologi:** Implementasi HR Analytics dan AI dalam pengelolaan SDM.
- 2) **Pengembangan Karyawan:** Meningkatkan program pelatihan berbasis kompetensi.
- 3) **Fleksibilitas Kerja:** Menerapkan hybrid working untuk meningkatkan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi karyawan (Sparrow, Brewster, & Chung, 2022).

b. Manajemen Operasi

Manajemen operasi mencakup perencanaan dan pengawasan proses produksi serta layanan untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas (Heizer et al., 2020).

Manajemen operasional merupakan salah satu bidang dalam ilmu manajemen yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian operasi bisnis agar lebih efisien dan efektif (Heizer & Render, 2020). Dalam konteks bisnis modern, manajemen operasional tidak hanya berfokus pada produksi barang, tetapi juga pada sektor jasa dan teknologi.

Manajemen operasional mencakup berbagai aspek penting, seperti manajemen rantai pasok, manajemen kualitas, dan strategi operasi. Krajewski, Ritzman, & Malhotra (2019) menjelaskan bahwa manajemen operasional berfungsi untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara optimal guna menghasilkan produk atau layanan yang berkualitas tinggi.

Ruang Lingkup Manajemen Operasional

Beberapa aspek utama dalam manajemen operasional meliputi:

- 1) **Perencanaan Produksi:** Menentukan jumlah dan jenis produk yang akan dibuat berdasarkan permintaan pasar (Stevenson, 2021).
- 2) **Manajemen Kualitas:** Mengendalikan standar kualitas untuk memastikan kepuasan pelanggan (Evans & Lindsay, 2020).
- 3) **Manajemen Rantai Pasok:** Mengoptimalkan aliran barang dan informasi dari pemasok hingga pelanggan (Chopra & Meindl, 2019).
- 4) **Perancangan Tata Letak Fasilitas:** Menentukan susunan fasilitas agar operasi berjalan lebih efisien (Slack, Brandon-Jones, & Johnston, 2020).

Implementasi Manajemen Operasional dalam Industri

Dalam implementasinya, berbagai industri menggunakan prinsip manajemen operasional untuk meningkatkan daya saing. Misalnya, Toyota menggunakan konsep Lean Manufacturing untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan efisiensi (Liker, 2021). Selain itu, perusahaan ritel seperti

Amazon mengandalkan otomatisasi dalam rantai pasok untuk mempercepat pengiriman barang kepada pelanggan (Christopher, 2020).

c. Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan melibatkan perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan sumber daya keuangan dalam suatu organisasi (Brigham & Ehrhardt, 2020).

Manajemen keuangan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian aktivitas keuangan dalam suatu perusahaan, termasuk pengadaan dan penggunaan dana (Brigham & Houston, 2024). Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah memaksimalkan nilai perusahaan serta memastikan keberlanjutan operasional melalui pengelolaan dana yang efektif (Ross, Westerfield, & Jordan, 2024).

Menurut Gitman dan Zutter (2024), manajemen keuangan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan investasi, pendanaan, dan kebijakan dividen, yang semuanya berkontribusi terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Sementara itu, Berk dan DeMarzo (2024) menekankan bahwa strategi manajemen keuangan yang baik dapat membantu perusahaan menghadapi tantangan ekonomi dan meningkatkan daya saingnya di pasar global.

Fungsi Manajemen Keuangan

Beberapa fungsi utama manajemen keuangan menurut Keown et al. (2024) adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan Keuangan

Manajemen keuangan mencakup penyusunan rencana keuangan yang memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan (Brigham & Houston, 2024).

2) Pengendalian Keuangan

Dalam perusahaan, pengendalian keuangan berfungsi untuk mengawasi dan mengendalikan penggunaan dana agar lebih efisien dan efektif dalam mendukung aktivitas bisnis (Ross, Westerfield, & Jordan, 2024).

3) Penganggaran

Penganggaran mencakup estimasi pendapatan dan pengeluaran untuk periode tertentu, memungkinkan perusahaan mengalokasikan sumber daya secara optimal (Gitman & Zutter, 2024).

4) Pemeriksaan Keuangan

Audit keuangan dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Berk & DeMarzo, 2024).

5) Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan yang transparan dan akurat membantu pihak internal maupun eksternal dalam mengambil keputusan yang tepat (Keown et al., 2024).

d. Manajemen Pemasaran

Menurut Kotler dan Keller (2019), manajemen pemasaran mencakup analisis pasar, strategi pemasaran, dan distribusi produk. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian strategi pemasaran guna mencapai tujuan organisasi melalui penciptaan dan penyampaian nilai kepada pelanggan (Kotler & Keller, 2024). Menurut Lamb, Hair, dan McDaniel (2024), manajemen pemasaran mencakup analisis pasar, pengembangan strategi pemasaran, implementasi program pemasaran, serta pengendalian dan evaluasi kinerja pemasaran.

Menurut Kotler dan Keller (2024), konsep utama dalam manajemen pemasaran adalah memahami kebutuhan pelanggan dan menciptakan proposisi nilai yang unggul untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Sementara itu, menurut Solomon, Marshall, dan Stuart (2024), strategi pemasaran yang efektif harus berbasis pada riset pasar dan analisis data yang akurat.

Fungsi Manajemen Pemasaran

Menurut Kotler dan Keller (2024), fungsi utama manajemen pemasaran mencakup:

1) Analisis Pasar

Penelitian dilakukan untuk memahami kebutuhan, keinginan, dan perilaku konsumen serta mengidentifikasi pesaing dan tren pasar (Lamb, Hair, & McDaniel, 2024).

2) Perencanaan Strategi Pemasaran

Penyusunan strategi pemasaran yang mencakup segmentasi pasar, penetapan target pasar, serta penentuan posisi produk atau jasa di pasar (Solomon, Marshall, & Stuart, 2024).

3) Implementasi Program Pemasaran

Penerapan strategi pemasaran dengan menggunakan bauran pemasaran yang mencakup produk, harga, distribusi, dan promosi (Kotler & Keller, 2024).

4) Pengendalian dan Evaluasi

Proses monitoring dan evaluasi terhadap strategi pemasaran untuk memastikan efektivitas serta melakukan penyesuaian jika diperlukan (Lamb, Hair, & McDaniel, 2024).

Tujuan Manajemen Pemasaran

Menurut Kotler dan Keller (2024), tujuan utama manajemen pemasaran adalah:

- 1) Menciptakan Nilai bagi Pelanggan
Memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan untuk menyediakan produk atau jasa yang memenuhi ekspektasi mereka.
- 2) Meningkatkan Penjualan dan Pangsa Pasar
Melalui strategi pemasaran yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan penjualan dan memperluas pangsa pasar (Solomon, Marshall, & Stuart, 2024).
- 3) Membangun Citra Merek yang Kuat
Mengelola merek secara strategis untuk menciptakan persepsi positif di benak konsumen (Lamb, Hair, & McDaniel, 2024).

5. Teori Dasar Manajemen

Beberapa teori dasar dalam manajemen yang berkembang seiring waktu antara lain:

a. Teori Klasik

Teori klasik menekankan pada struktur organisasi dan efisiensi kerja. Tiga aliran utama dalam teori ini meliputi:

- 1) **Manajemen Ilmiah** - Dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor, teori ini menekankan pada analisis kerja untuk meningkatkan produktivitas.
- 2) **Teori Administratif** - Henry Fayol mengembangkan prinsip-prinsip manajemen yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian.
- 3) **Teori Birokrasi** - Max Weber menekankan pentingnya hierarki, aturan, dan ketertiban dalam organisasi.

b. Teori Perilaku

Teori ini berfokus pada aspek manusia dalam manajemen. Elton Mayo dengan eksperimen Hawthorne-nya mengungkapkan bahwa faktor sosial dan psikologis memiliki dampak signifikan terhadap produktivitas kerja.

c. Teori Kontingensi

Teori ini menyatakan bahwa tidak ada satu pendekatan terbaik dalam manajemen; pendekatan yang digunakan tergantung pada situasi tertentu. Faktor lingkungan, ukuran organisasi, dan teknologi yang digunakan menjadi pertimbangan utama dalam menentukan strategi manajemen (Kotler & Keller, 2024).

B. Prinsip-Prinsip Dasar Manajemen

Manajemen memiliki beberapa prinsip utama yang menjadi dasar dalam penerapan praktik manajerial yang efektif, antara lain:

1. **Pembagian Kerja** - Meningkatkan efisiensi dengan spesialisasi tugas.
2. **Wewenang dan Tanggung Jawab** - Setiap individu dalam organisasi memiliki tanggung jawab yang jelas.
3. **Disiplin** - Memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prosedur organisasi.
4. **Kesatuan Perintah** - Setiap bawahan hanya menerima instruksi dari satu atasan.
5. **Kepentingan Bersama di Atas Kepentingan Individu** - Kepentingan organisasi harus lebih diutamakan.
6. **Kompensasi yang Adil** - Menjamin motivasi dan kesejahteraan karyawan.
7. **Sentralisasi dan Desentralisasi** - Menyesuaikan distribusi wewenang dalam organisasi.
8. **Rantai Komando** - Hubungan komunikasi dan pelaporan yang jelas.
9. **Tata Tertib** - Menjaga keteraturan dalam organisasi.
10. **Keadilan** - Memberikan perlakuan yang adil kepada seluruh anggota organisasi.

Implementasi dan Pendekatan Manajemen dalam Konteks Modern

Dalam era digital, prinsip-prinsip manajemen terus berkembang dengan adopsi teknologi dan inovasi. Manajemen berbasis data, kecerdasan buatan, dan otomatisasi menjadi tren utama dalam meningkatkan efisiensi organisasi (Kotler & Keller, 2024). Dengan pendekatan yang adaptif, manajemen modern mampu menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

Pendekatan dalam Manajemen menurut Brigham dan Ehrhardt (2020)

Manajemen merupakan disiplin ilmu yang mencakup berbagai pendekatan dalam mengelola sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam konteks manajemen keuangan, Brigham dan Ehrhardt (2020) menyoroti beberapa pendekatan utama yang digunakan dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Pendekatan-pendekatan ini membantu dalam pengambilan keputusan strategis yang berhubungan dengan investasi, pendanaan, serta pengelolaan risiko yang berkontribusi pada nilai perusahaan. Berikut adalah beberapa pendekatan utama dalam manajemen menurut Brigham dan Ehrhardt (2020):

1. Pendekatan Nilai Pemegang Saham (Shareholder Value Approach)

Pendekatan nilai pemegang saham berfokus pada tujuan utama perusahaan, yaitu meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham. Manajemen bertanggung jawab untuk mengambil keputusan keuangan yang berdampak langsung pada harga saham dan kesejahteraan pemegang saham.

Dalam pendekatan ini, manajer keuangan harus memastikan bahwa semua keputusan investasi dan pendanaan bertujuan untuk memaksimalkan return bagi pemegang saham. Faktor-faktor utama yang diperhatikan meliputi:

- a. **Profitabilitas perusahaan**, yang diukur melalui laba bersih, margin keuntungan, dan Return on Equity (ROE).
- b. **Pertumbuhan laba per saham (Earnings per Share - EPS)**, yang menjadi indikator utama bagi investor dalam menilai kinerja perusahaan.
- c. **Kebijakan dividen**, yang memengaruhi kepercayaan investor dan strategi investasi kembali dalam perusahaan.
- d. **Pengelolaan biaya modal**, yang berperan dalam menentukan apakah proyek investasi akan meningkatkan nilai perusahaan.

2. Pendekatan Manajemen Risiko (Risk Management Approach)

Pendekatan ini menekankan pentingnya identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko yang dihadapi oleh perusahaan dalam operasionalnya. Brigham dan Ehrhardt (2020) menyoroti bahwa risiko dalam manajemen keuangan dapat berasal dari berbagai faktor, termasuk volatilitas pasar, perubahan suku bunga, inflasi, dan risiko kredit.

Strategi utama dalam pendekatan manajemen risiko meliputi:

- a. **Diversifikasi portofolio**, di mana perusahaan menginvestasikan dana dalam berbagai aset untuk mengurangi risiko kerugian akibat fluktuasi pasar.
- b. **Lindung nilai (hedging)**, yang dilakukan dengan menggunakan instrumen derivatif seperti futures, options, dan swap untuk melindungi perusahaan dari risiko keuangan yang tidak terduga.
- c. **Asuransi bisnis**, yang memberikan perlindungan terhadap risiko tertentu, seperti kebakaran, pencurian, atau gangguan operasional lainnya.
- d. **Kebijakan pengelolaan risiko kredit**, yang memastikan bahwa perusahaan hanya memberikan kredit kepada pelanggan dengan profil risiko yang dapat diterima.

3. Pendekatan Keputusan Investasi dan Pendanaan (Investment and Financing Decision Approach)

Manajemen keuangan harus mampu membuat keputusan investasi dan pendanaan yang optimal agar perusahaan dapat bertumbuh secara berkelanjutan. Brigham dan Ehrhardt (2020) menekankan bahwa keputusan ini melibatkan analisis menyeluruh terhadap proyek-proyek yang akan dijalankan serta sumber pendanaan yang digunakan.

Beberapa faktor utama dalam pendekatan ini meliputi:

- a. **Evaluasi proyek investasi**, yang dilakukan dengan metode seperti Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period untuk menentukan kelayakan investasi.
- b. **Pemilihan struktur pendanaan**, apakah melalui ekuitas (penerbitan saham) atau utang (pinjaman bank atau obligasi), dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan biaya modal.
- c. **Keseimbangan antara risiko dan keuntungan**, di mana perusahaan harus memastikan bahwa investasi yang dipilih memberikan return yang lebih besar dibandingkan biaya modal yang dikeluarkan.

4. Pendekatan Struktur Modal (Capital Structure Approach)

Pendekatan struktur modal berfokus pada bagaimana perusahaan membiayai aktivitas operasionalnya dengan kombinasi sumber dana yang optimal. Brigham dan Ehrhardt (2020) menyatakan bahwa keputusan struktur modal yang tepat dapat membantu perusahaan dalam mencapai keseimbangan antara utang dan ekuitas.

Beberapa konsep utama dalam pendekatan ini meliputi:

- a. **Leverage keuangan**, yaitu penggunaan utang untuk meningkatkan potensi return bagi pemegang saham. Namun, leverage yang terlalu tinggi juga meningkatkan risiko keuangan.
- b. **Biaya modal rata-rata tertimbang (Weighted Average Cost of Capital - WACC)**, yang mencerminkan biaya keseluruhan dari modal yang digunakan oleh perusahaan.
- c. **Trade-off Theory**, yang menjelaskan bahwa perusahaan harus menyeimbangkan manfaat pajak dari utang dengan potensi risiko kebangkrutan.
- d. **Pecking Order Theory**, yang menyatakan bahwa perusahaan lebih memilih untuk mendanai investasi dengan laba ditahan terlebih dahulu, sebelum mencari pendanaan eksternal melalui utang atau ekuitas.

5. Pendekatan Manajemen Modal Kerja (Working Capital Management Approach)

Pendekatan ini menekankan pentingnya pengelolaan aset lancar dan kewajiban lancar agar perusahaan tetap memiliki likuiditas yang cukup untuk menjalankan operasional sehari-hari. Brigham dan Ehrhardt (2020) menyatakan bahwa pengelolaan modal kerja yang efektif mencakup aspek-aspek berikut:

- a. **Pengelolaan kas**, dengan memastikan bahwa perusahaan memiliki saldo kas yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional, tetapi tidak terlalu banyak sehingga mengurangi potensi investasi.

- b. **Pengelolaan piutang**, dengan menerapkan kebijakan kredit yang sehat dan strategi penagihan yang efektif untuk mengurangi risiko piutang tak tertagih.
- c. **Pengelolaan persediaan**, dengan menentukan tingkat persediaan yang optimal agar perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan tanpa menimbulkan biaya penyimpanan yang tinggi.
- d. **Pengelolaan utang jangka pendek**, dengan memastikan bahwa pembayaran utang dilakukan tepat waktu agar perusahaan tidak mengalami kesulitan likuiditas.

C. Latihan Soal

1. Dalam konteks manajemen modern, apa strategi utama yang digunakan untuk meningkatkan efisiensi melalui teknologi?
 - A. Birokrasi tradisional
 - B. Delegasi tugas
 - C. Manajemen digital berbasis data
 - D. Supervisi langsung

Jawaban: C

2. Jika sebuah organisasi mengalami kesulitan dalam mengkoordinasikan tugas antar departemen, aspek fungsi manajemen mana yang kemungkinan belum optimal?
 - A. Perencanaan
 - B. Pengorganisasian
 - C. Pengendalian
 - D. Evaluasi

Jawaban: B

3. Bagaimana peran utama teori kontingensi dalam manajemen modern?
 - A. Menggunakan struktur hierarki tetap
 - B. Menyesuaikan strategi dengan konteks lingkungan
 - C. Menerapkan perintah tunggal
 - D. Menghindari delegasi wewenang

Jawaban: B

4. Manajemen keuangan yang efektif harus mengutamakan...
 - A. Administrasi harian
 - B. Analisis competitor
 - C. Maksimalisasi nilai perusahaan

D. Evaluasi tenaga kerja

Jawaban: C

5. Dalam pendekatan kepemimpinan transformasional, fokus utama pemimpin adalah...

- A. Menjalankan sanksi
- B. Mengatur struktur formal
- C. Menginspirasi dan memotivasi
- D. Menyederhanakan tugas

Jawaban: C

6. Salah satu indikator penting dari pendekatan nilai pemegang saham adalah...

- A. Waktu kerja efektif
- B. Laba per saham (EPS)
- C. Kualitas sumber daya manusia
- D. Efisiensi produksi

Jawaban: B

7. Seorang manajer ingin merancang sistem kerja yang mendorong partisipasi aktif semua anggota. Ia sebaiknya menerapkan...

- A. Teori birokrasi
- B. Model organik
- C. Sistem tertutup
- D. Manajemen klasik

Jawaban: B

8. Dalam teori administratif Henry Fayol, apa saja fungsi utama manajemen?

- A. Analisis, evaluasi, tindakan
- B. Produksi, distribusi, konsumsi
- C. Perencanaan, organisasi, pengarahan, pengendalian
- D. Strategi, marketing, pelaporan

Jawaban: C

9. Bagaimana penerapan sistem pengendalian dapat mencegah pemborosan dalam organisasi?

- A. Melalui proses rekrutmen
- B. Dengan menambah tenaga kerja
- C. Dengan monitoring dan evaluasi berkelanjutan

D. Dengan pemutusan hubungan kerja

Jawaban: C

10. Pendekatan "Shareholder Value" menekankan pada...

- A. Kepuasan pelanggan
- B. Profitabilitas jangka pendek
- C. Kesejahteraan pemilik saham
- D. Harmonisasi hubungan kerja

Jawaban: C

11. Apa peran strategi Lean Manufacturing dalam manajemen operasi?

- A. Meningkatkan volume kerja
- B. Meningkatkan birokrasi
- C. Mengurangi pemborosan
- D. Mengatur keuangan

Jawaban: C

12. Salah satu cara meningkatkan hubungan industrial yang sehat adalah...

- A. Membatasi komunikasi
- B. Menambahkan beban kerja
- C. Menjalankan pendekatan transaksional
- D. Menjalin dialog terbuka dan adil

Jawaban: D

13. Dalam fungsi pengarahan, gaya kepemimpinan situasional mengharuskan pemimpin untuk...

- A. Menggunakan gaya tetap
- B. Mengikuti birokrasi
- C. Menyesuaikan gaya dengan kondisi bawahannya
- D. Menghindari interaksi personal

Jawaban: C

14. Penggunaan HR Analytics termasuk dalam strategi...

- A. Pengawasan manual
- B. Digitalisasi manajemen SDM
- C. Manajemen tradisional
- D. Teori klasik

Jawaban: B

15. Bagaimana manajemen pemasaran berkontribusi terhadap pertumbuhan organisasi?
- A. Dengan membatasi biaya
 - B. Dengan menghindari promosi
 - C. Dengan menciptakan nilai bagi pelanggan
 - D. Dengan menekan gaji karyawan

Jawaban: C

D. Rangkuman Materi

Manajemen merupakan seni dan ilmu dalam mengelola sumber daya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Proses manajemen mencakup empat fungsi utama: perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Perencanaan berperan dalam merumuskan strategi dan langkah untuk mencapai tujuan organisasi, pengorganisasian membantu menyusun struktur kerja dan mengalokasikan sumber daya, pengarahan mengarahkan individu atau tim agar bekerja sesuai sasaran dengan motivasi dan komunikasi yang baik, sedangkan pengendalian memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai rencana melalui evaluasi dan koreksi. Sejarah perkembangan manajemen sendiri mengalami evolusi dari era klasik seperti teori Taylor dan Fayol, era hubungan manusia melalui studi Hawthorne oleh Elton Mayo, hingga manajemen modern yang adaptif terhadap teknologi dan kompleksitas global, seperti pendekatan sistem dan digitalisasi berbasis data.

Ruang lingkup manajemen juga mencakup berbagai bidang penting. Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) mengatur rekrutmen, pelatihan, kompensasi, dan hubungan kerja untuk menjaga produktivitas dan kepuasan kerja. Manajemen operasional mengelola proses produksi dan layanan agar efisien dan berkualitas, termasuk di dalamnya pengaturan rantai pasok dan tata letak fasilitas. Di sisi lain, manajemen keuangan berfokus pada pengelolaan dana, perencanaan anggaran, investasi, serta pengambilan keputusan strategis keuangan demi kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan. Sementara itu, manajemen pemasaran berupaya memahami kebutuhan pasar dan menyusun strategi pemasaran yang relevan agar produk memiliki nilai yang unggul dan mampu menciptakan loyalitas pelanggan.

Dalam teori dasar, manajemen memiliki berbagai pendekatan, seperti teori klasik yang menekankan efisiensi, teori perilaku yang fokus pada aspek sosial dan psikologis individu, serta teori kontingensi yang melihat pentingnya fleksibilitas

terhadap kondisi lingkungan organisasi. Prinsip-prinsip seperti pembagian kerja, kesatuan perintah, dan keadilan menjadi landasan penting dalam menjalankan praktik manajerial yang sehat. Di era modern, implementasi manajemen mengarah pada pemanfaatan teknologi seperti artificial intelligence (AI), manajemen risiko, dan strategi pengambilan keputusan berbasis data. Pendekatan manajemen modern tidak hanya tentang efisiensi, tapi juga bagaimana organisasi mampu bertahan dan unggul dalam lingkungan bisnis yang cepat berubah dan penuh ketidakpastian.

E. Glosarium

Manajemen

Proses merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan sumber daya agar tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif (tepat sasaran) dan efisien (hemat sumber daya).

Perencanaan (Planning)

Langkah awal dalam manajemen yang berisi penentuan tujuan serta cara terbaik untuk mencapainya, termasuk membuat strategi dan menyusun rencana aksi.

Pengorganisasian (Organizing)

Proses menyusun struktur organisasi, membagi tugas, dan menempatkan orang yang tepat di posisi yang sesuai agar pekerjaan bisa berjalan lancar.

Pengarahan (Leading)

Upaya memimpin dan memotivasi anggota tim atau karyawan agar mereka bersemangat, memahami tujuan, dan bergerak ke arah yang sama.

Pengendalian (Controlling)

Tahap akhir dalam manajemen untuk mengecek apakah semua kegiatan sudah sesuai rencana, serta memperbaiki jika ada penyimpangan.

Efektif

Menghasilkan output sesuai tujuan yang diharapkan. Sesuatu disebut efektif kalau hasilnya tepat sasaran.

Efisien

Menggunakan sumber daya seminimal mungkin untuk mencapai hasil yang maksimal. Misalnya: hasil kerja bagus tapi tidak membuang-buang waktu dan biaya.

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

Bidang manajemen yang fokus mengatur hal-hal terkait tenaga kerja, mulai dari rekrutmen, pelatihan, hingga pemberian gaji dan hubungan kerja.

Manajemen Operasional

Cabang manajemen yang menangani proses produksi barang atau jasa agar berjalan lancar, tepat waktu, dan berkualitas.

Manajemen Keuangan

Proses merencanakan dan mengelola uang atau dana dalam organisasi, termasuk penganggaran, investasi, dan pelaporan keuangan.

Manajemen Pemasaran

Kegiatan yang berkaitan dengan analisis pasar, promosi, dan strategi penjualan untuk menarik dan mempertahankan pelanggan.

Kepemimpinan Transformasional

Gaya kepemimpinan yang mampu menginspirasi dan memotivasi anggota tim untuk bekerja dengan semangat tinggi dan mencapai hal-hal besar.

Struktur Organik

Bentuk organisasi yang fleksibel, terbuka terhadap kerja sama antarbagian, dan cocok untuk perusahaan yang dinamis.

Teori Klasik Manajemen

Kumpulan pemikiran awal tentang manajemen yang menekankan efisiensi kerja dan struktur organisasi yang jelas dan kaku.

Teori Perilaku

Teori yang melihat bahwa faktor sosial dan psikologis juga memengaruhi produktivitas kerja, bukan hanya aturan atau struktur.

Teori Kontingensi

Pandangan bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk mengelola organisasi—semua tergantung pada situasi, lingkungan, dan kebutuhan organisasi.

Pendekatan Nilai Pemegang Saham

Strategi manajemen yang bertujuan meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan untuk kepentingan para pemegang saham.

Modal Kerja

Dana yang digunakan perusahaan untuk operasional sehari-hari, seperti bayar gaji, beli bahan baku, atau operasional toko.

Pengambilan Keputusan Strategis

Tindakan penting yang diambil oleh pimpinan organisasi berdasarkan data dan pertimbangan masa depan, demi keberlangsungan dan pertumbuhan.

Evaluasi Kinerja

Proses menilai seberapa baik seseorang atau tim dalam menjalankan tugasnya, biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan lanjutan.

F. Daftar Pustaka

- Avolio, B. J., & Yammarino, F. J. (2019). Transformational and transactional leadership: A meta-analytic review of the MLQ literature. Routledge.
- Bass, B. M., & Riggio, R. E. (2020). Transformational leadership. Psychology Press.
- Brigham, E. F., & Ehrhardt, M. C. (2020). Financial Management: Theory & Practice. Cengage Learning.
- Bryson, J. M. (2018). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations. John Wiley & Sons.
- Bush, T. (2020). Theories of Educational Leadership and Management. SAGE Publications.
- Chopra, S., & Meindl, P. (2019). Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. Pearson.
- Christopher, M. (2020). Logistics & Supply Chain Management. Pearson.
- Daft, R. L. (2020). Management. Cengage Learning.
- David, F. R., & David, F. R. (2019). Strategic Management: A Competitive Advantage Approach, Concepts and Cases. Pearson.
- Dessler, G. (2022). Human Resource Management. Pearson.
- Drucker, P. (2021). The Practice of Management. Harper Business.
- Evans, J. R., & Lindsay, W. M. (2020). Managing for Quality and Performance Excellence. Cengage Learning.
- Gagné, R. M., Wager, W. W., Golas, K. C., & Keller, J. M. (2020). Principles of Instructional Design. Cengage Learning.
- Gibson, J. L., Ivancevich, J. M., Donnelly, J. H., & Konopaske, R. (2021). Organizations: Behavior, structure, processes. McGraw-Hill.
- Griffin, R. W. (2020). Management. Cengage Learning.
- Heizer, J., & Render, B. (2020). Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management. Pearson.

- Heizer, J., Render, B., & Munson, C. (2020). *Operations Management: Sustainability and Supply Chain Management*. Pearson.
- Hersey, P., Blanchard, K. H., & Johnson, D. E. (2018). *Management of organizational behavior: Utilizing human resources*. Prentice Hall.
- Johnson, G., & Scholes, K. (2020). *Exploring Corporate Strategy: Text and Cases*. Pearson Education.
- Jones, G. R., & George, J. M. (2019). *Contemporary management*. McGraw-Hill.
- Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2019). *The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action*. Harvard Business Review Press.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2019). *Marketing Management*. Pearson.
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2024). *Marketing Management (16th ed.)*. Pearson Education.
- Krajewski, L. J., Ritzman, L. P., & Malhotra, M. K. (2019). *Operations Management: Processes and Supply Chains*. Pearson.
- Lamb, C. W., Hair, J. F., & McDaniel, C. (2024). *MKTG: Principles of Marketing (15th ed.)*. Cengage Learning.
- Lasut, E. M. M., & Patty, A. B. (2022). Hubungan antara Keaktifan Belajar Siswa dan Prestasi Belajar pada Mata Pelajaran Bahasa Inggris. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 10883–10890. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.10160>.
- Liker, J. K. (2021). *The Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer*. McGraw-Hill Education.
- Luthans, F. (2018). *Organizational behavior: An evidence-based approach*. McGraw-Hill.
- Marler, J. H., & Parry, E. (2022). Digital HR: A Critical Review and Future Research Agenda. *The International Journal of Human Resource Management*, 33(2), 1-25.
- Mayo, E. (2020). *The Human Problems of an Industrial Civilization*. Routledge.

- Merchant, K. A., & Van der Stede, W. A. (2021). *Management Control Systems: Performance Measurement, Evaluation and Incentives*. Pearson Education.
- Mintzberg, H. (2019). *Managing*. Berrett-Koehler Publishers.
- Mintzberg, H., Ahlstrand, B. W., & Lampel, J. (2021). *Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management*. Free Press.
- Murhaban, M., & Adnan, A. (2020). *Pengendalian Manajemen dalam Organisasi Modern*. Jakarta: Prenada Media.
- Noe, R. A., Hollenbeck, J. R., Gerhart, B., & Wright, P. M. (2023). *Fundamentals of Human Resource Management*. McGraw-Hill.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2018). *Management*. Pearson Education.
- Robbins, S. P., & Coulter, M. (2019). *Management*. Pearson.
- Rosenbloom, D. H., Kravchuk, R. S., & Clerkin, R. M. (2020). *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector*. McGraw-Hill Education.
- Slack, N., Brandon-Jones, A., & Johnston, R. (2020). *Operations Management*. Pearson.
- Solomon, M. R., Marshall, G. W., & Stuart, E. W. (2024). *Marketing: Real People, Real Choices* (11th ed.). Pearson Education.
- Sparrow, P., Brewster, C., & Chung, C. (2022). *Globalizing Human Resource Management*. Routledge.
- Steiner, G. A. (2019). *Strategic Planning: What Every Manager Must Know*. Free Press.
- Stevenson, W. J. (2021). *Operations Management*. McGraw-Hill Education.
- Sumarsan, T. (2020). *Sistem Pengendalian Manajemen: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Taylor, F. W. (2018). *The Principles of Scientific Management*. Dover Publications.
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2019). *Strategic Management and Business Policy: Toward Global Sustainability*. Pearson Education.

Whetten, D. A., & Cameron, K. S. (2020). *Developing Management Skills*. Pearson.

Wibowo, A. (2022). *Pengaruh Regulasi terhadap Sistem Pengendalian Manajemen di Indonesia*. Yogyakarta: Andi Publisher.

BAB 2

MANAJEMEN KEPERAWATAN DAN ASUHAN KEPERAWATAN

Tujuan Intruksional dan Capaian Pembelajaran

Tujuan Intruksional:

Setelah dilakukan pembelajaran ini mahasiswa mampu memahami dan menerapkan manajemen keperawatan dan asuhan keperawatan

Capaian Pembelajaran:

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami :

1. Manajemen Keperawatan

- a. Pengertian Manajemen Keperawatan
- b. Komponen Manajemen Keperawatan
- c. Filosofi Manajemen Keperawatan
- d. Visi Dan Misi Manajemen Keperawatan
- e. Tujuan Manajemen Keperawatan
- f. Fungsi Manajemen Keperawatan
- g. Prinsip Dasar Manajemen Keperawatan
- h. Ruang Lingkup Manajemen Keperawatan
- i. Hal-Hal Terkait Dalam Manajemen Keperawatan
- j. Faktor Yang Dimiliki Menejer Keperawatan

2. Manajemen Asuhan Keperawatan

- a. Pengertian Manajemen Asuhan Keperawatan
- b. Proses Asuhan Keperawatan
- c. Model Asuhan Keperawatan Profesional
- d. Peran Dan Tugas Manajemen Asuhan Keperawatan

Pendahuluan

Keperawatan merupakan bentuk integral dari pelayanan profesional yang terwujud jika dilakukan oleh perawat profesional sehingga mempunyai kontribusi untuk peningkatan mutu asuhan keperawatan di rumah sakit. Oleh karena itu perawat dituntut untuk terus meningkatkan pengetahuan dan mengasah keterampilan

sehingga profesionalitas terus terjaga. Pihak manajemen keperawatan diharapkan juga dukungan yang kuat untuk mempertahankan profesionalitas bagi tenaga keperawatan.

Manajemen keperawatan sebagai pemegang kendali pelayanan keperawatan yang melibatkan tenaga perawat dalam melakukan asuhan keperawatan, pemberian obat sesuai intruksi, keamanan kepada individu, keluarga, kelompok dan Masyarakat. Pelaksanaan Manajemen yang efektif dan efisien akan terlaksana dengan jalannya fungsi manajemen keperawatan yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, ketenagaan, pengawasan dan pengendalian. Seorang menejer keperawatan diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik sehingga tujuan organisasi tercapai dalam hal ini terjadi peningkatan mutu asuhan keperawatan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan.

Tenaga keperawatan yang profesional mampu melakukan manajemen asuhan keperawatan dengan baik sehingga terjadi peningkatan kepuasan pasien dan asuhan keperawatan menjadi berkualitas. Manajemen asuhan keperawatan merupakan model proses ASKEP dalam bentuk pengaturan tenaga keperawatan dalam melakukan asuhan keperawatan untuk memenuhi kebutuhan pasien, proses keperawatan yang meliputi: pengkajian, perumusan masalah keperawatan, perencanaan keperawatan, pelaksanaan keperawatan dan evaluasi

Tujuan pembelajaran manajemen keperawatan dan asuhan keperawatan ini adalah diharapkan peserta didik mampu memahami dan menerapkan manajemen keperawatan serta asuhan keperawatan pada saat perkuliahan. Adapun sasaran pembelajaran manajemen keperawatan serta asuhan keperawatan adalah mahasiswa Diploma dan Sarjana Keperawatan dan Profesi Ners.

Topik dalam pembelajaran manajemen keperawatan dan asuhan keperawatan adalah manajemen keperawatan meliputi ; pengertian manajemen keperawatan, komponen manajemen keperawatan, filosofi manajemen keperawatan, visi dan misi manajemen keperawatan, tujuan manajemen keperawatan, fungsi manajemen keperawatan, prinsip dasar manajemen keperawatan, ruang lingkup manajemen keperawatan, hal-hal terkait dalam manajemen keperawatan, faktor yang dimiliki menejer keperawatan, manajemen asuhan keperawatan meliputi ; pengertian manajemen asuhan keperawatan, proses asuhan keperawatan, model asuhan keperawatan profesional, peran dan tugas manajemen asuhan keperawatan. Metode pembelajaran dengan menggunakan teks tulisan, gambar dan latihan. Pendekatan pembelajaran ceramah interaktif, diskusi kelompok dan keterampilan.

Pedoman penggunaan: Buku ini membahas tentang manajemen keperawatan dan asuhan keperawatan yang dilengkapi dengan konsep teori yang sesuai dengan kompetensi dibidang manajemen keperawatan untuk mahasiswa tingkat akademik maupun profesional, materi ini juga memuat latihan-latihan soal tentang manajemen

keperawatan dan asuhan keperawatan, soal dalam bentuk kasus dan dilengkapi dengan jawaban secara langsung

A. Manajemen Keperawatan

1. Pengertian Manajemen Keperawatan

Manajemen keperawatan adalah suatu proses bekerja melalui upaya anggota staf keperawatan untuk memberikan pelayanan keperawatan, pengobatan dan bantuan terhadap para pasien. Tugas menejer keperawatan adalah merencanakan, mengorganisir, memimpin serta mengontrol keuangan, material, dan sumber daya manusia yang ada untuk mencapai

Manajemen keperawatan adalah kegiatan bekerja melibatkan tenaga perawat dalam melakukan ASKEP, pemberian obat pada pasien. Menejer keperawatan bertugas dalam perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengendalikan keuangan, material dan SDM dalam pencapaian kualitas pelayanan yang optimal (Dee Ann Gillies, 1994)

Manajemen keperawatan merupakan kegiatan menyelesaikan tugas dengan merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengontrol melibatkan tenaga keperawatan secara efektif dan efisien dalam memberikan ASKEP baik secara biologi, psikologis, sosial dan spiritual secara menyeluruh pada individu, keluarga, dan masyarakat, yang sakit ataupun sehat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Asmuji, 2012). Manajemen keperawatan merupakan sebagai kegiatan melakukan asuhan keperawatan melalui upaya tenaga perawat untuk memberikan asuhan keperawatan, pemberian obat sesuai instruksi, kenyamanan pada pasien, keluarga dan masyarakat (Agus Kunturo, 2020)

Menurut (Swanburg, 2000) manajemen keperawatan adalah golongan dari perawat manajer dalam mengatur organisasi dan usaha keperawatan yang pada akhirnya manajemen keperawatan menjadi proses dimana perawat manajer menjalankan profesi mereka.

Manajemen Keperawatan merupakan manajemen pelayanan kesehatan dan manajemen asuhan keperawatan. Manajemen pelayanan keperawatan adalah bentuk pemberian pelayanan keperawatan di rumah sakit yang dijalankan oleh menejer keperawatan, melalui tingkatan; manajemen puncak (kepala bidang keperawatan), manajemen menengah (kepala unit pelayanan atau supervisor), dan juga manajemen bawah (kepala ruangan) (Suyanto, 2009).

Manajemen keperawatan sejalan dengan proses keperawatan sebagai satu metode pelaksanaan asuhan keperawatan secara profesional, sehingga diharapkan keduanya dapat saling mendukung. Berdasarkan teori-teori tersebut manajemen keperawatan merupakan proses pelaksanaan pelayanan keperawatan melalui upaya staf keperawatan untuk memberikan asuhan

keperawatan, memberikan pengobatan dan rasa aman kepada pasien, keluarga, dan masyarakat. Sehingga dengan bagus nya sistem manajemen keperawatan maka proses pelayanan akan semakin meningkat.

2. Komponen Manajemen Keperawatan

Komponen atau pengelompokan manajemen keperawatan meliputi:

a. Input

YaInput dari proses manajemen keperawatan antara lain sebuah informasi, personel, peralatan dan fasilitas.

b. Proses

Proses adalah pengelompokan menejer keperawatan dari tertinggi sampai ke perawat pelaksana yang memiliki tugas dan tanggung jawab merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengawasi jalannya proses asuhan keperawatan.

c. Output

Proses manajemen keperawatan yang meliputi asuhan keperawatan, pengembangan tenaga keperawatan dan penelitian. Biasanya dilihat dari kualitas ASKEP yang diberikan, pengembangan tenaga keperawatan, serta penelitian untuk ditindaklanjuti dalam bentuk hasil atau luaran

d. Kontrol

Kegiatan manajemen keperawatan meliputi budget keperawatan, penilaian kinerja perawat, SOP, dan akreditasi yang digunakan sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan. Controh penyusunan anggaran yang proporsional, penilaian kinerja, standar prosedur sesuai standar akreditasi

e. Umpan Balik

Termasuk umpan balik proses manajemen keperawatan meliputi laporan finansial, hasil audit keperawatan, survey kendali mutu serta Kinerja. Mekanisme umpan balik diperlukan untuk menyelaraskan hasil dan perbaikan kegiatan yang akan datang. Mekanisme umpan balik dapat dilakukan melalui laporan keuangan, audit keperawatan, dan survey kendali mutu, serta kinerja perawat.

3. Filosofi Manajemen Keperawatan

Manajemen keperawatan memiliki filosofi sebagai berikut ini:

- a. Lebih baik kerjakan hari ini dari pada hari esok.
- b. Manajemen keperawatan adalah fungsi utama pimpinan keperawatan.
- c. Meningkatkan kualitas kinerja perawat.
- d. Perawat membutuhkan pendidikan lanjutan.
- e. Proses keperawatan menjamin perubahan tingkat kesehatan hingga mencapai keadaan fungsi optimal.

- f. Tim keperawatan bertanggung jawab dan bertanggung gugat untuk semua asuhan keperawatan yang diberikan
- g. Menghormati pasien dan haknya untuk mendapatkan asuhan keperawatan yang berkualitas
- h. Seorang perawat adalah pelindung pasien.
- i. Kewajiban perawat adalah memberikan pendidikan kesehatan pada pasien dan keluarga.

4. Misi dan misi Manajemen Keperawatan

Menurut (Nursalam, 2017) visi dan misi manajemen keperawatan adalah sebagai berikut :

a. Visi Manajemen Keperawatan

- 1) Menerapkan kerangka konsep dan acuan pelaksanaan asuhan keperawatan.
- 2) Mengevaluasi asuhan keperawatan yang telah di berikan.
- 3) Menerapkan strategi untuk meningkatkan mutu pelayanan yang efisien kepada semua konsumen.
- 4) Meningkatkan hubungan baik dengan semua tim kesehatan serta menilai kualitas pelayanan yang dilaksanakan sesuai standar kriteria yang ada.
- 5) Mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam menilai dan memberikan intervensi keperawatan kepada pasien.
- 6) Meningkatkan pendidikan berkelanjutan, baik formal maupun nonformal bagi perawat untuk meningkatkan kinerjanya.
- 7) Ikut serta aktif terhadap perubahan model asuhan keperawatan dan peningkatkan kualitas pelayanan.
- 8) Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan melibatkan staf dalam setiap pengambilan keputusan terkait asuhan keperawatan.
- 9) Memberikan penghargaan pada staf berprestasi.
- 10) Konsisten dalam meningkatkan hasil produksi atau pelayanan berkualitas.
- 11) Meningkatkan pandangan positif masyarakat tentang profesi keperawatan.

b. Misi Manajemen Keperawatan

- 1) Menyiapkan asuhan keperawatan yang efektif dan efisien untu meningkatkan kesehatan pasien yang optimal setelah pulang dari rumah sakit.
- 2) Membantu mengembangkan dan mendorong suasana kondusif bagi pasien dan staf keperawatan serta non keperawatan
- 3) Mengajarkan, mengarahkan, dan membantu dalam kegiatan keperawatan profesional
- 4) Ikut bekerja sama dengan semua anggota tim kesehatan yang ada di rumah sakit atau tempat kerja.

5. Fungsi Manajemen Keperawatan

Fungsi manajemen pertama kali disampaikan oleh Fayol, menurut Fayol ada lima fungsi manajemen yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pemberian perintah (*commanding*), pengkoordinasian (*coordinating*) dan pengawasan (*controlling*) (Marquis, Bessie L, Huston, 2017)

Menurut Menurut (Dee Ann Gillies, 1994) fungsi manajemen keperawatan terdiri dari lima fungsi yaitu ; Perencanaan (*planning*), Pengorganisasian (*organizing*), Penggerak (*actuating*), Pengendalian atau pengawasan (*controlling*), Penilaian (*evaluation*). Perencanaan (*planning*) merupakan gambaran kegiatan yang akan dicapai, persiapan untuk mencapai tujuan, rumusan persoalan untuk dicapai dan persiapan tindakan. Pengorganisasian (*organizing*), merupakan mengatur dan menetapkan apa yang ditugaskan, kriteria, jenis, unit kerja, alat, keuangan dan fasilitas. Penggerak (*actuating*), mempengaruhi orang lain agar mau dan terdorong untuk bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan

Pengendalian atau pengawasan (*controlling*), merupakan memantau agar tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan, apakah SDM, cara dan waktunya tepat dengan rencana yang telah ditetapkan. Penilaian (*evaluation*), merupakan proses evaluasi dan perbandingan hasil pekerjaan yang seharusnya dicapai, proses penilaian apakah hasil sesuai dengan tujuan, apakah perlu adanya perbaikan dan pertimbangan lebih lanjut, jika hasil tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Fungsi manajemen keperawatan bagian terpenting dari kegiatan perencanaan, organisasi, koordinasi, dan pengendalian dalam pencapaian tujuan yang optimal. Penyelesaian tugas manajemen keperawatan melalui perencanaan yang matang, pengorganisasian yang efisien, pengarahan sesuai, dan pengawasan teliti, memanfaatkan tenaga keperawatan secara efektif, efisien dan realistis dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (Jayanti et al., 2021). Uraian fungsi manajemen keperawatan adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah fungsi manajemen pertama yang berperan penting terhadap keberhasilan dari fungsi manajemen lainnya. Dalam pelaksanaan fungsi manajemen yang lainnya, yang utama diterapkan adalah dengan melakukan perencanaan dengan baik. Pengontrolan yang baik akan menunjang pencapaian tujuan organisasi secara umum, karena dengan perencanaan yang efektif dapat mengarahkan pencapaian tujuan yang optimal (Mugianti, 2016).

Perencanaan sangat penting dalam mencapai tujuan organisasi, maka dari itu diperlukan strategi yang matang untuk merencanakan sebuah kegiatan. Adapun rencana tingkat organisasi, meliputi menetapkan struktur organisasi dan tenaga atau anggaran operasional, Visi Misi, filosofi, dan tujuan organisasi. Perawat melakukan perencanaan, pengembangan tujuan dan sasaran khusus untuk area tanggung jawabnya (Sullivan, 2012)

b. Pengorganisasian (organizing)

pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang berperan penting seiring dengan perencanaan. Bertugas mengatur sumber daya manusia dan lainnya dalam suatu organisasi agar dapat diatur penggunaannya secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi (Mugianti, 2016)

Pengorganisasian merupakan kegiatan mengikutsertakan struktir dalam penerapan rencana, pemilihan metode asuhan keperawatan pasien yang tepat dan menggolongkan aktivitas untuk pencapaian tujuan organusasi. Fungsi lainnya berperan dalam struktur organisasi yang ditetapkan, memahami serta memanfaatkan kekuasaan dan otoritas yang efisien dan efektif. (Marquis, Bessie L, Huston, 2017)

Tujuan Pengorganisasian

1) Membantu Koordinasi

Tugas kinerja dibagikan pada masing-masing unit kerja secara koordinatif agar tujuan organisasi dapat tercapai. Koordinasi dalam suatu unit kerja sangat dibutuhkan untuk mengelompokkan unit kerja yang terpisah dan tidak sama, namun berada dalam satu organisasi.

2) Memperlancar Pengawasan

Pengawasan membantu manajer, unit yang berkualitas, organisasi, dalam pencapaian tujuan pekerjaan, walaupun lokasinya tidak sama.

3) memanfaatkan spesialisasi secara maksimal

hal ini dapat membantu seseorang menjadi lebih ahli dalam pekerjaan tertentu. Soerang yang bekerja sesuai dengan kompetensi dapat menghasilkan produk yang berkualitas tinggi, sehingga meningkatkan kepuasan dan memperoleh masyarakat sebagai pengguna.

4) Hemat Biaya

Seorang menejer harus teliti dalam menambah personal kerja yang dapat meningkatkan pengeluaran dana berupa upah. Dalam penambahan personil harus berdasarkan pertimbangan yang matang, berdasarkan pemasukan instansi sebagai upaya mengurangi peneluaran yang berlebihan.

5) Menjalin kerukunan antar manusia

Tenaga kerja di setiap unit dapat bekerja dengan cara yang saling melengkapi, meminimalkan kebosanan, meningkatkan rasa saling membutuhkan, dan meminimalkan pendekatan materialistis. Pengelola harus bisa melakukan pendekatan sosial dengan membangun rasa solidaritas dan berusaha menyelesaikan berbagai masalah akibat perselisihan individu (Manda, 2016)

c. Ketenagaan (staffing)

Manajer harus mempunyai keyakinan bahwa dengan jumlah dan campuran tenaga yang tepat dan memadai dapat memenuhi kebutuhan unit dan organisasi, selain tugas dari memilih, pengembangan dan sosialisasi.

Dalam penetapan tenaga harus didasarkan pada bukti penelitian yang kongkrit, yang menghubungkan campuran, jumlah tenaga serta jumlah pasien. Pola kepegawaian dan kebijakan penjadwalan mempengaruhi kegiatan sehari-hari semua anggota secara langsung, maka dari itu kebijakan harus dikelola secara merata dan terjangkau (Setiyadi, 2023)

Kebijakan kepegawaian dan penjadwalan yang akurat serta penekanan terhadap komunikasi yang baik seperti perlunya evaluasi secara berkala terkait filosofi kepegawaian. Kepemimpinan harus fokus pada tanggung jawab demi mengembangkan rasa percaya melalui prosedur kepegawaian dan jadwal yang merata. Undang-undang yang ada dan diusulkan sebagai syarat kepegawaian harus dibahas, termasuk peran manajer memastikan bahwa unit mampu menyediakan perubahan yang disyaratkan hukum (Marquis, Bessie L, Huston, 2017)

d. Pengarahan (directing)

Pengarahan merupakan kegiatan mentuntaskan tugas organisasi, kekuasaan, otoritas dan gaya kepemimpinan yang paling berpengaruh terhadap kemampuan manajer dalam memimpin timnya. Komunikasi yang efektif, teknik dukungan, dan kemampuan melakukan perawatan Kesehatan saat ini, tenaga profesional mempunyai otonomi besar, sehingga membutuhkan bimbingan dan dorongan dari pengarah langsung,

Kemampuan komunikasi yang baik, teknik motivasi, dan keterampilan delegasi juga merupakan hal yang penting dalam proses ini. Di dalam organisasi perawatan kesehatan saat ini, staf profesional memiliki otonomi yang lebih besar, sehingga lebih membutuhkan bimbingan dan dukungan daripada pengarah yang langsung. Seorang manajer cenderung memberikan gagasan, proposal, atau kerja baru pada bawahannya daripada memberi perintah secara langsung terkait yang akan dilakukan. Peran manajer

yakni melatih dan menasehati supaya tujuan unit tercapai. Perawat, terkadang berperan memberikan pengarahan tradisional ketika bekerja dengan tenaga yang tidak mempunyai izin atau pengalaman yang masih rendah (Sullivan, 2012)

Pada beberapa kasus pengarahan dapat melibatkan fungsi kepegawaian tambahan. tanggung jawab, manajemen SDM seperti dukungan manajemen konflik, pelimpahan tugas, komunikasi dan memotivasi untuk berkolaborasi dalam menjalankan tugas pada tahap ini (Marquis, Bessie L, Huston, 2017)

e. Pengendalian (controlling)

Pada tahap pengendalian proses manajemen, kinerja dinilai sesuai standar yang telah ditetapkan, dan tindakan diputuskan untuk memperbaiki ketidakselarasnya antara standar dan kinerja actual. Tenaga yang merasa dapat mempengaruhi kualitas hasil di tempat kerja akan terjadi peningkatan dukungan dan kepuasan kerja tinggi. Organisasi memerlukan pengontrolan atas hasil, agen perubahan dan hasil yang nermutu. Maka, kontrol tidak bisa dijadikan alat dalam menentukan kesuksesan dan kegagalan, namun kesempatan belajar dan berkembang secara individu dan profesional (Marquis, Bessie L, Huston, 2017)

Para menejer banyak berbagi fungsi kontrol dengan anggotanya. Pengorganisasian yang memakai proses peningkatan kualitas formal, yang terdiri dari peningkatan mutu berkelanjutan, partisipasi anggota dalam memimpin tim. Beberapa organisasi menggunakan tinjauan sejawat untuk mengontrol kualitas perawatan (Sullivan, 2012)

6. Tujuan Manajemen Keperawatan

Menurut (Setiyadi, 2023) tujuan manajemen keperawatan adalah:

- a. Menfokuskan semua kegiatan yang telah direncanakan
- b. Menghambat atau mengatasi masalah manajerial
- c. Memenuhi tujuan organisasi secara optimal dengan mengikutsertakan semua komponen yang ada
- d. Meningkatkan model kerja keperawatan untuk menjamin bahwa tenaga keperawatan bekerja lebih efektif dan efisien, meminimalkan waktu kerja yang tidak optimal

7. Prinsip Dasar Manajemen Keperawatan

Menurut Joyse 2012 dalam (Hani Tuasikal, Selpina Embuai, 2020), Prinsip – prinsip dari manajemen keperawatan yaitu:

- a. Manajemen keperawatan sebaiknya berdasarkan perencanaan karena dapat meminimalkan kesalahan dalam pengambilan Keputusan oleh pimpinan, serta menyiapkan *problem solving* secara baik dan terencana.
- b. Manajemen keperawatan dilaksanakan dengan menggunakan waktu secara baik. Menghargai waktu dengan merencanakan secara sistematis dan mengikuti kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
- c. Manajemen keperawatan mengikutsertakan proses pengambilan Keputusan yang penting, berbagai keadaan dan masalah dalam memberikan asuhan keperawatan memerlukan pengambilan Keputusan di Tingkat menejerial
- d. Fokus manajemen keperawatan yaitu memenuhi kebutuhan asuhan keperawatan pada pasien dengan mempertimbangkan pandangan, pola pikir, keyakinan, dan kebutuhan pasien. Kepuasan pasien adalah bagian utama dari semua tujuan pemberian asuhan keperawatan.
- e. Manajemen keperawatan harus terarah. Dalam mencapai tujuan organisasi, pengorganisasian dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditentukan.
- f. Pengarahan merupakan fungsi manajemen keperawatan meliputi pelimpahan tugas, supervisi, koordinasi, dan pengendalian pelaksanaan rencana yang terorganisir
- g. Manajer keperawatan berkualitas adalah manajer yang memberikan dukungan kepada anggotanya untuk melihat penampilan kerja yang berkualitas
- h. Manajemen keperawatan menerapkan komunikasi efektif karena meminimalkan kesalahpahaman dan memastikan pandangan yang seragam tentang arah dan persepsi antar bawahan.
- i. Pengembangan staf merupakan sesuatu yang penting dan harus dilaksanakan dalam memfasilitasi perawat pelaksana agar dapat menempati kedudukan yang lebih tinggi, serta upaya manajer dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perawat.
- j. Berdasarkan prinsip tersebut, manajer, administrator, dan bawahan seyogyanya bekerja sama dengan perawat dan staf dalam perencanaan, pengorganisasian, serta fungsi manajemen lainnya dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.

8. Ruang Lingkup Manajemen Keperawatan

Keperawatan merupakan disiplin praktik yang klinis. Manajer keperawatan yang baik selayaknya mengerti dan memfasilitasi pekerjaan perawat pelaksana. Menurut (Suyanto, 2009) pengelolaan kegiatan keperawatan, seorang manajer keperawatan melakukan:

- a. Menentukan penggunaan proses asuhan keperawatan

- b. Menetapkan rencana keperawatan berdasarkan masalah keperawatan.
- c. Memperoleh akuntabilitas kegiatan keperawatan yang dilakukan oleh perawat
- d. Memperoleh akuntabilitas hasil kegiatan keperawatan.

Menurut (Suyanto, 2009) keperawatan terdiri atas :

a. Manajemen Pelayanan Keperawatan

Bidang keperawatan dapat mengelola pelayanan keperawatan di rumah sakit, yang terdiri dari tiga tingkatan manajerial, yakni:

- 1) Manajemen puncak (kepala bidang keperawatan).
- 2) Manajemen menengah (kepala unit pelayanan atau supervisor).
- 3) Manajemen bawah (kepala ruangan perawatan).

b. Manajemen Asuhan Keperawatan

Manajemen asuhan keperawatan dilaksanakan dengan menggunakan proses keperawatan yang pada prinsipnya menggunakan konsep manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian atau evaluasi.

9. Hal - hal terkait dalam manajemen keperawatan

Manajemen keperawatan tergantung pada asuhan keperawatan. Menurut Korn (1987), yang terhubung dalam manajemen keperawatan meliputi; pengkajian merupakan proses utama keperawatan yang mengharuskan perawat menentukan setepat mungkin pengalaman masa lalu pasien, pengetahuan yang dimiliki, perasaan dan harapan kesehatan dimasa mendatang. Pengkajian ini meliputi proses pengumpulan data, validasi, interpretasi informasi tentang pasien.

Diagnosa keperawatan adalah masalah kesehatan secara aktual dan potensial berdasarkan pengalamannya, mempunyai wewenang melakukan intervensi keperawatan. Perawat melakukan analisa data pengkajian dalam menegakkan masalah keperawatan. Perencanaan keperawatan dilakukan setelah perawat merumuskan masalah keperawatan.

Implementasi adalah penerapan rencana keperawatan yang merupakan langkah proses keperawatan. Evaluasi adalah pertimbangan logis dari standar dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dibandingkan dengan aplikasi praktek yang aktual dan tingkat asuhan yang diberikan.

10. Faktor-faktor yang perlu dimiliki oleh menejer keperawatan

Seorang menejer agar berhasil dalam melaksanakan kegiatan manajemen tentunya didukung oleh adanya kemampuan dan keahlian yang dimilikinya. Menurut (Ilyas, 2012) menejer harus mempunyai keahlian dalam penerapan pengetahuan, mempunyai keterampilan kepemimpinan yang handal dan kemampuan menjalankan fungsi manajemen. Dalam memberikan asuhan keperawatan, seorang menejer keperawatan harus mampu memimpin semua

tenaga perawat agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas.

Menurut (Jones, 2007), seorang manajer keperawatan dalam melaksanakan pelayanan yang profesional pada pasien melalui stafnya dengan berpedoman pada fungsi-fungsi manajemen keperawatan. Seorang manajer keperawatan harus mempunyai keahlian, kemampuan memimpin, mempunyai kekuatan dan wibawa serta seorang manajer keperawatan yang berkualitas harus mempunyai keahlian dalam melaksanakan fungsi manajemen keperawatan

B. Manajemen Asuhan Keperawatan

1. Pengertian Manajemen Asuhan Keperawatan

Manajemen asuhan keperawatan adalah pengelompokan sumber daya dalam melaksanakan proses keperawatan dengan menggunakan model asuhan keperawatan dalam memenuhi kebutuhan pasien atau menegakkan masalah pasien (Keliat, 2000). Tiga komponen manajemen asuhan keperawatan yaitu manajemen tenaga perawat (SDM) dengan menerapkan sistem pengorganisasian perawat (asuhan keperawatan) dan sistem klasifikasi kebutuhan pasien dalam model pemberian asuhan keperawatan yaitu proses keperawatan.

2. Asuhan Keperawatan

Asuhan keperawatan merupakan proses praktik keperawatan yang dilakukan langsung pada pasien dalam memberi pelayanan keperawatan sesuai asas keperawatan sebagai suatu profesi yang didasarkan ilmu dan kiat keperawatan, berfokus pada kebutuhan klien untuk mengatasi masalah pada pasien. Hal terpenting dalam asuhan keperawatan adalah melakukan pendokumentasian asuhan keperawatan (Amalia et al., 2018)

Asuhan keperawatan adalah proses tersusun berupa langkah-langkah pemecahan masalah yang berurutan dan sistematis dalam pemberian asuhan keperawatan yang berorientasi pada pencapaian tujuan. Asuhan keperawatan merupakan hal penting dalam melaksanakan intervensi keperawatan pada individu, keluarga, maupun masyarakat. Asuhan keperawatan didasarkan pada kode etik, standar pelayanan, standar profesi, dan standar prosedur operasional (SOP) (Syarifah, 2022)

Asuhan keperawatan merupakan tugas utama tenaga keperawatan yang menjadi acuan dalam penilaian kinerja perawat di rumah sakit, maka dari itu perawat dituntut untuk memberikan asuhan keperawatan secara optimal dan mendokumentasikan dengan baik.

3. Proses Keperawatan

Proses keperawatan adalah sesuatu yang dengan sengaja, menggunakan sistem pemecahan masalah untuk menentukan kebutuhan keperawatan pasien dalam pelayanan keperawatan, meliputi pengkajian, masalah keperawatan, perencanaan, pelaksanaan keperawatan dan evaluasi, serta menerapkan mekanisme umpan balik dalam peningkatan pemecahan masalah.

Proses merupakan suatu kegiatan operasional dalam mencapai hasil yang diharapkan. Proses keperawatan adalah model yang logis dan rasional dalam merencanakan dan memberikan pelayanan keperawatan kepada individu. Tujuannya untuk mengidentifikasi status kesehatan klien, kebutuhan atau masalah kesehatan aktual atau risiko, membuat perencanaan sesuai dengan kebutuhan yang telah diidentifikasi dan melaksanakan intervensi keperawatan spesifik sesuai dengan kebutuhan (Kozier, Barbara; Berman, 2012)

Sedangkan (Clark, 2008) mengatakan bahwa proses keperawatan sebagai suatu metode berfikir yang teroganisir untuk membuat suatu keputusan klinis dan pemecahan masalah. Demikian juga dengan (Yura, Helen; B Walsh, 1988), menyatakan bahwa proses keperawatan adalah tindakan yang berurutan dilakukan secara sistematis untuk menentukan masalah klien, membuat perencanaan untuk mengatasinya, melaksanakan rencana tersebut atau menugaskan orang lain untuk melaksanakannya dan mengevaluasi keberhasilan secara efektif terhadap masalah yang dilatasi.

4. Komponen Asuhan Keperawatan

Menurut (Kesehatan RI, 2005), komponen asuhan keperawatan meliputi; pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi dan evaluasi :

a. Pengkajian

Pengkajian adalah pemikiran dasar dari proses keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang respon klien agar dapat mengidentifikasi dan mengenali masalah atau kebutuhan kesehatan dan keperawatan klien. Area yang termasuk respon klien antara lain kegiatan sehari-hari, emosional, sosio-ekonomi, kultural dan spiritual (Yura, Helen; B Walsh, 1988). Menurut (Kozier, Barbara; Berman, 2012) proses pengkajian terdiri atas empat kegiatan, yaitu pengumpulan data, organisasi data, validasi data, dan pencatatan data.

b. Diagnosa keperawatan

Diagnosa keperawatan adalah struktur dan proses. Struktur diagnosa keperawatan tergantung pada tipenya, antara lain; diagnosa keperawatan aktual (*Actual nursing diagnosis*). Diagnosa keperawatan aktual menyajikan keadaan yang secara klinis telah divalidasi melalui batasan karakteristik mayor

yang dapat diidentifikasi. Tipe dari diagnosa keperawatan ini mempunyai empat komponen yaitu label, definisi, batasan karakteristik dan faktor-faktor yang berhubungan (Craven, Ruth F; Hirnle, 2005)

Diagnosa keperawatan risiko dan risiko tinggi (*risk and high risk nursing diagnose*) adalah rentan keputusan klinis bahwa individu, keluarga dan masyarakat sangat rentan untuk masalah, dibanding yang lain pada situasi yang sama (Craven, Ruth F; Hirnle, 2005)

Diagnosa keperawatan kemungkinan (*possible nursing diagnosis*) adalah pernyataan tentang masalah-masalah yang diduga masih memerlukan data tambahan. Namun banyak perawat-perawat telah diperkenalkan untuk menghindari sesuatu yang bersifat sementara dan NANDA tidak mengeluarkan diagnosa keperawatan untuk jenis ini (Craven, Ruth F; Hirnle, 2005)

Diagnosa keperawatan sejahtera (*wellness nursing diagnoses*) adalah ketentuan klinis mengenai individu, keluarga dan masyarakat dalam situasi transisi dari tingkat kesehatan khusus ke tingkat kesehatan yang lebih baik. Pernyataan diagnostik untuk diagnosa keperawatan sejahtera merupakan bagian dari pernyataan yang berisikan hanya sebuah label. Label ini dimulai dengan "potensi terhadap peningkatan". Diikuti tingkat sejahtera yang lebih tinggi yang dikehendaki oleh individu atau keluarga, misalnya "potensi terhadap peningkatan proses keluarga" (Craven, Ruth F; Hirnle, 2005)

Diagnosa keperawatan sindrom (*syndrome nursing diagnoses*) terdiri dari sekelompok diagnosa keperawatan aktual atau risiko tinggi yang diduga akan tampak karena kejadian atau situasi tertentu. NANDA telah menyetujui dua diagnosa keperawatan sindrom yaitu "sindrom trauma perkosaan" dan "Risiko terhadap sindrom disuse" (Carpenito, 2013). Secara umum diagnosa keperawatan dipergunakan perawat di Indonesia adalah diagnosa keperawatan aktual dan diagnosa keperawatan risiko tinggi.

c. Perencanaan

Langkah ketiga dari proses keperawatan adalah perencanaan menurut (Kozier, Barbara; Berman, 2012) perencanaan adalah sesuatu yang telah dipertimbangkan secara mendalam, tahap yang sistematis dari proses keperawatan meliputi kegiatan pembuatan keputusan dan pemecahan masalah. Dalam perencanaan keperawatan, perawat menetapkan berdasarkan hasil pengumpulan dalam membuat tujuan dan asuhan keperawatan untuk mencegah, menirukan, atau mengeliminasi masalah kesehatan lain.

Langkah-langkah dalam membuat perencanaan keperawatan meliputi; pendapat prioritas, penetapan tujuan/hasil yang diharapkan, menentukan

intervensi keperawatan yang tepat dan pengembangan rencana asuhan keperawatan. Setelah diagnosa keperawatan dirumuskan secara spesifik, perawat menggunakan kemampuan berfikir kritis untuk segera menetapkan prioritas diagnosa keperawatan dan intervensi yang penting sesuai dengan kebutuhan klien (Potter, Patricia A ; Perry, 2012), penetapan prioritas bertujuan untuk mengidentifikasi urusan intervensi keperawatan yang sesuai dengan berbagai masalah klien (Carpenito, 2013).

Penetapan prioritas dilakukan karena tidak semua masalah dapat diatasi dalam waktu yang bersamaan. Salah satu metode dalam menetapkan prioritas dengan menggunakan hirarki kebutuhan Maslow. Prioritas dapat diklasifikasi menjadi tiga tingkatan, antara lain *high priority, intermediate, priority, dan low priority*.

Dalam menetapkan prioritas perawat juga harus memperhatikan nilai dan kepercayaan klien terhadap kesehatan, prioritas klien, sumber yang tersedia untuk klien dan perawat, pentingnya masalah kesehatan yang dihadapi, rencana pengobatan medis.

d. Implementasi

Implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dari masalah status kesehatan yang dihadapi kestatus kesehatan yang lebih baik yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan (Potter, Patricia A ; Perry, 2012). Ukuran intervensi keperawatan yang diberikan kepada klien terkait dengan dukungan, pengobatan, tindakan untuk memperbaiki kondisi, pendidikan untuk klien-keluarga, atau tindakan untuk mencegah masalah kesehatan yang muncul dikemudian hari.

Untuk kesuksesan pelaksanaan implementasi keperawatan agar sesuai dengan rencana keperawatan, perawat harus mempunyai kemampuan kognitif (intelektual), kemampuan dalam hubungan interpersonal, dan kerampilan dalam melakukan tindakan. Proses pelaksanaan implementasi harus berpusat kepada kebutuhan klien, faktor-faktor lain yang mempengaruhi keperawatan, strategi implementasi keperawatan, dan kegiatan komunikasi (Kozier, Barbara; Berman, 2012)

Beberapa pedoman dalam pelaksanaan implementasi keperawatan (Kozier, Barbara; Berman, 2012) adalah sebagai berikut :

- 1) Harus berdasarkan ilmu pengetahuan, hasil penelitian keperawatan dan standar pelayanan profesional
- 2) Perawat mengerti dengan jelas pesan-pesan yang ada dalam rencana implementasi
- 3) Harus dapat menciptakan adaptasi dengan klien sebagai individu

- 4) Dapat menjaga rasa aman/melindungi klien
- 5) Memberikan pendidikan, dukungan dan bantuan
- 6) Bersifat holistik
- 7) Menjaga martabat dan harga diri klien
- 8) Mengikutsertakan partisipasi aktif klien dalam implementasi keperawatan

e. Evaluasi

Meskipun proses keperawatan mempunyai tahap-tahap, namun evaluasi berlangsung terus menerus sepanjang proses keperawatan (Alfaro-Lefevre, 1998). Tahap evaluasi merupakan perbandingan yang sistematis dan terencana tentang kesehatan klien dengan tujuan yang telah ditetapkan, dilakukan berkesinambungan dengan melibatkan klien dan tenaga kesehatan lainnya. Evaluasi dalam keperawatan merupakan kegiatan dalam menilai tindakan keperawatan yang telah ditentukan, untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan klien secara optimal dan mengukur hasil dari proses keperawatan. (Craven, Ruth F; Hirnle, 2005) evaluasi didefinisikan sebagai keputusan dari efektivitas asuhan keperawatan antara dasar tujuan keperawatan klien yang telah ditetapkan dengan respon perilaku yang tampil.

Perawat menggunakan berbagai kemampuan dalam memutuskan efektif atau tidaknya pelayanan keperawatan yang diberikan. Untuk memutuskan hal tersebut dalam melakukan evaluasi seseorang perawat harus mempunyai pengetahuan tentang standar pelayanan, respon klien yang normal, dan konsep model teori keperawatan.

Dalam melakukan proses evaluasi, ada beberapa kegiatan yang harus diikuti oleh perawat, antara lain mengkaji ulang tujuan klien dan kriteria hasil yang telah ditetapkan, mengumpulkan data yang berhubungan dengan hasil yang diharapkan, mengukur pencapaian tujuan, melakukan revisi atau modifikasi terhadap rencana keperawatan.

5. Model Asuhan Keperawatan Profesional

Menurut (Marquis, B. L.,; Huston, 2012) pemberian asuhan keperawatan sebagai berikut:

a. Model Fungsional

Model tradisional peninggalan jaman Belanda dimana perawat dianggap sebagai asisten, sehingga perawat bekerja menunggu advis atau tergantung profesi lain. Kepala ruangan bertanggung jawab hampir 90% dalam pelayanan keperawatan. Semua anggota tergantung perintah atau pembagian tugas dari Kepala ruangan (KARU) dan tidak terlihat jelas pembagian tugas KARU dengan KATIM yg sudah dibentuk

Dasar pemikiran: setiap perawat mempunyai pemikiran yg sama. Fungsi KARU: menentukan standar pelaksanaan asuhan keperawatan, tapi tidak ada kejelasan dalam pelaksanaan pengarahan dan supervisi serta evaluasi tugas tim. Klasifikasi pengawasan: KARU dipilih oleh pimpinan karena dianggap memiliki pengalaman lama dan anggota berpendidikan lulusan D3 atau dibawahnya. Wakil KARU bisa selevel atau lebih rendah dari perawat lainnya Model Fungsional atau konvensional merupakan metode dimana seorang kepala ruangan membagi kompetensi kepada masing-masing stafnya. Contoh: Ners F bertugas memasang kateter, Ners A bertugas mengukur tanda-tanda vital. Perawat bisa melaksanakan dua tanggung jawab atau lebih pada semua pasien yang berada di ruangan. Kepala ruangan mempunyai tanggung jawab membagi tugas dan menerima laporan terkait seluruh pasien yang ada di ruangan.

Kelebihan Model Fungsional meliputi: 1) Perawat lebih kompeten dengan jenis keterampilan tertentu; 2) Perawat merasa lebih puas setelah selesai bekerja; 3) Tenaga perawat profesional bisa diganti dengan perawat belum profesional; 4) Kepala ruangan mudah dalam mengawasi staf perawat dan mahasiswa yang sedang praktek di ruangan

Kekurangan Model Fungsional meliputi: 1) Asuhan keperawatan terfragmentasi, sehingga proses keperawatan sulit dilaksanakan; 2) Perawat lebih sering meninggalkan pasien dan melaksanakan tugas diluar keperawatan; 3) Sulit mendapatkan kepuasan kerja secara menyeluruh serta sulit mengidentifikasi seberapa besar peran sertanya dalam pelayanan keperawatan dan 4) Perawat beranggapan bahwa layanan keperawatan hanya skill semata.

b. Model Kasus

Adalah model penugasan dimana seorang perawat memberikan asuhan keperawatan kepada seorang pasien secara total dalam satu shift. Jumlah pasien yang dirawat oleh seorang perawat tergantung pada kemampuan perawat, kondisi serta kebutuhan pasien yang menjadi tanggung jawabnya.

- 1) Masalah pasien dapat teratasi
- 2) Pasien akan merasakan kepuasan.
- 3) Masalah keperawatan pasien dipahami dan dapat diatasi oleh perawat
- 4) Secara keseluruhan kepuasan dalam bekerja bisa didapatkan oleh perawat.

Kekurangan model kasus meliputi; 1) Kemampuan perawat pelaksana serta peserta didik yang melaksanakan praktik masih kurang, sehingga asuhan keperawatan belum bisa dilakukan secara komprehensif; 2) Memerlukan

tenaga perawat yang banyak, ; 3) Beban kerja tinggi, terutama bila pasien banyak dan akibatnya tugas rutin bisa terbengkalai dan 4) Pendelegasian tugas hanya bisa dilaksanakan apabila penanggung jawab pasien bertugas.

c. Model Tim

Pengorganisasian pelayanan keperawatan dimana seorang perawat profesional memimpin beberapa perawat dalam memberikan asuhan keperawatan terhadap beberapa orang pasien melalui upaya kooperatif dan kolaboratif. Ketua tim sebagai perawat profesional bertanggung jawab membuat keputusan yang tepat terkait perencanaan, supervisi dan evaluasi asuhan keperawatan. Ketua Tim bertanggung jawab dalam mengarahkan anggota Tim, membantu anggota Tim dalam menyelesaikan tugas apabila mengalami kesulitan.

Model dibentuk karena adanya keterbatasan tenaga profesional atau S1 sehingga ada modifikasi pembagian tugas yaitu dilakukan bersama terhadap beberapa perawat. Dasar pemikiran: berusaha menerapkan metode keperawatan profesional tapi dengan tenaga lulusan yg berbeda-beda

Fungsi KARU:

- 1) Menentukan standar pelaksanaan ASKEP
- 2) Memberikan pengarahannya kepd KATIM
- 3) Melakukan evaluasi tugas tim

Klasifikasi KATIM:

- 1) Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
 - a) Pendidikan tinggi dan memiliki keterampilan yang mahir dan kemampuan kepemimpinan serta *registered nurse*
 - b) Mampu menentukan prioritas kebutuhan ASKEP
 - c) Mampu menerapkan filosofi keperawatan dalam melaksanakan ASKEP
- 2) Memiliki kemampuan komunikasi yang baik
- 3) Mampu menerapkan manajemen dan kepemimpinan keperawatan dalam bekerja
- 4) Pelaksanaan fleksibel sesuai ketenagaan yang ada

Fungsi KATIM

- 1) Membuat perencanaan berdasarkan tugas pokok dan kewenangannya
- 2) Membuat penugasan, supervisi dan evaluasi harian
- 3) Mengetahui dan menilai kebutuhan pasien setiap hari
- 4) Memberi motivasi kebutuhan pasien setiap hari
- 5) Membuat dan menetapkan sistem operan, pre dan post konferens serta diskusi lainnya dengan anggota tim

Pengawasan Metode Tim

- 1) Melalui komunikasi yaitu langsung mengadakan tanya jawab kelapangan bertemu dengan anggota tim
- 2) Melalui supervisi: pengawasan langsung, menginspeksi, observasi langsung dan melihat dokumentasi setiap hari dan langsung mengadakan diskusi dan mendengar keluhan serta membuat koreksi dan perbaikan
- 3) Evaluasi: menilai kemampuan anggota terutama pengetahuan dan keterampilannya
- 4) Membuat pencatatan dan pelaporan secara tertib dan teratur

Fungsi Anggota Tim:

- 1) Menyadari bahwa mereka memiliki tanggungjawab sesuai unit timnya
- 2) Mengikuti instruksi sesuai rencana keperawatan yang dibuat katim
- 3) Melaporkan secara tepat dan akurat ASKEP yg telah dilakukan kepada Katim
- 4) Menerima bantuan dan bimbingan katim

Fungsi *Critical Care Manajer (CCM)*

- 1) Bersama karu mengidentifikasi kebutuhan sarana/prasarana ruang keperawatan
- 2) Bersama karu membuat sistem/metode evaluasi dan pengawasan
- 3) Bersama karu dan katim menentukan sistem ASKEP dipakai
- 4) Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan askep
- 5) Mengadakan pencatatan dan pelaporan tentang kekurangan pelaksanaan ASKEP dan melaporkan ke pimpinan lebih tinggi
- 6) Menjadi fasilitator, mediator dan komunikator ruangan dengan pihak lain yang terkait dengan pimpinan institusi dan pihak luar

Klasifikasi Tenaga Model Penugasan Tim

Karu diutamakan minimal lulusan S1 atau D3 yg berpengalaman lebih dari 10 tahun. Waku bisa selevel atau lebih rendah dari karu. Ketua tim S1 atau D3 yang berpengalaman lebih dari 5 tahun. CCM selalu tinggi pendidikannya atau lebih berpengalaman dari Karu

Kelebihan model tim meliputi; 1) Berbagi pengalaman antara perawat dalam satu tim; 2) Klien mendapatkan pelayanan yang menyeluruh.; 3) Terwujudnya kaderisasi kepemimpinan; 4) Terciptanya kerjasama yang baik; 5) Memberikan kepuasan kerja bagi perawat terkait dengan hubungan antar anggota tim dan 6) Menyatukan kemampuan setiap perawat dengan aman dan efektif.

Kekurangan meliputi: 1) Perawat tidak mengetahui pasien yang bukan tanggung jawabnya; 2) Pertemuan dengan anggota tim butuh waktu akibatnya

saat sibuk, *meeting* sering tidak dilaksanakan atau tergesa-gesa, yang berakibat komunikasi serta koordinasi diantara anggota akan terganggu sehingga dapat menghambat kegiatan; 3) Anggota tim yang masih kurang pengalaman lebih sering bergantung kepada perawat yang mempunyai kemampuan atau berlandung pada ketua tim.

d. Model Keperawatan Primer

Metode Keperawatan Primer yaitu model penugasan dimana seorang perawat profesional bertanggung jawab melaksanakan asuhan keperawatan selama 24 jam sejak pasien masuk sampai pulang. Metode Keperawatan Primer adalah metode pelayanan asuhan keperawatan yang ditandai dengan adanya ketertarikan kuat dan terus menerus antara perawat primer dan pasien dimana perawat memiliki tugas untuk merencanakan, melaksanakan dan berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lain selama pelaksanaan asuhan keperawatan. Persyaratan minimal adalah S1 yg memiliki sertifikat nurse atau *registered nurse*

Ketenagaan

- 1) Setiap perawat primer adalah perawat *bedside*
- 2) Beban kerja untuk satu perawat primer, maksimal 5 pasien
- 3) Penugasan ditentukan oleh kepala ruangan
- 4) Perawat primer adalah perawat profesional minimal setingkat S1 dengan tambahan pendidikan keahlian khusus atau S2 spesialis

Fungsi Kepala Ruangan

- 1) Sebagai konsultan dan pengendali mutu pelayanan keperawatan
- 2) Member orientasi dan perekrutan tenaga perawat
- 3) Menyusun jadwal jaga
- 4) Memberi penugasan kepada perawat primer
- 5) Melakukan evaluasi kerja
- 6) Memberi penugasan kepada pembantu perawat
- 7) Merencanakan pengembangan staf
- 8) Membuat pasien sebagai model pelayanan profesional

Tugas Perawat Primer

- 1) Menerima pasien baru
- 2) Melakukan pengkajian kebutuhan pasien bio-psiko-spritual
- 3) Membuat tujuan dg kriteria sesuai prioritas kebutuhan pasien (*Nursing Care Plan*)
- 4) Melaksanakan asuhan keperawatan meliputi: tindakan keperawatan mandiri, observasi/monitor, kolaborasi, termasuk pendidikan Kesehatan

- 5) Melakukan koordinasi kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan yang terkait untuk kesembuhan pasien
- 6) Melakukan evaluasi sesuai tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan
- 7) Menerima dan menyesuaikan hasil rencana dengan melakukan tindak lanjut terhadap masalah yang belum selesai
- 8) Menyiapkan discharge planning sesuai kondisi pasien

Keuntungan model keperawatan primer meliputi; 1) Model praktek keperawatan professional bisa diaplikasikan; 2) Bisa dilaksanakan asuhan keperawatan secara menyeluruh; 3) Perawat akan merasa puas dengan pekerjaan dan 4) Pasien dan keluarga dapat merasakan kepuasan setelah mendapatkan layanan keperawatan.

Kerugian model keperawatan primer meliputi: 1) Hanya bisa dilaksanakan oleh perawat yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai; 2) Hanya bisa dilaksanakan oleh perawat yang mampu berkolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu dan 3) Biaya relatif lebih tinggi.

e. Model Moduler

Model modular adalah variasi model primer dan tim, tetapi menggunakan perawat dari berbagai jenjang. Perawat melaksanakan asuhan keperawatan selama 24 jam. Metode modular merupakan variasi metode primer dan tim tetapi dengan menggunakan tenaga perawat dari berbagai klasifikasi, sama dengan metode tim Perawat profesional dengan perawat non profesional bekerjasama

Ketenagaan

- 1) Satu modul bertanggung jawab terhadap 8-15 pasien
- 2) Bila modul tidak dinas maka bisa digantikan oleh modul lain

Fungsi KARU

- 1) Memasangkan perawat yg memilki tipe yang saling melengkapi
- 2) Menjadi fasilitator dan motivator

Keuntungan model modular meliputi: 1) Pasien dan perawat bisa mendapatkan kepuasan; 2) Meningkatkan kebersamaan dan kesolidan antar anggota tim; 3) Memungkinkan pengembangan perawat secara alami; 4) Saling menutupi kekurangan dan 5) Kepuasan pasien dan 6) perawat bisa dipertahankan

Kerugian model modular meliputi: 1) Hanya cocok bagi perawat yang kreatif dan 2) Tidak sesuai bagi kepala ruangan yang tidak memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik (Kanang, Syahrul, & Majid, 2020).

6. Peran Dan Tugas Manajemen Asuhan Keperawatan

Peran dan fungsi perawat profesional dibuat untuk mempertegas aspek yang membedakan praktik keperawatan profesional dengan praktik keperawatan yang diberikan orang tidak profesional dibidang keperawatan. Menurut (Lestari 2014), peran dan fungsi perawat secara umum sebagai berikut:

- a. Intervensi keperawatan kepada pasien
- b. Pemberian perawatan langsung. Identifikasi waktu yang tepat untuk melaksanakan pelayanan keperawatan pada klien
- c. Mempersiapkan dan mendukung tenaga yang tidak profesional dibidang keperawatan untuk aktivitas diserahkan kepada perawat profesional.
- d. Perawat profesional mengambil alih dan mengendalikan manajemen, sumber daya manusia, perlengkapan dan pelayanan yang optimal
- e. Pembentukan standar, audit keperawatan dan audit klinik.

Peran dan fungsi perawat dalam manajemen keperawatan sebagai berikut:

- a. Peran
 - 1) Pelaksana Pelayanan Keperawatan Perawat bertanggung-jawab dalam memberikan pelayanan keperawatan dari yang bersifat sederhana sampai pada yang paling kompleks kepada klien, keluarga, kelompok dan Masyarakat
 - 2) Pengelola dalam bidang Pelayanan Keperawatan Tenaga keperawatan secara fungsional mengelola pelayanan keperawatan termasuk perlengkapan, peralatan dan lingkungan. Disamping itu membimbing petugas kesehatan yang berpendidikan lebih rendah, bertanggungjawab dalam hal administrasi keperawatan baik di masyarakat maupun di dalam institusi dalam mengelola pelayanan keperawatan untuk klien, keluarga, kelompok dan masyarakat.
 - 3) Pendidik Pelayanan Keperawatan Tenaga Keperawatan bertanggung jawab dalam hal pendidikan dan pengajaran ilmu keperawatan dasar bagi tenaga kesehatan lainnya dan tenaga anggota keluarga.
- b. Fungsi tenaga perawat

Adapun fungsi tenaga keperawatan adalah sebagai berikut:

- 1) Menetapkan kebutuhan Kesehatan pasien dan memotivasi pasien untuk berperan aktif dalam pemenuhan kebutuhan kesehatannya.
- 2) Melakukan pendidikan kesehatan terkait *personal hygiene*, kesehatan lingkungan, kesehatan mental, gizi, kesehatan ibu dan anak, pencegahan penyakit dan kecelakaan.
- 3) Pemberian Asuhan Keperawatan pada pasien meliputi perawatan darurat, dan kolaborasi dengan dokter dalam pemberian obat

- 4) Memberikan rujukan terhadap kasus yang tidak bisa ditangani dan menerima rujukan dari organisasi kesehatan lainnya.
- 5) Melakukan pendokumentasian asuhan Keperawatan.
- c. Tugas tenaga keperawatan adalah:
 - 1) Menjaga kebersihan dan kerapihan didalam ruangan
 - 2) Penerimaan pasien baru
 - 3) Melakukan asuhan keperawatan dengan model proses keperawatan
 - 4) Melakukan *discharge planning*
 - 5) Mengarahkan dan mengawasi pekarya kesehatan dan pekarya rumahtangga
 - 6) Mengatur tugas jaga
 - 7) Mengatur peralatan medik dan keperawatan, bahan habis pakai dan obat
 - 8) Mengatur administrasi

C. Latihan Soal

Soal Essay

1. Coba saudara/I jelaskan, menurut pendapat saudara manajemen keperawatan dengan Manajemen asuhan keperawatan pengorganisasian dalam keperawatan seperti apa?
2. Coba saudara/i jelaskan tentang fungsi manajemen keperawatan
3. Coba saudara/ijelaskan tentang prinsip Manajemen keperawatan
4. Coba saudara/i jelaskan proses asuhan keperawatan
5. Coba saudara/I jelaskan model asuhan keperawatan

Soal Multiple choice

Perhatikan petunjuk dalam menjawab soal ini

- a. Jawablah menurut anda yang benar (A, B, C, D, E)
- b. Jawaban A jika 1, 2 dan 3 benar
 Jawaban B jika 1 dan 3 benar
 Jawaban C jika 2 dan 4 benar
 Jawaban D jika 4 saja benar
 Jawaban E jika semua benar
1. Seorang kepala ruangan membuat rencana kerja selama 1 tahun, dengan membuat upaya-upaya pengembangan staf, berupa studi lanjut bagi perawat, pelatihan dan seminar-seminar yang akan diselenggarakan selama 1 tahun kedepan. Apakah fungsi manajemen yang dilakukan kepala ruangan pada kasus diatas?
 A. *Planning*

- B. *Organizing*
- C. *Staffing*
- D. *Actuating*
- E. *Controlling*

2. Seorang perawat baru bekerja pada hari pertama di Bangsal Penyakit Dalam. Kepala ruangan menyampaikan uraian tugas kepada perawat baru tersebut dan kepada masing-masing perawat dan staf lainnya. Apakah fungsi manajemen yang diterapkan pada kasus tersebut?

- A. *Planning*
- B. *Organizing*
- C. *Staffing*
- D. *Actuating*
- E. *Controlling*

3. Seorang ketua tim melakukan kegiatan post conference, katim menanyakan kepada perawat pelaksana implementasi keperawatan dan evaluasi dari tindakan keperawatan yang telah dilakukan pada pasien serta melakukan pengecekan status pasien apa sudah terdokumentasi dengan baik atau belum. Apakah bentuk fungsi manajemen yang dilakukan KATIM pada kasus diatas?

- A. *Planning*
- B. *Organizing*
- C. *Staffing*
- D. *Actuating*
- E. *Controlling*

4. Di rumah sakit A melakukan pengelompokkan structural dari kelompok manajer atau dari tingkat pengelola keperawatan tertinggi sampai ke perawat pelaksana yang mempunyai tugas dan wewenang untuk dapat melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan, merupakan komponen Manajemen keperawatan:

- A. Input
- B. Outpet
- C. Proses
- D. Control
- E. Umpan baalik

5. Kepala bidang keperawatan terus berupaya meningkatkan mutu pelayanan keperawatan di rumah sakit tempat dia bekerja, dengan mengelola sistem manajerial dengan baik dan melalui tingkatan manajerial. Yang merupakan tingkatan manajerial pada kasus diatas:
- A. Manajemen puncak
 - B. Manajemen menengah
 - C. Manajemen bawah
 - D. Pengelolaan asuhan keperawatan
 - E. Pengelolaan pelayanan keperawatan
6. Seorang ketua tim perawat disuatu ruang rawat inap membagi pasien pada masing-masing perawat pelaksana. Setiap hari perawat pelaksana melakukan pre dan post conference kasus pasien masing-masing dan melakukan diskusi perkembangan pasien masing-masing. Apakah metode asuhan keperawatan yang diterapkan pada kasus tersebut?
- A. Tim
 - B. Kasus
 - C. Primer
 - D. Modular
 - E. fungsional
7. Pemikiran dasar dari proses keperawatan untuk mengumpulkan informasi atau data klien, mengidentifikasi, mengenali masalah, kebutuhan kesehatan dan keperawatan klien (fisik, mental, sosial dan lingkungan), disebut:
- A. Pengkajian
 - B. Diagnosa Keperawatan
 - C. Intervensi Keperawatan
 - D. Implementasi
 - E. e.Evaluasi
8. Penilaian klinik (Clinical Judgment) tentang respon individu, keluarga atau komunitas terhadap masalah kesehatan (proses hidup) aktual atau potensial, disebut:
- A. Pengkajian
 - B. Diagnosa Keperawatan
 - C. Intervensi Keperawatan
 - D. Implementasi
 - E. Evaluasi

9. Seorang perawat berusia 34 tahun melakukan tindakan keperawatan berdasarkan rencana tindakan yang telah dibuat dengan melihat apakah rencana tersebut menjamin keselamatan klien. Proses keperawatan yang dilakukan oleh perawat berada pada tahap:
- A. Pengkajian
 - B. Diagnosa Keperawatan
 - C. Intervensi Keperawatan
 - D. Implementasi
 - E. Evaluasi
10. Tindakan intelektual untuk melengkapi proses keperawatan yang menandakan seberapa jauh diagnosa keperawatan, rencana tindakan, dan pelaksanaannya sudah berhasil dicapai, disebut :
- A. Pengkajian
 - B. Diagnosa Keperawatan
 - C. Intervensi Keperawatan
 - D. Implementasi
 - E. Evaluasi

Kunci Jawaban

- 1. A
- 2. B
- 3. E
- 4. C
- 5. A
- 6. A
- 7. A
- 8. B
- 9. D
- 10. E

D. Rangkuman Materi

Manajemen Keperawatan adalah salah satu manajemen pelayanan kesehatan dan manajemen asuhan keperawatan. Manajemen pelayanan keperawatan adalah suatu pelayanan di rumah sakit yang dikelola oleh bidang perawatan melalui tiga tingkatan manajerial yaitu manajemen puncak (kepala bidang keperawatan), manajemen menengah (kepala unit pelayanan atau supervisor), dan juga manajemen bawah (kepala ruang perawatan) (Suyanto, 2009).

Manajemen keperawatan sejalan dengan proses keperawatan sebagai satu metode pelaksanaan asuhan keperawatan secara profesional, sehingga diharapkan keduanya dapat saling mendukung. Berdasarkan teori-teori tersebut manajemen keperawatan merupakan proses pelaksanaan pelayanan keperawatan melalui upaya staf keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan, memberikan pengobatan dan rasa aman kepada pasien, keluarga, dan masyarakat. Sehingga dengan bagusnya sistem manajemen keperawatan maka proses pelayanan akan semakin meningkat. Menurut (Dee Ann Gillies, 1994) ada lima fungsi manajemen yang harus diperhatikan, yaitu ; perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerak (*actuating*), pengendalian atau pengawasan (*controlling*), penilaian (*evaluation*).

Manajemen asuhan keperawatan merupakan pengaturan sumber daya dalam menjalankan kegiatan keperawatan dengan menggunakan metode proses keperawatan untuk memenuhi kebutuhan klien atau menghasilkan masalah klien (Keliat, 2000). Asuhan keperawatan merupakan rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang diberikan langsung kepada klien untuk memberi pelayanan kesehatan sesuai dengan kaidah-kaidah keperawatan sebagai suatu profesi yang berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan. (Amalia, dkk 2018). Proses keperawatan ini terdiri dari lima tahapan, yaitu pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi dan evaluasi (Koerniawan, dkk 2020).

E. Glosarium

ASKEP	: Asuhan Keperawatan
CCM	: <i>Critical Care Manajer</i>
KARU	: Kepala Ruangan
KATIM	: Ketua Tim
SDM	: Sumber Daya Manusia
SOP	: Standar Operasional Profesional
WAKARU	: Wakil Kepala Ruangan

F. Daftar Pustaka

- Agus Kunturo. (2020). Buku Ajar Manajemen Keperawatan. Nuha Medika.
- Amalia, E., Herawati, L., & Studi Ilmu Keperawatan STIKes Perintis Padang, P. (2018). Faktor-Faktor Kelengkapan Pendokumentasian Asuhan Keperawatan Di Instalasi Rawat Inap Rsud Lubuk Sikaping. *Prosiding Seminar Kesehatan Perintis E*, 1(1), 2622–2256.
- Asmuji. (2012). *Manajemen Keperawatan: Konsep dan Aplikasi*. Ar-Ruzz.
- Carpenito, L. J. (2013). *Buku Saku Diagnosis Keperawatan* (13th ed.). EGC.
- Clark, M. J. D. (2008). *Nursing Care in the Community* (M. J. D. Clark (ed.); 2nd ed.). Appleton & Lange.
- Craven, Ruth F; Hirnle, C. J. (2005). *Fundamentals of nursing: human health and function*. Lippincott Williams & Wilkins.
- Dee Ann Gillies. (1994). *Nursing Management: A Systems Approach*. Saunders.
- Hani Tuasikal, Selpina Embuai, M. S. (2020). *Manajemen Keperawatan: Teori dan Konsep Dalam Keperawatan*. Desanta Muliavisitama.
- Ilyas. (2012). *Perencanaan sumber daya manusia rumah sakit*. Erlangga.
- Jones, R. (2007). *Nursing leadership and management: theories, process and practice*. Davis Company.
- Kesehatan RI, D. (2005). *Instrumen Evaluasi Penerapan Standar Asuhan Keperawatan Di Rumah Sakit*. Depkes RI.
- Kozier, Barbara; Berman, A. (2012). *Kozier & Erb's fundamentals of nursing: concepts, process, and practice*. Pearson.
- Manda. (2016). Fungsi Pengorganisasian Dan Evaluasi Peserta Didik. *Journal of Islamic Education Management*, 1, 89–101.
- Marquis, B. L; Huston, C. J. (2012). *Leadership roles & management functions in nursing: Theory & Application* (7th ed). Lippincott Williams & Wilkins.
- Marquis, Bessie L, Huston, C. J. (2017). *Kepemimpinan Dan Manajemen Keperawatan*. EGC.

- Mugianti, S. (2016). Modul Bahan Ajar Cetak Keperawatan: Manajemen dan Kepemimpinan dalam Praktek Keperawatan. Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.
- Nursalam. (2017). Manajemen keperawatan: Aplikasi dalam praktik keperawatan profesional (5th ed). Salemba Medika.
- Potter, Patricia A; Perry, A. G. (2012). Buku Ajar Fundamental Keperawatan Konsep Proses Dan Praktik (4th ed.). EGC.
- Setiyadi, A. (2023). Manajemen Keperawatan (Issue July).
- Sullivan, E. J. (2012). Effective Leadership And Management In Nursing. 8th ed. Pearson.
- Suyanto. (2009). Mengenal kepemimpinan dan manajemen keperawatan di rumah saki. Perpustakaan STIK GIA.
- Swanburg, R. C. (2000). Pengantar kepemimpinan & manajemen keperawatan untuk perawat klinis. EGC.
- Syarifah, L. D. K. R. S. U. D. S. B. P. A. N. A. Y. C. H. W. J. J. N. E. U. R. (2022). Metodologi Proses Asuhan Keperawatan. Kita Menulis.
- Yura, Helen; B Walsh, M. (1988). The nursing process assessing, planning, implementing, evaluating 5th ed. Appleton & Lange.

BAB 3

MANAJEMEN PERENCANAAN KEPERAWATAN

Tujuan Instruksional

Tujuan Umum

1. Mahasiswa dapat memahami konsep perencanaan manajemen dalam keperawatan.
2. Mahasiswa dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip perencanaan manajemen dalam keperawatan.

Tujuan Khusus

1. Mampu memahami perencanaan manajemen keperawatan
2. Mampu memahami visi dan misi
3. Mampu memahami rencana kerja pelayanan keperawatan
4. Mampu memahami perencanaan kebutuhan tenaga

Capaian Pembelajaran:

Kognitif:

1. Mahasiswa memahami dan menjelaskan konsep-konsep penting terkait dengan perencanaan manajemen keperawatan
2. Mahasiswa mampu menghubungkan teori dengan praktik melalui analisis kasus dan penerapan prinsip-prinsip perencanaan manajemen keperawatan

Psikomotor:

1. Mahasiswa mampu menyusun sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan rencana asuhan keperawatan.
2. Menyusun perencanaan manajemen keperawatan suatu unit ruang sesuai dengan tahapan penyusunan perencanaan

Afektif:

1. Mahasiswa mampu bekerjasama Bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
2. Mahasiswa mampu bertanggung gugat terhadap praktik profesional

Pendahuluan

Keperawatan merupakan suatu bentuk pelayanan profesional bersifat humanistik, menggunakan pendekatan holistik ,dilakukan berdasarkan ilmu dan kiat keperawatan berorientasi kepada kebutuhan objektif klien . Praktik keperawatan mengacu pada

standar profesional keperawatan dan menggunakan etika keperawatan sebagai tuntutan utama titik perawat dituntut untuk selalu melaksanakan Asuhan Keperawatan yang benar atau rasional (Nursalam, 2007).

Perencanaan merupakan fungsi manajemen pertama yang sangat menentukan dan mempengaruhi keberhasilan dari fungsi-fungsi manajemen lainnya. Perencanaan harus dikerjakan lebih dahulu sebelum mengerjakan fungsi manajemen yang lainnya. Perencanaan yang baik akan mengarahkan pada pencapaian tujuan, sehingga sistem kontrol diharapkan berjalan dengan baik yang pada akhirnya akan memudahkan pencapaian tujuan organisasi. Fungsi manajemen selanjutnya adalah pengorganisasian, merupakan fungsi manajemen yang memiliki peranan penting seperti halnya perencanaan. Melalui fungsi pengorganisasian seluruh sumber daya baik manusia maupun bukan manusia yang dimiliki oleh suatu organisasi atau institusi diatur penggunaannya agar efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi tercapai

Bab ini akan mahasiswa memahami Hakekat Perencanaan ,visi misi .jenis perencanaan dalam keperawatan, Analisa Swot , perencanaan SDM Keperawatan.

Uraian Materi

A. Hakikat perencanaan

Aspek utama dalam manajemen adalah pengaturan dan penggerakan karyawan melalui proses kepemimpinan (Gitosudarmo, 2001). Untuk dapat melakukan pengaturan yang baik maka perlu perencanaan, pembagian tugas dan koordinasi tugas-tugas, oleh karena itu perencanaan merupakan aspek utama dan pertama kali harus dilakukan oleh seorang manajer atau pimpinan organisasi. Hasil dari perencanaan adalah sebuah rencana/rencana kerja yang harus berisi alternatif terbaik untuk mencapai tujuan. Rencana kerja yang baik mengarahkan pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, sehingga faktor-faktor produksi (resources) yang ada digunakan sebaik-baiknya.

Perencanaan merupakan langkah utama yang penting dalam keseluruhan proses manajemen agar faktor produksi yang biasanya sangat terbatas dapat diarahkan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, oleh karena itu perencanaan harus mengandung unsur-unsur yang dapat menjawab What, Why, Where, When, Who dan How. Secara lengkap pertanyaan-pertanyaan yang dimaksud adalah (Swanburg 1999)

Tindakan apa yang harus dikerjakan? Penjelasan dan perincian kegiatan yang dibutuhkan, sumber daya yang diperlukan dalam melaksanakan kegiatan tersebut agar apa yang menjadi tujuan dapat dihasilkan

Apa sebabnya Tindakan itu harus dilaksanakan? Penjelasan mengapa rencana itu harus dikerjakan dan mengapa tujuan tertentu harus dicapai

Dimana Tindakan itu harus dikerjakan? Penjelasan tentang tempat/lokasi secara fisik Dimana rencana kegiatan harus dikerjakan sehingga tersedia sumber daya yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan itu

Kapan rencana itu harus dikerjakan? Penjelasan kapan dimulainya tindakan dan kapan selesainya di setiap unit organisasi dengan penggunaan standar waktu yang telah ditentukan Siapa yang mengerjakan tindakan itu? Petugas yang akan melakukan kegiatan atau tindakan baik jumlah maupun kualifikasi keahlian, pengalaman maupun pendidikan

Bagaimana cara melaksanakan kegiatan itu? Penjelasan secara rinci teknik-teknik melakukan kegiatan yang ditetapkan sehingga tindakan yang dimaksud akan dapat dijalankan dengan benar

B. Tujuan Perencanaan

Tujuan perencanaan dalam manajemen:

- Meningkatkan peluang untuk sukses
- Menstimulasi berfikir analisis
- Mencegah terjadinya krisis manajemen
- Memfasilitasi berfikir kritis dan membuat keputusan secara fleksibel.
- Meningkatkan keterlibatan staf dan komunikasi
- Menjamin biaya yang efektif

C. Unsur-unsur Dalam Perencanaan

Perencanaan manajemen Keperawatan diawali dengan perumusan tujuan institusi/ organisasi yang dijelaskan dalam visi, misi, filosofi dan tujuan sebagai arah kebijakan organisasi.

1. Perumusan Visi

Istilah lain dari visi adalah mimpi, cita-cita. Visi merupakan dasar untuk membuat suatu perencanaan sehingga disusun secara singkat, jelas, dan mendasar serta ada batasan waktu untuk pencapaian. Visi merupakan pernyataan berisi tentang mengapa organisasi dibentuk. Contoh rumusan visi:

“Menjadi ruang perawatan bedah yang melakukan perawatan profesional dan unggul dalam manajemen perawatan luka modern di tahun 2018”

2. Perumusan Misi

Misi adalah uraian yang berisi pernyataan operasional guna mencapai visi yang telah ditetapkan

Contoh misi ruang perawatan bedah yang mengacu pada visi tersebut di atas:

- Memberikan asuhan keperawatan pada pasien bedah secara holistik bio-psiko-sosio-kultural dan spiritual.
- Melakukan tindakan perawatan luka dengan menggunakan manajemen perawatan luka modern.
- Menyediakan sarana prasarana untuk menunjang manajemen perawatan luka modern.
- Melakukan penelitian tindakan bedah berdasarkan perkembangan dan trend perawatan bedah.

3. Perumusan Filosofi

Filosofi adalah nilai-nilai dan keyakinan yang menyangkut keyakinan dan praktik keperawatan dalam suatu organisasi (Swanburg, 1999)

Filosofi keperawatan dalam perencanaan manajemen keperawatan adalah pandangan dasar tentang nilai-nilai, etika, dan keyakinan perawat. Filosofi ini menjadi kerangka dasar dalam praktik keperawatan.

Contoh :

Pasien adalah manusia yang merupakan makhluk holistik (bio- psiko-sosial-spiritual)

Pasien adalah individu yang unik dan bermartabat.

4. Perumusan Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai sebagai arah kebijakan bagi organisasi untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara mencapainya. Tujuan mutlak harus ada dalam organisasi pelayanan keperawatan. Untuk merumuskan tujuan yang baik harus memenuhi syarat antara lain (Mugianti, 2016):

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai sebagai arah kebijakan bagi organisasi untuk menentukan apa yang harus dilakukan dan bagaimana cara mencapainya. Tujuan mutlak harus ada dalam organisasi pelayanan keperawatan. Untuk merumuskan tujuan yang baik harus memenuhi syarat antara lain (Gillies, 1994)

Tujuan harus dapat menjelaskan arah

Tujuan harus memungkinkan untuk dicapai

Terukur artinya tujuan berisi ketentuan kuantitatif

Teradapat batasan waktu untuk pencapaian target

Pencapaian akhir setiap tujuan dapat diterima semua anggota organisasi

Kriteria dibuat untuk melihat seberapa besar tujuan tercapai

Setiap tujuan mendukung sasaran organisasi

Contoh Rumusan tujuan:

Meningkatkan kualifikasi tenaga perawatan yang handal dan kompeten dalam keperawatan bedah melalui pendidikan dan pelatihan.

Tujuan harus dapat menjelaskan arah

Tujuan harus memungkinkan untuk dicapai

D. Jenis Perencanaan dalam manajemen Keperawatan

Perencanaan dalam manajemen keperawatan berdasarkan jangka waktunya dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang

Perencanaan jangka pendek atau yang disebut sebagai perencanaan operasional adalah perencanaan yang dibuat untuk kegiatan dengan kurun

waktu satu jam sampai dengan satu tahun. Perencanaan jangka menengah adalah perencanaan yang dibuat untuk kegiatan dengan kurun waktu antara satu tahun sampai lima tahun (Marquis & Huston, 1998), sedangkan perencanaan jangka panjang atau sering disebut perencanaan strategis adalah perencanaan yang dibuat untuk kegiatan tiga sampai 20 tahun (Swanburg, 1999).

1. Rencana Harian: rencana yang berisikan setiap kegiatan perawat setiap harinya yang telah dibuat oleh kepala ruang, ketua tim atau perawat primer dan perawat pelaksana
2. Rencana Bulanan: rencana yang berisikan kegiatan perawat selama 1 bulan dan harus sinkron dengan rencana harian, biasanya dibuat oleh kepala ruang dan ketua tim atau perawat primer
3. Rencana Tahunan: rencana yang dibuat setiap tahun sekali berdasarkan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya, biasanya dibuat oleh kepala ruang saja.

Menurut waktu pembuatan perencanaan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu perencanaan reaktif dan perencanaan proaktif. Perencanaan reaktif yaitu perencanaan yang disusun ketika adanya masalah aktual yang dihadapi saat ini. Sedangkan perencanaan proaktif yaitu perencanaan yang disusun sebelum masalah timbul, antisipasi, sedangkan proses penyusunan perencanaan diklasifikasikan menjadi:

- a. Pendekatan Perkembangan yang menguntungkan (Profitabel Growth Approach) dan pendekatan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity dan Treat).
- b. Pendekatan Perkembangan yang menguntungkan (Profitabel Growth Approach) yaitu Perencanaan yang dilakukan dengan menganalisa sarana produksi yang dimiliki dan dihubungkan dengan kebutuhan yang muncul dari lingkungan.

Mengusahakan terjadinya keseimbangan antara sarana yang dimiliki dengan kebutuhan lingkungan. SALING BANGUN: SA (Sarana Produksi) LING (Lingkungan masyarakat), BANGUN (Perkembangan yang menguntungkan)



Gambar3.2: Proses Perencanaan dengan pendekatan yang menguntungkan

c. Pendekatan SWOT (Strength, Weakness, Opportunity and Threat)

Rencana disusun dengan proses perencanaan, dimulai dengan menganalisa faktor internal yang berhubungan dengan kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness), selanjutnya melakukan Analisa faktor eksternal yang berhubungan dengan peluang (opportunity) dan tekanan/ancaman (Threat). Setelah diketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman selanjutnya disusun rencana strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Rencana strategis harus diterjemahkan ke dalam rencana operasional yang mencantumkan target yang harus dicapai

Perencanaan keperawatan yang juga penting adalah perencanaan SDM khususnya SDM keperawatan. Adapun tujuan perencanaan SDM keperawatan adalah:

- 1) Menentukan kualitas dan kuantitas tenaga keperawatan contoh perencanaan kebutuhan perawat berdasarkan tingkat pendidikan (D3, Ners, Ners spesialis)
- 2) Peminatan SDM keperawatan sesuai minat, spesialisasi, dan kualifikasi pendidikan yang tepat.
- 3) Menjamin tersedianya tenaga keperawatan masa sekarang maupun masa mendatang
- 4) Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas
- 5) Mempermudah koordinasi integrasi dan sinkronisasi

Pada pembahasan dalam topik ini, perencanaan keperawatan yang juga penting adalah perencanaan SDM khususnya SDM Keperawatan. Dalam topik ini Anda diajak untuk berlatih bersama untuk melakukan perencanaan SDM Keperawatan yakni kegiatan merencanakan tenaga kerja agar sesuai

dengan kebutuhan organisasi serta efektif efisien dalam membantu terwujudnya tujuan (Hasibuan, 2005).

Adapun

Tujuan Perencanaan SDM Keperawatan adalah:

- 1) Menentukan kualitas dan kuantitas tenaga keperawatan contoh perencanaan kebutuhan perawat berdasarkan tingkat pendidikan (D III, Ners, NersSpesialist)
- 2) Peminatan SDM keperawatansesuai minat, spesialisasi, dan kualifikasi pendidikan yangtepat
- 3) Menjamin tersedianya tenaga keperawatan masa sekarang maupun masa mendatang
- 4) Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas
- 5) Mempermudah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

"Bagaimana menghitung kebutuhan SDM perawat tersebut?" Dalam pembahasan ini, Anda akan diajak berlatih menghitung dengan menggunakan beberapa formula. Penghitungan kebutuhan SDM perawat berbeda pada setiap tempat perawatan seperti di Ruang rawat inap penghitungan didasarkan pada tingkat klasifikasi dan tingkat ketergantungan pasien. Tingkat ketergantungan pasien dibedakan berdasarkan jenis kasus, rata-rata pasien per hari, jam perawatan yang diperlukan/hari/pasien, jam perawatan yang diperlukan/ruangan/hari, jam efektif perawat 7 jam/hari.

Tabel 3.1 berikut tentang rata-rata jam perawatan pasien per hari

No	Jenis /Kategori	Rata-rata per hari	Rata-rata jam perawatan pasien /hari	Jumlah jam perawatan pasein / hari
1	Pasien Interne	10	3,5	35
2	Pasien Bedah	8	4	32
3	Pasien Gawat	1	10	10
4	Pasien Anak	3	4.5	13.5
5	Pasien Kebidanan	1	2.5	2.5
	Jumlah	23		93

Berdasarkan tabel di atas maka bisa dihitung kebutuhan perawat dengan formula (Rumus). Jumlah tersebut perlu ditambah dengan faktor koreksi berupa loss day (hari libur, cuti dan hari besar dengan rumus sebagai berikut

Jumlah jam perawatan	= $\frac{93}{7} = 13$ perawat
Jam kerja efektif/shif	7

Karena tugas perawat tidak hanya mengerjakan tugas keperawatan, tapi juga non keperawatan (tugas administrasi), maka diberikan toleransi 25% dari jam pelayanan keperawatan dengan rumus

$\frac{\text{Jumlah hari minggu dalam 1 tahun} + \text{Cuti} + \text{hari besar} \times \text{jumlah perawat tersedia}}{\text{Jumlah hari kerja efektif}}$ $52 + 12 \times 13 = 3,5 \text{ orang}$
--

$\frac{\text{Jumlah tenaga perawat}}{100} + \frac{\text{loss day} \times 25}{100} = \frac{13}{100} + \frac{3,5 \times 25}{100} = 4,1 \text{ orang}$

Sehingga tenaga keperawatan yang dibutuhkan adalah sebagai berikut Jumlah tenaga keperawatan = tenaga yang tersedia + faktor koreksi = $13 + 3,5 + 4,1 = 20,6$ orang (dibulatkan ke atas karena berkaitan dengan orang menjadi 21 perawat)

E. Latihan Soal

Identifikasi visi misi di ruang rawat tempat Anda bekerja! cocokkan dengan konsep yang telah Anda pelajari, temukan beberapa hal berdasarkan analisa situasi, buat rencana sesuai konsep, pilih salah satu yang memungkinkan Anda buat!

Buat rencana kerja harian dinas pagi, sore dan malam (24 jam), rencana mingguan dan bulanan di ruang perawatan sesuai peran (kepala ruang, ketua tim dan perawat pelaksana

F. Rangkuman Materi

Perencanaan adalah esensial dalam manajemen keperawatan dan merupakan fungsi pertama dalam fungsi manajemen. Manajer keperawatan bertugas untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan dan mengevaluasi sarana dan prasarana yang tersedia untuk memberikan asuhan keperawatan kepada pasien.

Perencanaan bisa dibedakan menjadi perencanaan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, namun biasanya perencanaan keperawatan adalah rencana jangka pendek. Perencanaan jangka pendek dalam keperawatan meliputi rencana harian yang harus dikerjakan semua perawat, rencana bulanan yang dibuat oleh ketua tim/perawat primer, dan kepala ruang dan rencana tahunan yang dibuat oleh kepala ruang. Perencanaan kebutuhan tenaga/sumber daya manusia keperawatan dapat dihitung dari jumlah kasus yang dirawat dengan menggunakan rumus atau formula yang ada sesuai ketentuan.

G. Glosarium

A

Analisa Swot ; metode perencanaan strategid yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, mengevaluasi kekuatan, kelemahan,peuang dan ancaman dalam sebuah proyek atau bisnis

B

Berfikir Kritis : proses berpikir yang sistematis dan rasional untuk mengevaluasi informasi,mengidentifikasi masalah,dan membuat keputusan tepat dalam pemberian asuhan keperawatan

H

Handal : Dapat dipercaya dan memberikan hasil yang sama pada ujian dan percobaan yang berulang

K

Krisis Manajemen: proses dan pendekatan strategis yang digunakan oleh suatu organisasi untuk menghadapi, merespon, dan mengatasi situasi krisis yang dapat membahayakan kelangsungan hidup atau reputasi organisasi tersebut.

L

Loss Day: Hari yang tidak produktif

M

Mahluk holistic: makhluk yang memiliki keutuhan atau paduan dari berbagai unsur seperti biologis, psikologis, sosial, dan spiritual.

H. Daftar Pustaka

- Gitosudarmo, Indriyo. 2001. Manajemen strategi. Yogyakarta: BPFE YOGYAKARTA
- Hasibuan , Malayu S.P,2005.Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi. Bumi Aksara. Jakarta.
- Maquis, B. L., & Huston, C. J. (2017). Leadership Roles and Management Functions in Nursing: Theory and Application. In Wolters Kluwer Health (9th ed., Vol. 59).
- Marquis, BL & Huston, C.J (1998), Management Decision Making For Nurses, 124 Cases Studies, 3 Ed. Philadelphia: JB Lippincott
- Nursalam. (2013). Manajemen Keperawatan, Aplikasi Dalam Praktik Keperawatan Profesional. Jakarta: Salemba Medika
- Swanburg, Russel.C. & Swanburg, Richard.J. (1999). Introductory Management and Leadership for Nurses. Second Edition. Canada : Jones and Bartlett Publisher
- Swansburg, RC (1999) Introductory Management and Leadership for Nurses. London : Jones and Bartlett Publishers, Inc

BAB 4

PENGARAHAN DALAM KEPERAWATAN

Tujuan Intruksional: Mampu memberikan asuhan keperawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mengutamakan keselamatan klien dan mutu pelayanan.

Capaian Pembelajaran: Mampu memahami pengarahan dalam manajemen asuhan keperawatan.

Pendahuluan

Menurut Organisasi Kesehatan Pan Amerika (2004), perawat bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesehatan primer di rumah sakit, menjalankan peran penuh selama 24 jam sepanjang tahun, dan memiliki dampak pada kualitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan kesehatan dan layanan terkait. Ada kemungkinan bahwa perawat akan secara signifikan meningkatkan kualitas rumah sakit jika mereka dapat merasa puas dengan pekerjaan mereka dan jika mereka mampu melaksanakan tanggung jawab profesional mereka. Pihak manajemen menempatkan prioritas tinggi pada kepuasan perawat untuk menjamin bahwa mereka mampu menjalankan pekerjaan mereka secara efektif di dalam organisasi (Foong, 2001, sebagaimana dikutip dalam Abdullah dan Nahla, 2006; Schermerhorn, Hunt, dan Osborn, 2002).

Menurut Davis dan Newstorm (1985) dan Robin (2003), kepuasan kerja didefinisikan sebagai disposisi umum individu terhadap kesesuaian tanggung jawab pekerjaan mereka. Luthans (2005) berpendapat bahwa kebahagiaan pekerja adalah hasil langsung dari penilaian mereka terhadap kualitas pekerjaan mereka. Respon emosional yang dimiliki perawat terhadap perspektif mereka, yang ditunjukkan dengan ekspresi kegembiraan dengan profesi mereka, adalah apa yang menjadi kepuasan kerja. Ada korelasi antara posisi kepemimpinan kepala ruangan dan ketua tim dengan tingkat kepuasan kerja. Menurut McNamara (1999, sebagaimana dikutip dalam Huber 2006), Marquist dan Huston (2000), Hunt dan Osborn (2002), dan Rowland dan Rowland (1997), pengarahan atau koordinasi adalah metode yang mewakili cara membimbing kelompok, mendorong moral yang tinggi dan motivasi karyawan yang kuat, mendorong kerja yang tekun, dan memelihara hubungan interpersonal untuk meningkatkan efektivitas kelompok. Kapasitas kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala bangsal dan ketua tim adalah komponen utama yang berkontribusi pada peningkatan

tingkat kepuasan kerja di bangsal MPKP. Keliat et al. (2006) dan Schermerhorn et al. (2002) menyatakan bahwa tanggung jawab pengarahannya mencakup tindakan yang terkait dengan operasi, prosedur yang terkait dengan kegiatan pra-konferensi dan pasca-konferensi, lingkungan yang menstimulasi, supervisi, dan pendelegasian.

Uraian Materi

A. Konsep Dasar Pengarahan

Dalam konteks operasi organisasi perawatan kesehatan, sumber daya manusia merupakan jenis modal dasar. Melalui penggunaan fungsi mobilisasi, seorang manajer perawat diwajibkan untuk mengelola sumber daya manusia dengan benar untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam Siagian (2007), Henry Fayol menggunakan istilah "*commanding*" atau "*directing*" untuk menggambarkan gerakan ini. Namun, George R. Terry (1993) menggunakan istilah "*actuating*," yang mengacu pada upaya atasan untuk mendorong bawahan. Dalam ranah kepemimpinan otoritatif, pengarahan hadir sebagai dinamika hubungan. Memotivasi bawahan untuk menyumbangkan upaya mereka menuju pencapaian tujuan perusahaan melalui upaya bersama adalah cara untuk memotivasi mereka. Menurut Muninjaya (1999), kepemimpinan dalam organisasi secara inheren kompleks karena beragamnya perilaku yang ditunjukkan oleh orang-orang.

B. Tujuan Pengarahan dalam Manajemen Keperawatan

Muninjaya (1999) mengusulkan lima tujuan yang harus dicapai oleh peran kepemimpinan:

1. Meningkatkan efektivitas upaya bersama.

Dimungkinkan untuk meningkatkan komunikasi antara atasan dan bawahan, dan juga dimungkinkan untuk mencapai efisiensi kerja yang lebih besar karena kepala ruangan secara aktif terlibat dalam proses memobilisasi bawahan. Sebagai contoh, pemantauan tindakan keperawatan oleh kepala ruangan menghasilkan pengurangan kesalahan yang cukup besar, yang pada gilirannya membantu menghemat persediaan, peralatan, dan waktu. Hal ini berbeda dengan konsekuensi yang timbul ketika terjadi kegagalan untuk memberikan pengawasan.

2. Meningkatkan kemampuan dan pengetahuan staf.

Mereka yang bertanggung jawab untuk mengarahkan bertanggung jawab atas kegiatan seperti supervisi dan pendelegasian. Para bawahan diberi kemampuan untuk melaksanakan tugas secara mandiri sesuai dengan komitmen mereka melalui partisipasi dalam kegiatan-kegiatan ini.

3. Menumbuhkan rasa memiliki dan apresiasi terhadap pekerjaan seseorang.

Pengarahan yang diberikan oleh kepala ruangan sebagai reaksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh seorang perawat, dorongan yang diberikan

selama masa motivasi yang menurun, dan pujian yang diberikan untuk kinerja yang patut dicontoh semuanya dapat berkontribusi pada peningkatan rasa memiliki dan kepuasan kerja.

4. Berusaha untuk menciptakan lingkungan di tempat kerja yang meningkatkan motivasi dan kinerja anggota staf Anda.

Untuk meningkatkan motivasi kerja perawat pelaksana dan meningkatkan kinerja mereka, kepemimpinan yang adil diperlukan. Seorang pemimpin yang sukses menumbuhkan lingkungan yang mendukung dan menciptakan hubungan interpersonal yang harmonis.

5. Pengarahan bekerja menuju tujuan memfasilitasi evolusi organisasi menjadi entitas yang lebih dinamis.

Semua perawat akan mendapatkan manfaat dari pengarahannya yang disampaikan oleh ketua ruangan, yang akan memfasilitasi pengembangan profesional mereka dan, sebagai hasilnya, memungkinkan organisasi untuk mengalami pertumbuhan yang dinamis.

C. Kegiatan Manajemen Keperawatan Sebagai Fungsi Pengarahan

Tindakan untuk meyakinkan anggota staf agar mengambil tindakan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan disebut sebagai pengarahannya, yang juga dikenal sebagai penggerakannya. Manajer perawat perlu memiliki pemahaman yang komprehensif dan mempertimbangkan sejumlah faktor agar dapat secara efektif membimbing dan menginspirasi bawahan. Di antara komponen-komponen ini adalah Komunikasi, Kepemimpinan, dan Motivasi di Tempat Kerja.

Konsep komunikasi dan motivasi akan dibahas lebih dalam di bawah ini.

1. Motivasi

Menurut Stoner dan Freeman, motivasi adalah karakteristik psikologis manusia yang memberi kontribusi yang meningkat komitmen seseorang (termasuk faktor-faktor yang menyebabkan, menyalurkan dan mempertahankan tingkah laku dalam arah tekad tertentu).

Motivasi adalah fitur psikologis manusia yang mengarah pada komitmen individu yang lebih besar, seperti yang dinyatakan oleh Stoner dan Freeman. Faktor-faktor yang menciptakan, menyalurkan, dan mempertahankan perilaku dalam arah keputusan tertentu termasuk dalam definisi motivasi.

Untuk memiliki pemahaman yang lengkap tentang motivasi, ada tiga aspek penting yang harus dipertimbangkan, menurut Stanford. Aspek-aspek ini termasuk interaksi antara kebutuhan, dorongan, dan tujuan.

Ketika seseorang merasa bahwa mereka kehilangan sesuatu, baik secara medis maupun mental, mereka dikatakan memiliki kebutuhan.

- a. Kebutuhan adalah hasil dari persepsi ini.
- b. Dorongan: jalan yang mengarah pada keberhasilan suatu kebutuhan.
- c. Tujuan adalah kulminasi dari siklus motivasi.

Tergantung pada bentuk yang diambilnya, motivasi terdiri dari keduanya:

- a. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri seseorang.
- b. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang berasal dari luar diri seseorang.
- c. Motivasi mendesak ditandai oleh fakta bahwa ia terwujud secara bersamaan, dengan cara yang mengejutkan, dan dalam waktu yang sangat singkat.

Karena fakta bahwa layanan keperawatan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kualitas perawatan kesehatan secara keseluruhan, motivasi adalah komponen penting dari peran pengarahan dalam keperawatan. Kualitas layanan keperawatan akan berdampak negatif jika kinerja perawat di bawah standar; di sisi lain, jika kinerja perawat memuaskan, kualitas layanan keperawatan akan meningkat. Memiliki kinerja perawat yang baik tidak hanya karena perawat bersemangat untuk melaksanakan dan menyelesaikan tindakan keperawatan secara teratur, tetapi yang paling penting adalah perawat melaksanakan tindakan berdasarkan motivasi diri mereka sendiri.

Kemampuan seorang perawat untuk melaksanakan tugas secara efektif dan efisien akan sangat dipengaruhi oleh tingkat dorongan internal yang tinggi yang mereka miliki. Pernyataan bahwa motivasi adalah apa yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia untuk bersedia bekerja keras dan dengan gembira untuk mencapai hasil yang ideal didukung oleh Hasibuan (2005), yang berpendapat bahwa motivasi adalah apa yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung mereka.

Selanjutnya, menurut Wlodkowski (1985), motivasi adalah suatu kondisi yang menghasilkan atau melahirkan tindakan tertentu, serta suatu kondisi yang memberikan arah dan ketekunan perilaku tertentu. Untuk merangsang kinerja perawat dalam pemberian perawatan keperawatan yang efisien dan efektif, seorang manajer perawat dituntut untuk mengakui motivasi dan kebutuhan tenaga kerja di dalam organisasi.

2. Komunikasi

Menurut Tappen (1995), komunikasi adalah segala sesuatu yang terjadi antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan mencakup berbagi ide, emosi, pandangan, dan pemberian saran. Memiliki kemampuan untuk menghasilkan dan mengkomunikasikan pesan dalam gaya yang sederhana dan

lugas, sehingga orang lain dapat memahami dan menerimanya, adalah suatu bentuk seni.

Setiap komunikasi harus memiliki pengirim, pesan, dan penerima pesan masing-masing. Dalam proses ini, lingkungan internal dan eksterior mengambil bagian. Lingkungan eksterior, yang meliputi cuaca, suhu, faktor daya, dan waktu, serta lingkungan interior, yang meliputi kualitas seperti nilai-nilai, keyakinan, temperamen, dan tingkat stres.

Berikut ini adalah beberapa contoh bagaimana komunikasi dapat digunakan dalam perawatan keperawatan:

a. Saat Timbang Terima

- 1) Penting untuk memiliki komunikasi yang jelas tentang tuntutan klien, intervensi yang telah dilakukan dan yang belum dilakukan, serta respons pasien.
- 2) Saat perawat berjalan di samping perawat lain dan menyampaikan status pasien dengan tepat saat mereka berada di dekat pasien, perawat menyerahkan.

b. Interview/Anamnesa

- 1) Pertukaran informasi dengan tujuan khusus untuk memperoleh informasi tentang kondisi pasien dan melaksanakan kegiatan yang benar.
- 2) Selama proses pemberian perawatan keperawatan, tugas yang selalu dilakukan oleh perawat yang merawat pasien.

Prinsip yang perlu diterapkan perawat :

- 1) Komunikasi yang terlalu formal atau tidak pantas harus dihindari.
- 2) Saat bekerja di lingkungan yang bising, penting untuk menghindari gangguan dan gangguan.
- 3) Saat menjawab, cobalah untuk tidak hanya menggunakan "ya" dan "tidak" karena ini akan membuat komunikasi lebih sulit.
- 4) Pastikan Anda tidak mengambil alih diskusi.
- 5) Jauhi rintangan pribadi.

3. Komunikasi Melalui Komputer

- a. Saat ini, komputer adalah alat komunikasi yang cepat dan tepat di bidang administrasi perawat.
- b. Perawat lain akan lebih mudah mengenali masalah pasien dan memberikan perawatan yang sesuai jika mereka dapat menuliskan data pasien di komputer.
- c. Jika perawat mengalami kesulitan menangani masalah pasien, mereka dapat segera mengakses informasi terbaru dengan memanfaatkan internet, yang dimungkinkan oleh komputer.

- d. Di satu sisi, perawat dituntut untuk menjalin hubungan antara apa yang dikatakan pasien dengan individu lain untuk mengumpulkan informasi. Di sisi lain, perawat berkewajiban untuk menjunjung tinggi janji mereka untuk menjaga kerahasiaan pasien kepada individu lain.

4. Komunikasi melalui Sentuhan

- a. Teknik yang membantu memperkuat ikatan yang ada antara perawat dan pasien.
- b. Mungkin bagi perawat untuk menggunakan sentuhan sebagai semacam pengobatan atau aktivitas independen untuk membantu pasien mengatasi masalah.

5. Dokumentasi sebagai Alat Komunikasi

Dalam hal pemberian perawatan keperawatan, dokumentasi berfungsi sebagai dokumen paten, metode komunikasi dengan tim kesehatan lain, dan alat yang digunakan dalam komunikasi keperawatan untuk memvalidasi perawatan keperawatan. Berikut ini adalah beberapa keuntungan berkomunikasi dalam dokumentasi:

- a. Dapat digunakan kembali untuk berbagai aplikasi yang bermanfaat
- b. Memberitahukan perawat dan tenaga medis lainnya tentang tindakan yang telah diambil pada pasien dan tindakan yang akan diambil di masa depan.

Penting untuk memiliki komunikasi yang efektif agar dapat secara efektif memobilisasi atau memimpin bawahan. Adalah mungkin untuk mencegah kesalahpahaman dengan memastikan bahwa manajemen dan pelaksana perawat memiliki komunikasi yang efektif satu sama lain. Komunikasi dapat terjadi dalam orientasi vertikal (atas-bawah) atau horizontal (ke samping). Komunikasi yang terbuka dan jujur antara dua orang atau lebih dianggap sebagai komunikasi yang baik. Tujuan dari komunikasi semacam ini adalah untuk mengekspresikan dan menyampaikan pesan-pesan penting baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Komunikasi verbal dan nonverbal adalah kedua bentuk komunikasi.

Bahkan ketika pemimpin tidak ada di sana, diharapkan dari seorang manajer perawat bahwa mereka akan dapat mengikuti perkembangan terbaru dalam teknologi informasi. Ini dapat dicapai dengan menggunakan berbagai media kontemporer dengan tujuan memperoleh pengetahuan dan berinteraksi secara efisien dengan orang lain. Implementasi komunikasi di bangsal rawat inap dilakukan melalui berbagai kegiatan, termasuk kegiatan serah terima, konferensi (sebelum, tengah, dan sesudah), diskusi kasus, putaran perawat, rapat, dan kegiatan lainnya.

D. Rambu-rambu Kegiatan Pengarahan Menurut Douglas

Menurut Douglas, berikut ini adalah sepuluh aturan untuk mengarahkan kegiatan yang harus Anda ketahui karena dianggap penting:

1. Tetapkan tujuan untuk membimbing yang dapat dicapai.
2. Jadikan hal-hal yang paling penting dan sensitif terhadap waktu sebagai prioritas pertama Anda.
3. Pastikan koordinasi yang efektif dengan berbagai unit kerja yang berbeda
4. Tentukan apa yang menjadi tanggung jawab setiap posisi untuk memastikan bahwa setiap orang di staf bekerja dengan tepat dan adil.
5. Pastikan bahwa Anda selalu beroperasi dengan informasi ilmiah yang andal dan mutakhir dengan membangun budaya keselamatan di tempat kerja dan budaya pendidikan berkelanjutan.
6. Pemberian insentif dan hukuman yang eksplisit dan kuat akan membantu anggota mengembangkan tingkat kepercayaan diri yang tinggi.
7. Untuk membuat pekerjaan yang harus dilakukan oleh staf lebih mudah dikelola, prosedur operasi standar harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang mudah dibaca dan dipahami.
8. Protokol darurat harus dijelaskan, baik untuk pasien maupun untuk jenis keadaan darurat lainnya.
9. Berikan pedoman yang tidak ambigu, ringkas, dan spesifik.
10. Manfaatkan manajemen kendali yang efektif untuk melakukan evaluasi yang sering dan rutin terhadap kualitas layanan.

E. Indikator Pengarahan yang Baik

1. Dengan memberikan instruksi kepada ketua tim tentang tugas dan dengan memuji anggota tim yang melaksanakan tanggung jawab mereka dengan cara yang efektif
2. Menawarkan dorongan untuk tujuan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan sikap seseorang
3. Penyebaran informasi tentang hal-hal yang dipandang signifikan dan terkait dengan perawatan keperawatan untuk pasien dan layanan keperawatan di bangsal
4. Memfasilitasi partisipasi bawahan dari awal hingga akhir kegiatan Memberikan bantuan kepada bawahan yang mengalami kesulitan melakukan tugas mereka
5. Kerja sama antara anggota tim harus ditingkatkan.

F. Supervisi Keperawatan

Menurut definisi yang diberikan oleh (Kholid, 2011), supervisi didefinisikan sebagai observasi atau supervisi langsung dari pelaksanaan pekerjaan biasa oleh seorang individu. Jauh lebih mudah bagi perawat untuk melaksanakan tugas mereka ketika mereka diawasi secara langsung. Seorang anggota organisasi diberi wewenang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang menjadi tanggung jawab manajer perawat melalui supervisi.

Lingkungan kerja yang nyaman adalah tujuan dari supervisi, yang mencakup lingkungan fisik dan suasana kerja di antara staf keperawatan dan anggota staf lainnya, serta jumlah persediaan dan kelayakan fasilitas untuk memfasilitasi implementasi tugas. Tujuan supervisi adalah untuk mencapai kondisi kerja yang paling optimal. [Swanburg, 2009] mengidentifikasi hal-hal berikut sebagai tujuan supervisi:

- 1 Selain area kerja dan tugas itu sendiri, penting untuk memperhatikan anggota unit organisasi internal.
- 2 Perhatikan rencana, tindakan, dan penilaian yang dibuat tentang pekerjaannya.
- 3 Orientasi, pelatihan, dan supervisi yang dipersonalisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu harus digunakan untuk meningkatkan keterampilan kerja, dan kemudian keterampilan tersebut harus diterjemahkan ke dalam kemampuan keperawatan.

G. Latihan Soal

1. Sebutkan lima tujuan yang harus dicapai dalam peran kepemimpinan!
2. Apa yang dimaksud dengan motivasi?
3. Sebutkan beberapa contoh bagaimana komunikasi dapat digunakan dalam keperawatan!
4. Sebutkan sepuluh aturan dalam mengarahkan kegiatan menurut Douglas!
5. Apa yang dimaksud dengan supervisi keperawatan?

H. Rangkuman Materi

Dalam ranah kepemimpinan otoritatif, pengarahan hadir sebagai dinamika hubungan. Memotivasi bawahan untuk menyumbangkan upaya mereka menuju pencapaian tujuan perusahaan melalui upaya bersama adalah cara untuk memotivasi mereka.

Ada lima tujuan yang harus dicapai oleh peran kepemimpinan: meningkatkan efektivitas upaya bersama; meningkatkan kemampuan dan pengetahuan staf; menumbuhkan rasa memiliki dan apresiasi terhadap pekerjaan seseorang; berusaha

untuk menciptakan lingkungan di tempat kerja yang meningkatkan motivasi dan kinerja anggota staf anda; pengarahan bekerja menuju tujuan memfasilitasi evolusi organisasi menjadi entitas yang lebih dinamis.

Motivasi adalah karakteristik psikologis manusia yang memberi kontribusi yang meningkat komitmen seseorang (termasuk faktor-faktor yang menyebabkan, menyalurkan dan mempertahankan tingkah laku dalam arah tekad tertentu).

Komunikasi adalah segala sesuatu yang terjadi antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan mencakup berbagi ide, emosi, pandangan, dan pemberian saran.

Supervisi didefinisikan sebagai observasi atau supervisi langsung dari pelaksanaan pekerjaan biasa oleh seorang individu. Tujuan supervisi adalah untuk mencapai kondisi kerja yang paling optimal.

I. Daftar Pustaka

- Abdullah, M.A., & Nahla, A.K. (2006). Job satisfaction among primary health care physicians and nurses in Al-Madinah Al-Munawwara. *The Journal of the Egyptian Public Health Association (JEPHAss.)*, 81 (3&4), 165-180.
- Barry, L.M., & Houston, J.P. (1998). *Psychology at work: An introduction to industrial and organizational psychology* (2nd Ed.). USA: Wm.c.Brown Communication.
- Davis, K., & Newstorm, J.W. (1985). *Human behavior at work: Organizational behavior* (7th Ed.). USA: McGraw-Hill, Inc.
- Huber, D.L. (2006). *Leadership and nursing care management* (3rd Ed.). USA: Elsevier.
- Keliat, et al. (2006). *Modul model praktek keperawatan profesional jiwa*. Jakarta: Fakultas Keperawatan Universitas Indonesia dan World Health Organization Indonesia.
- Luthans, F. (2005). *Organizational behavior*. USA: The McGraw-Hills Companies, Inc.
- Nursalam. (2014). *Manajemen keperawatan: Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional* (Edisi 4). Salemba Medika.
- Pan American Health Organization. (2004). *Nursing and midwifery services contributing to equity, access, coverage, quality, and sustainability in the health services*. Pan American Health Organization. Diperoleh dari <http://www.paho.org/english/ad/ths/os/nur-svcs-eng.pdf>.

Rowland, H.S., & Rowland, B.L. (1997). Nursing administration hand book (4th Ed.). Maryland: Aspen Publisher, Inc.

Schermerhorn, J.R., Hunt, J.G., & Osborn, R.N. (2002). Organizational behavior (7th Ed.). USA: John Wiley & Sons, Inc.

Sullivan, Eleanor, J. (2012). Effective leadership and manajemen nursing. 8 th ed., p: cm

Swansburg, R.C & Swansburg, J. R. (2006). Introductory Management & Leadership for Nurses. Toronto: Jones And Bartlert Pub.Ca. 7.

BAB 5

KONSEP PRAKTIK KEPERAWATAN BERBASIS BUKTI (EVIDENCE-BASED NURSING PRACTICE)

Tujuan Intruksional dan Capaian Pembelajaran

Tujuan Intruksional :

1. Memahami definisi Pengertian Praktik Keperawatan Berbasis Bukti
2. Memahami Tujuan Praktik Keperawatan Berbasis Bukti dalam layanan keperawatan
3. Memahami Komponen Utama dalam Praktik Keperawatan Berbasis Bukti (EBNP)
4. Memahami Langkah-Langkah dalam Praktik Keperawatan Berbasis Bukti
5. Memahami Manfaat EBNP
6. Tantangan dalam Implementasi EBNP
7. Strategi Implementasi EBNP

Capaian Pembelajaran :

Memahami dan menerapkan Praktik Keperawatan Berbasis Bukti dalam layanan asuhan keperawatan dari berbagai konsep keilmuan

Pendahuluan

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, termasuk keperawatan, telah mengalami kemajuan pesat dalam beberapa dekade terakhir. Sebagai profesi yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan kesehatan manusia, keperawatan dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman, memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan tidak hanya berdasarkan pengalaman atau kebiasaan semata, tetapi juga berdasarkan bukti ilmiah yang sah. Inilah yang melatarbelakangi pentingnya Praktik Keperawatan Berbasis Bukti (Evidence-Based Nursing Practice, EBNP).

EBNP merupakan pendekatan sistematis dalam pengambilan keputusan klinis yang mengintegrasikan bukti terbaik dari penelitian ilmiah, keahlian klinis, serta nilai dan preferensi pasien. Penerapan EBNP bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan dengan cara memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan memiliki dasar ilmiah yang jelas, relevan, dan efektif. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, tetapi juga memperkuat kedudukan profesi perawat dalam sistem kesehatan yang modern dan kompleks. Meskipun

keperawatan terus berkembang, tantangan yang dihadapi masih cukup besar. Di antaranya adalah:

1. Kurangnya Standar Praktik yang Seragam: Variasi dalam pelaksanaan asuhan keperawatan sering kali menyebabkan perbedaan hasil pelayanan di berbagai fasilitas kesehatan.
2. Keterbatasan Akses terhadap Bukti Ilmiah: Tidak semua perawat memiliki akses yang memadai terhadap jurnal ilmiah, pedoman praktik berbasis bukti, atau sumber daya lainnya.
3. Minimnya Pelatihan: Sebagian besar perawat belum sepenuhnya memahami metode pencarian, analisis, dan penerapan bukti ilmiah ke dalam praktik sehari-hari.
4. Budaya Resistensi terhadap Perubahan: Implementasi EBNP sering kali menghadapi hambatan dari individu atau organisasi yang lebih nyaman dengan metode tradisional.

Tantangan-tantangan ini menegaskan pentingnya pendidikan yang terstruktur dan berorientasi pada peningkatan kemampuan analisis kritis serta penerapan praktik berbasis bukti dalam pendidikan keperawatan.

Relevansi Buku Ini

Buku ajar ini hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Buku ini disusun sebagai referensi utama bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi keperawatan untuk memahami dan mengaplikasikan EBNP dalam berbagai tatanan pelayanan kesehatan. Secara khusus, buku ini membahas:

1. Prinsip-Prinsip Dasar EBNP: Konsep teoretis dan elemen kunci yang menjadi dasar dalam pelaksanaan EBNP.
2. Langkah-Langkah Sistematis dalam EBNP: Panduan praktis mulai dari identifikasi masalah klinis, pencarian bukti, penilaian kualitas bukti, hingga implementasi dan evaluasi hasil.
3. Studi Kasus dan Contoh Nyata: Ilustrasi penerapan EBNP dalam berbagai situasi klinis untuk mempermudah pemahaman dan aplikasi.
4. Strategi Mengatasi Hambatan EBNP: Saran praktis untuk mengatasi tantangan implementasi di lapangan.

Buku ajar ini bertujuan untuk:

1. Membekali mahasiswa dan praktisi keperawatan dengan pemahaman mendalam tentang konsep EBNP.
2. Meningkatkan keterampilan analisis kritis dalam mengevaluasi dan menggunakan bukti ilmiah.
3. Memberikan panduan implementasi EBNP dalam asuhan keperawatan di berbagai tatanan pelayanan kesehatan.

4. Mendukung pengembangan profesionalisme dan inovasi dalam praktik keperawatan.

Kami berharap buku ini dapat menjadi panduan yang bermanfaat dalam mendukung pengembangan ilmu keperawatan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mendorong profesionalisme di bidang keperawatan. Kami juga berharap bahwa melalui penerapan EBNP, profesi perawat dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semoga buku ini tidak hanya memberikan wawasan baru, tetapi juga menginspirasi pembaca untuk terus belajar, berinovasi, dan memberikan asuhan keperawatan yang terbaik berdasarkan bukti ilmiah.

Uraian Materi

Praktik Keperawatan Berbasis Bukti dalam layanan asuhan keperawatan

A. Berbagai pandangan tentang Definisi Praktik Keperawatan Berbasis Bukti.

1. Praktik keperawatan berbasis bukti

(Evidence-Based Nursing Practice/ EBNP) adalah pendekatan dalam memberikan asuhan keperawatan yang mengintegrasikan:

2. Melnyk & Fineout-Overholt (2018):

Praktik Keperawatan Berbasis Bukti adalah penggunaan bukti ilmiah terbaik yang tersedia, pengalaman klinis, serta preferensi dan nilai pasien dalam pengambilan keputusan klinis.

3. Craig & Smyth (2019):

EBNP adalah proses sistematis yang bertujuan menggabungkan penelitian yang relevan, keterampilan profesional, dan kebutuhan pasien untuk menghasilkan asuhan yang aman dan efektif.

4. Nursalam (2016)

dalam bukunya "*Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan*", Praktik Keperawatan Berbasis Bukti adalah proses pengambilan keputusan klinis yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik, keahlian klinis, dan preferensi pasien untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan.

B. Elemen Utama Evidence-Based Nursing Practice (EBNP):

1. Bukti terbaik dari penelitian ilmiah.
2. Pengalaman atau keahlian klinis perawat.
3. Kebutuhan, nilai, dan preferensi pasien.

C. Tujuan Praktik Keperawatan Berbasis Bukti

1. **Meningkatkan kualitas asuhan keperawatan** melalui penggunaan intervensi yang terbukti efektif.
2. **Mengurangi variasi praktik keperawatan** dengan menerapkan standar berbasis bukti.
3. **Meningkatkan keamanan pasien** melalui intervensi yang valid dan dapat diandalkan.
4. **Meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kesehatan** dengan mengurangi prosedur yang tidak perlu.

D. Prinsip-Prinsip Dasar Evidence-Based Nursing Practice (EBNP)

1. Berorientasi pada Pasien (Patient-Centered Care):

Fokus pada kebutuhan, preferensi, dan nilai-nilai pasien dalam setiap keputusan klinis.

2. Berdasarkan Bukti Terbaik:

Penggunaan hasil penelitian yang valid dan mutakhir sebagai dasar pengambilan keputusan.

3. Melibatkan Pengalaman Klinis:

Pengalaman perawat dalam praktik lapangan sangat penting untuk melengkapi bukti ilmiah.

4. Pengambilan Keputusan Bersama (Shared Decision-Making):

Kolaborasi antara pasien dan perawat dalam merencanakan dan mengimplementasikan asuhan.

E. Model Implementasi Evidence-Based Nursing Practice (EBNP)

1. Model Iowa: Model ini terdiri dari beberapa langkah untuk menerapkan EBNP, dimulai dari identifikasi masalah klinis, peninjauan literatur, pengembangan rekomendasi praktik, hingga evaluasi hasil. Model ini berfokus pada pendidikan dan kolaborasi multidisiplin dalam penerapan EBNP.
2. Model ACE Star (Stevens, 2012):
 - a. Discovery: Penemuan bukti dari penelitian.
 - b. Summary: Penyusunan dan penyederhanaan bukti menjadi panduan klinis.
 - c. Translation: Penerapan panduan klinis dalam praktik sehari-hari.
 - d. Integration: Mengintegrasikan bukti dalam keputusan klinis.
 - e. Evaluation: Menilai dampak dari penerapan EBNP.

F. Jenis Bukti dalam EBNP (Hierarchy of Evidence)

Berdasarkan Melnyk & Fineout-Overholt (2018), bukti dapat diurutkan dalam hierarki, dari yang paling kuat hingga yang kurang kuat:

1. Level I: Bukti dari meta-analisis atau tinjauan sistematis dari uji acak terkontrol (Randomized Controlled Trials - RCTs).
2. Level II: Bukti dari satu uji acak terkontrol.
3. Level III: Bukti dari penelitian kuasi-eksperimental.
4. Level IV: Bukti dari studi observasional, seperti penelitian kohort atau kasus-kontrol.
5. Level V: Bukti dari studi deskriptif atau kualitatif.
6. Level VI: Bukti dari laporan kasus atau opini ahli.

G. Langkah-Langkah dalam Praktik Keperawatan Berbasis Bukti

1. Mengidentifikasi Masalah Klinis

Contoh: Mengapa pasien dengan luka diabetes memiliki tingkat penyembuhan yang lambat?

2. Menyusun Pertanyaan Klinis dengan Metode PICO

P (Population): Pasien dengan luka diabetes.

I (Intervention): Penggunaan balutan modern berbasis hidrogel.

C (Comparison): Balutan tradisional.

O (Outcome): Penyembuhan luka lebih cepat.

3. Mencari Bukti

Menggunakan sumber terpercaya seperti jurnal medis, pedoman klinis, dan database penelitian (PubMed, Cochrane).

4. Menilai Kualitas Bukti

Validitas, reliabilitas, dan relevansi bukti.

5. Mengintegrasikan Bukti ke dalam Praktik

Memodifikasi intervensi klinis berdasarkan hasil bukti.

6. Mengevaluasi Hasil

Apakah intervensi berbasis bukti berhasil meningkatkan hasil klinis pasien?

H. Manfaat Praktik Keperawatan Berbasis Bukti (EBNP)

1. Meningkatkan keterampilan analisis kritis perawat.
2. Memberikan asuhan keperawatan yang aman, efektif, dan efisien.
3. Mengurangi risiko kesalahan klinis.
4. Meningkatkan kepuasan pasien dan keluarga.

I. Tantangan dalam Implementasi Praktik Keperawatan Berbasis Bukti(EBNP)

Kurangnya akses ke sumber bukti ilmiah.

1. Keterbatasan waktu dan beban kerja perawat.
2. Kurangnya pelatihan tentang EBNP.
3. Resistensi terhadap perubahan praktik.

J. Strategi Implementasi Evidence-Based Nursing Practice (EBNP)

1. **Edukasi Berkelanjutan:** Menyediakan pelatihan dan workshop untuk meningkatkan kemampuan perawat dalam mencari, mengevaluasi, dan menerapkan bukti ilmiah.
2. **Penggunaan Teknologi:** Mengintegrasikan alat digital seperti aplikasi ponsel atau database online yang memudahkan akses ke bukti ilmiah terkini.

3. **Pendekatan Multidisiplin:** Bekerja sama dengan profesi kesehatan lain, seperti dokter dan apoteker, untuk menerapkan praktik berbasis bukti.
4. **Dukungan Manajemen:** Manajemen rumah sakit atau institusi kesehatan harus mendukung penerapan EBNP dengan menyediakan sumber daya yang memadai, baik dari segi waktu maupun akses informasi.

K. Studi Kasus Sukses Implementasi EBNP

1. **Pengurangan Infeksi Nosokomial:** Sebuah rumah sakit di Amerika Serikat menerapkan pedoman berbasis bukti untuk mencuci tangan dan desinfeksi peralatan medis. Hasilnya, terjadi penurunan signifikan dalam infeksi nosokomial selama periode dua tahun.
2. **Meningkatkan Pengelolaan Nyeri Pasien Kanker:** Implementasi program EBNP yang melibatkan penggunaan obat analgesik yang tepat, serta terapi non-farmakologis berbasis bukti, berhasil meningkatkan kualitas hidup pasien kanker terminal.

L. Contoh Kasus Penerapan Evidence-Based Nursing Practice (EBNP)

Kasus 1: Mencegah Ulkus Tekanan pd Pasien Lansia yang Terbaring Lama

1. Pertanyaan klinis: Bagaimana cara terbaik untuk mencegah ulkus tekanan pada pasien lansia yang imobilitas?
2. Pencarian bukti: Studi terbaru menunjukkan bahwa rotasi posisi pasien setiap dua jam lebih efektif dibandingkan penggunaan kasur tekanan rendah saja.
3. Aplikasi klinis: Menggunakan intervensi rotasi posisi yang lebih terstruktur dan dikombinasikan dengan kasur khusus untuk mengurangi insiden ulkus tekanan.
4. Evaluasi hasil: Setelah implementasi, terdapat penurunan signifikan dalam insiden ulkus tekanan.

Kasus 2:

Seorang pasien dengan luka diabetes memerlukan intervensi untuk mempercepat penyembuhan luka.

Langkah Penerapan:

1. **Identifikasi masalah:** Luka pasien lambat sembuh meski sudah mendapat perawatan konvensional.
2. **Pertanyaan PICO:**
 - P:** Pasien dengan luka diabetes.
 - I:** Penggunaan balutan berbasis hidrogel.
 - C:** Perawatan luka konvensional.
 - O:** Percepatan penyembuhan luka.

3. Pencarian bukti:

Studi menunjukkan bahwa balutan hidrogel lebih efektif dibandingkan metode konvensional dalam mempercepat penyembuhan luka.

4. Aplikasi:

Terapkan penggunaan balutan hidrogel sebagai metode perawatan luka.

5. Evaluasi:

Lakukan penilaian terhadap kecepatan penyembuhan luka setelah penggunaan metode baru.

M. Latihan Soal

1. Apa yang dimaksud dengan Evidence-Based Nursing Practice (EBNP)?
 - A. Metode asuhan keperawatan yang sepenuhnya bergantung pada pengalaman perawat.
 - B. Proses klinis berdasarkan kebiasaan dan tradisi lama.
 - C. Pendekatan yang menggabungkan bukti ilmiah, keahlian klinis, serta nilai pasien.
 - D. Proses asuhan keperawatan yang hanya bergantung pada kebutuhan pasien.

Jawaban: c

2. Apa tujuan utama dari penerapan EBNP?
 - A. Mengurangi interaksi antara perawat dan pasien.
 - B. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas asuhan keperawatan.
 - C. Menggantikan peran keahlian klinis perawat sepenuhnya.
 - D. Menyederhanakan prosedur keperawatan tanpa mempertimbangkan bukti.

Jawaban: b

3. Apa elemen utama dalam EBNP menurut Nursalam?
 - A. Preferensi keluarga, pengalaman pasien, dan intuisi perawat.
 - B. Bukti terbaik, keahlian klinis, dan preferensi pasien.
 - C. Tradisi budaya, nilai masyarakat, dan kebijakan rumah sakit.
 - D. Rekomendasi kolega, pedoman internal, dan intuisi perawat.

Jawaban: b

4. Langkah pertama dalam proses EBNP adalah?

- A. Menyusun pertanyaan PICO.
- B. Menilai kualitas bukti ilmiah.
- C. Mengidentifikasi masalah klinis.
- D. Mengimplementasikan hasil penelitian.

Jawaban: c

5. Apa yang dimaksud dengan metode PICO dalam EBNP?

- A. Proses pengumpulan data pasien untuk mendiagnosis penyakit.
- B. Kerangka untuk menyusun pertanyaan klinis berbasis bukti.
- C. Prosedur laboratorium untuk menguji efektivitas intervensi.
- D. Langkah evaluasi hasil implementasi keperawatan.

Jawaban: b

6. Dalam hierarki bukti, bukti paling kuat berasal dari?

- A. Penelitian deskriptif.
- B. Meta-analisis dan tinjauan sistematis RCT.
- C. Laporan kasus individu.
- D. Opini ahli.

Jawaban: b

7. Apa yang menjadi hambatan umum dalam implementasi EBNP?

- A. Banyaknya pelatihan yang diberikan kepada perawat.
- B. Kurangnya akses ke sumber bukti ilmiah.
- C. Tingginya insentif untuk penerapan EBNP.
- D. Dukungan penuh dari manajemen rumah sakit.

Jawaban: b

8. Apa manfaat utama dari pendekatan EBNP?

- A. Mengurangi partisipasi pasien dalam pengambilan keputusan.
- B. Meningkatkan variasi dalam pelaksanaan asuhan keperawatan.
- C. Memberikan pelayanan yang aman, efektif, dan berbasis bukti.
- D. Mengurangi standar pelayanan di rumah sakit.

Jawaban: c

9. Model Iowa dalam EBNP melibatkan langkah berikut, kecuali?

- A. Identifikasi masalah klinis.
- B. Pengembangan rekomendasi praktik.

- C. Penilaian dampak praktik berbasis bukti.
- D. Pembuatan intervensi tanpa dasar bukti.

Jawaban: d

10. Prinsip "Patient-Centered Care" dalam EBNP adalah?
- A. Fokus pada kebutuhan perawat dalam memberikan asuhan.
 - B. Mengutamakan nilai, preferensi, dan kebutuhan pasien.\
 - C. Memberikan intervensi berdasarkan pengalaman pribadi perawat.
 - D. Menghindari kolaborasi antara pasien dan perawat.

Jawaban: b

11. Contoh penerapan EBNP yang benar adalah?
- A. Memberikan terapi berdasarkan kebiasaan praktik lokal tanpa bukti ilmiah.
 - B. Menggunakan intervensi berdasarkan hasil penelitian dan nilai pasien.
 - C. Melakukan perawatan tanpa mengevaluasi hasilnya.
 - D. Mengabaikan preferensi pasien dalam pengambilan keputusan.

Jawaban: b

12. Dalam langkah EBNP, evaluasi hasil bertujuan untuk?
- A. Menyusun rencana keperawatan baru tanpa mempertimbangkan hasil.
 - B. Menilai keberhasilan intervensi berdasarkan bukti.
 - C. Mengabaikan data yang tidak relevan.
 - D. Mengulang proses tanpa modifikasi berdasarkan bukti.

Jawaban: b

13. Penggunaan database seperti PubMed dan Cochrane Library adalah bagian dari langkah?
- A. Mengidentifikasi masalah klinis.
 - B. Mencari bukti ilmiah.
 - C. Menyusun pertanyaan PICO.
 - D. Mengevaluasi hasil intervensi.

Jawaban: b

14. Mengapa resistensi terhadap perubahan menjadi hambatan dalam EBNP?
- A. Perawat lebih nyaman dengan metode berbasis bukti.
 - B. Organisasi mendukung inovasi tanpa hambatan.
 - C. Beberapa individu enggan meninggalkan praktik tradisional.
 - D. Akses terhadap bukti terlalu mudah.

Jawaban: c

15. Apa yang dimaksud dengan shared decision-making?
- A. Proses di mana keputusan klinis sepenuhnya diambil oleh perawat.
 - B. Kolaborasi antara pasien dan perawat dalam pengambilan keputusan.
 - C. Penyerahan seluruh keputusan klinis kepada dokter.
 - D. Pendekatan yang menghindari masukan dari pasien.

Jawaban: b

N. Rangkuman Materi

Konsep Evidence-Based Nursing Practice (EBNP) adalah pendekatan sistematis dalam praktik keperawatan yang mengintegrasikan bukti ilmiah terbaik, pengalaman klinis, serta nilai dan preferensi pasien. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kualitas asuhan keperawatan melalui metode berbasis bukti yang relevan, valid, dan efektif.

Elemen Utama EBNP

1. Bukti ilmiah terbaik: Melibatkan penelitian berkualitas tinggi, meta-analisis, atau pedoman berbasis bukti.
2. Keahlian klinis: Pengalaman profesional perawat dalam menilai, mendiagnosis, dan mengevaluasi.
3. Nilai dan preferensi pasien: Menghormati kebutuhan, harapan, serta budaya pasien.

Prinsip Dasar EBNP

1. Berorientasi pada pasien: Fokus pada kebutuhan pasien dalam pengambilan keputusan klinis.
2. Berdasarkan bukti terbaik: Menggunakan hasil penelitian mutakhir.
3. Melibatkan pengalaman klinis: Menjadikan keterampilan profesional sebagai pelengkap bukti.
4. Pengambilan keputusan bersama: Kolaborasi antara perawat dan pasien.

Langkah-Langkah EBNP

1. Mengidentifikasi masalah klinis.
2. Menyusun pertanyaan klinis dengan metode PICO (Population, Intervention, Comparison, Outcome).

3. Mencari bukti ilmiah melalui sumber terpercaya.
4. Menilai kualitas bukti berdasarkan validitas, relevansi, dan reliabilitas.
5. Mengintegrasikan bukti dalam praktik.
6. Mengevaluasi hasil implementasi terhadap pasien.

Manfaat EBNP

1. Memberikan asuhan keperawatan yang aman dan efektif.
2. Meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan.
3. Mengurangi risiko kesalahan klinis.
4. Meningkatkan profesionalisme dan kepuasan pasien.

Tantangan dalam Implementasi EBNP

1. Akses terbatas terhadap sumber bukti ilmiah.
2. Kurangnya pelatihan tentang EBNP.
3. Resistensi terhadap perubahan.
4. Beban kerja perawat yang tinggi.

Strategi Mengatasi Tantangan:

1. Pelatihan berkelanjutan.
2. Memanfaatkan teknologi digital.
3. Dukungan manajemen kesehatan.
4. Kolaborasi multidisiplin.

Model Implementasi EBNP

1. Model Iowa: Identifikasi masalah hingga evaluasi hasil.
2. Model ACE Star: Transformasi pengetahuan dari penemuan bukti hingga evaluasi dampak.

Buku ini bertujuan menjadi panduan bagi mahasiswa, dosen, dan praktisi untuk meningkatkan profesionalisme keperawatan melalui penerapan EBNP. Semoga rangkuman ini bermanfaat untuk memahami konsep dan penerapan keperawatan berbasis bukti.

O. Glosarium

1. ASKEP (Asuhan Keperawatan)

Pelayanan keperawatan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kemandirian klien dalam merawat dirinya.

2. EBNP (Evidence-Based Nursing Practice)

3. Praktik keperawatan berbasis bukti ilmiah, pengalaman klinis, serta nilai dan preferensi pasien untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

4. PICO (Population, Intervention, Comparison, Outcome)

5. Kerangka kerja untuk menyusun pertanyaan klinis yang membantu proses pencarian bukti ilmiah.
6. **Meta-Analisis**
7. Analisis statistik yang menggabungkan hasil dari beberapa penelitian untuk mendapatkan bukti yang lebih kuat.
8. **RCT (Randomized Controlled Trial)**
Uji klinis acak terkontrol, metode penelitian paling kuat dalam hierarki bukti ilmiah.
9. **Resistensi terhadap Perubahan**
Hambatan individu atau organisasi dalam menerima perubahan metode atau prosedur praktik.
10. **SharedDecision-Making**
Proses kolaborasi antara pasien dan perawat dalam pengambilan keputusan terkait asuhan kesehatan.
11. **Validitas**
Ukuran yang menunjukkan sejauh mana suatu penelitian atau bukti mencerminkan kebenaran.
12. **Reliabilitas**
Konsistensi hasil yang dihasilkan oleh suatu penelitian atau instrumen pengukuran.
13. **PedomanKlinis**
Rekomendasi berbasis bukti yang digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam asuhan keperawatan.
14. **KeahlianKlinis**
Pengalaman dan keterampilan profesional perawat dalam melakukan penilaian, diagnosis, dan evaluasi.
15. **Patient-CenteredCare**
Pendekatan asuhan kesehatan yang berpusat pada kebutuhan, preferensi, dan nilai pasien.
16. **HierarkiBukti**
Tingkatan bukti ilmiah berdasarkan kekuatannya, mulai dari meta-analisis hingga opini ahli.
17. **EvaluasiKeperawatan**
Penilaian terhadap keberhasilan intervensi keperawatan berdasarkan kondisi, perilaku, atau persepsi pasien.

P. Daftar Pustaka

- Craig, J. V., & Smyth, R. L. (Eds.). (2019). *The Evidence-Based Practice Manual for Nurses*.
- Melnyk, B. M., & Fineout-Overholt, E. (2018). *Evidence-Based Practice in Nursing & Healthcare*.
- Nursalam. (2016). *Metodologi Penelitian Ilmu Keperawatan: Pendekatan Praktis*. Jakarta: Salemba Medika.
- Nursalam. (2020). *Manajemen Keperawatan: Aplikasi dalam Praktik Keperawatan Profesional*. Jakarta: Salemba Medika.
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2020). *Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice*.
- Sackett, D. L., Straus, S. E., Richardson, W. S., Rosenberg, W., & Haynes, R. B. (2011). *Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM*.
- Stevens, K. R. (2012). *ACE Star Model of EBP: Knowledge Transformation*. Academic Center for Evidence-Based Practice.

BAB 6

PRAKTIK MANAJEMEN ASUHAN KEPERAWATAN PADA KASUS KELOLAAN

Pendahuluan

Manajemen keperawatan tidak hanya berkaitan dengan fungsi administratif, tetapi juga mencakup pengelolaan proses asuhan keperawatan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada mutu pelayanan. Salah satu pendekatan pembelajaran klinis yang menekankan integrasi teori ke dalam praktik nyata adalah melalui **praktik manajemen asuhan keperawatan (MAK) pada kasus kelolaan**.

Kasus kelolaan adalah metode pembelajaran klinis di mana mahasiswa secara sistematis merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi asuhan keperawatan secara komprehensif kepada pasien tertentu dalam periode waktu yang ditentukan. Dalam praktik ini, mahasiswa tidak hanya belajar menerapkan proses keperawatan, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip manajemen, seperti perencanaan tindakan, koordinasi tim, delegasi tugas, dokumentasi, supervisi, dan evaluasi hasil keperawatan. Melalui bab ini, mahasiswa keperawatan akan mendapatkan pemahaman mendalam dan pengalaman aplikatif mengenai bagaimana merancang dan menjalankan praktik MAK yang berfokus pada pasien secara holistik, dengan pendekatan kepemimpinan klinis, pelayanan berbasis bukti, dan penguatan keselamatan pasien.

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode

CPL

Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (KKNI Level 6)

- | | |
|--------------|--|
| | Mampu mengelola dan melaksanakan asuhan keperawatan secara komprehensif pada individu, keluarga, dan komunitas berdasarkan ilmu keperawatan dan prinsip manajemen. |
| CPL-1 | |
| CPL-2 | Mampu menunjukkan kemampuan kepemimpinan dan kerja sama tim dalam pelaksanaan pelayanan keperawatan. |
| CPL-3 | Mampu menggunakan teknologi informasi dalam dokumentasi dan pelaporan pelayanan keperawatan. |
| CPL-4 | Mampu berperilaku profesional, etis, dan bertanggung jawab dalam melaksanakan praktik keperawatan. |

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip manajemen keperawatan dalam praktik asuhan keperawatan.
CPMK-2	Mahasiswa mampu menerapkan proses keperawatan secara sistematis pada pasien kelolaan.
CPMK-3	Mahasiswa mampu mengelola asuhan keperawatan dengan mengintegrasikan prinsip delegasi, supervisi, dan dokumentasi keperawatan.
CPMK-4	Mahasiswa mampu mendemonstrasikan komunikasi profesional, kerja sama tim, dan kepemimpinan klinis dalam praktik kasus kelolaan.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

CPMK	Sub-CPMK
CPMK-1	a. Menjelaskan konsep manajemen keperawatan dan praktik MAK pada kasus kelolaan. b. Menjelaskan tanggung jawab profesional dalam praktik kasus kelolaan.
CPMK-2	a. Melakukan pengkajian komprehensif terhadap pasien kelolaan. b. Menyusun diagnosa, rencana, intervensi, dan evaluasi keperawatan. c. Mendokumentasikan proses keperawatan secara sistematis.
CPMK-3	a. Mengelola waktu dan sumber daya dalam praktik keperawatan. b. Melakukan supervisi dan koordinasi tindakan keperawatan. c. Melaporkan hasil dan perkembangan pasien secara profesional.
CPMK-4	a. Menunjukkan kemampuan komunikasi terapeutik dengan pasien dan keluarga. b. Berkolaborasi secara efektif dengan tim kesehatan. c. Mengambil keputusan klinis dengan mempertimbangkan keselamatan pasien.

A. Konsep Dasar Praktik MAK pada Kasus Kelolaan

1. Pengertian dan Tujuan

Praktik manajemen asuhan keperawatan (MAK) pada kasus kelolaan adalah suatu pendekatan pembelajaran klinik berbasis pengalaman nyata, di mana mahasiswa keperawatan diberikan tanggung jawab untuk mengelola secara komprehensif proses asuhan keperawatan kepada pasien tertentu selama periode praktik klinik. Dalam praktik ini, mahasiswa tidak hanya menerapkan teori proses keperawatan, tetapi juga mengintegrasikan fungsi-fungsi manajerial, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, evaluasi, komunikasi efektif, dan kolaborasi tim dalam pelayanan keperawatan.

Praktik ini dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa menjadi perawat profesional yang siap kerja, mampu berpikir kritis, responsif, dan beretika dalam menghadapi dinamika pelayanan keperawatan di tatanan nyata. Melalui tanggung jawab langsung terhadap pasien kelolaan, mahasiswa akan mengalami bagaimana asuhan keperawatan tidak hanya soal tindakan, tetapi juga kepemimpinan dan pengambilan keputusan yang tepat waktu dan akurat.

2. Landasan Filosofis

Praktik MAK pada kasus kelolaan dilandasi oleh:

- Paradigma belajar berbasis pengalaman (experiential learning) – Mahasiswa belajar dari aktivitas nyata dengan merefleksikan tindakan yang dilakukan.
- Student-centered learning Mahasiswa menjadi pusat dari proses pembelajaran dengan bertanggung jawab penuh atas proses dan hasil belajarnya.
- Prinsip asuhan keperawatan holistik Fokus tidak hanya pada fisik pasien, tetapi juga pada aspek psikologis, sosial, budaya, dan spiritual.
- Manajemen keperawatan profesional Menekankan pada kemampuan mengelola waktu, prioritas, komunikasi, dan kolaborasi.

3. Ciri Utama Praktik Kasus Kelolaan

- Pemilihan Pasien Secara Terstruktur

Pemilihan pasien kelolaan dilakukan secara sistematis oleh institusi pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Pasien dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti:

- 1) Diagnosa medis dan kompleksitas kasus
- 2) Lama perawatan (≥ 3 hari)
- 3) Kebutuhan intervensi keperawatan berkelanjutan
- 4) Ketersediaan ruang dan dukungan dari perawat klinis

Tujuannya adalah agar mahasiswa mendapatkan kesempatan belajar dari kasus nyata yang merepresentasikan kebutuhan asuhan keperawatan yang kompleks dan menantang.

b. Tanggung Jawab Penuh Mahasiswa terhadap Proses Keperawatan

Dalam praktik ini, mahasiswa:

- 1) Melakukan pengkajian secara menyeluruh
- 2) Menetapkan diagnosa keperawatan berdasarkan analisis data
- 3) Menyusun rencana asuhan keperawatan secara individual
- 4) Melaksanakan intervensi yang sesuai standar
- 5) Melakukan evaluasi dan modifikasi rencana jika diperlukan
- 6) Melaporkan hasil secara verbal dan tertulis kepada pembimbing dan tim keperawatan

Peran ini memberikan mahasiswa pemahaman langsung mengenai kontinuitas asuhan, pengambilan keputusan, dan pentingnya tanggung jawab profesional terhadap pasien.

c. Keterampilan Manajerial yang Diterapkan

Praktik kasus kelolaan tidak hanya menekankan keterampilan klinis, tetapi juga keterampilan manajerial yang mencakup:

- 1) Perencanaan harian tindakan keperawatan berdasarkan prioritas masalah pasien
- 2) Koordinasi tim keperawatan, termasuk komunikasi dengan dokter, apoteker, dan profesi lain
- 3) Delegasi tugas (jika dalam level lanjut), misalnya kepada teman sejawat di ruang praktik
- 4) Pengaturan waktu dan sumber daya agar pelayanan berjalan efektif dan efisien
- 5) Manajemen risiko dan keselamatan pasien, seperti pencegahan infeksi, pengkajian risiko jatuh, dan pelaporan insiden

Keterampilan ini sangat penting sebagai bekal mahasiswa ketika terjun di dunia kerja sebagai perawat profesional.

d. Supervisi dan Evaluasi oleh Pembimbing Klinik

Selama praktik, mahasiswa tetap berada dalam bimbingan dan supervisi dari:

- 1) Pembimbing klinik di fasyankes (preceptor/perawat senior)
- 2) Dosen pembimbing dari institusi pendidikan

Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan, baik secara:

- 1) Formatif (penilaian harian, observasi langsung, refleksi klinik)
- 2) Sumatif (laporan akhir kasus kelolaan, presentasi kasus, ujian OSCE)

Supervisi ini bertujuan untuk:

- 1) Menjamin keamanan dan keselamatan pasien
- 2) Memberikan umpan balik langsung kepada mahasiswa
- 3) Menanamkan nilai-nilai etika, akuntabilitas, dan profesionalisme

B. Tujuan Praktik Kasus Kelolaan

Praktik manajemen asuhan keperawatan (MAK) melalui pendekatan kasus kelolaan merupakan strategi pembelajaran klinik yang tidak hanya bertujuan melatih keterampilan teknis mahasiswa, tetapi juga membentuk karakter profesional dan kemampuan manajerial yang dibutuhkan dalam dunia kerja keperawatan. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah menciptakan lulusan keperawatan yang komprehensif, kompeten, dan beretika, melalui keterlibatan langsung dalam pemberian asuhan keperawatan secara holistik dan bertanggung jawab.

Berikut ini penjabaran mendalam dari masing-masing tujuan praktik kasus kelolaan:

1. Menerapkan proses keperawatan secara komprehensif.

Salah satu kompetensi inti dalam keperawatan adalah kemampuan untuk melaksanakan proses keperawatan secara menyeluruh. Melalui kasus kelolaan, mahasiswa belajar menerapkan lima tahap proses keperawatan, yaitu:

- a. Pengkajian: Mengumpulkan data subjektif dan objektif pasien secara sistematis dan menyeluruh.
- b. Diagnosa: Menetapkan masalah keperawatan yang tepat berdasarkan analisis data, sesuai standar NANDA-I.
- c. Perencanaan: Menyusun tujuan dan intervensi yang realistis, berbasis *Nursing Interventions Classification (NIC)*.
- d. Implementasi: Melaksanakan intervensi dengan pendekatan holistik, mencakup tindakan mandiri dan kolaboratif.
- e. Evaluasi: Menilai keberhasilan tindakan keperawatan dan merevisi rencana sesuai respons pasien.

Dengan keterlibatan penuh dalam seluruh proses ini, mahasiswa dilatih untuk berpikir analitis, kritis, dan reflektif dalam menghadapi permasalahan pasien secara nyata di ruang praktik.

2. Melatih kemampuan pengelolaan waktu, sumber daya, dan dokumentasi.

Manajemen asuhan keperawatan tidak lepas dari kemampuan mengelola sumber daya secara efektif dan efisien. Dalam praktik kasus kelolaan, mahasiswa diharapkan mampu:

- a. Menyusun prioritas harian tindakan keperawatan berdasarkan kondisi pasien, urgensi intervensi, dan efektivitas waktu.

- b. Menggunakan sarana dan prasarana secara bijak, termasuk alat medis, ruang perawatan, dan tenaga pendukung.
- c. Mencatat dan mendokumentasikan setiap tindakan keperawatan dalam format yang baku (SOAP, ADPIE, atau DAR), untuk menjamin kesinambungan asuhan dan sebagai bukti hukum yang sah.

Kemampuan manajerial ini merupakan bekal penting untuk bekerja di lingkungan klinik yang dinamis dan penuh tuntutan profesionalisme.

3. Mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan kerja sama tim.

Praktik kasus kelolaan juga berfungsi sebagai wadah untuk mengembangkan kepemimpinan klinis mahasiswa. Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai pemberi asuhan, tetapi juga:

- a. Mengkoordinasikan tindakan keperawatan bersama tim klinik (perawat ruangan, dokter, farmasi, ahli gizi, dll).
- b. Berkomunikasi efektif dan asertif dalam menyampaikan kondisi pasien kepada tim.
- c. Menjadi role model mini dalam praktik profesional, terutama kepada pasien dan keluarga.

Kepemimpinan dalam konteks ini tidak hanya berarti mengambil keputusan, tetapi juga menunjukkan inisiatif, tanggung jawab, etika kerja, dan kemampuan membangun hubungan interpersonal yang baik dengan berbagai pihak.

4. Menyusun dan melaksanakan rencana asuhan keperawatan berbasis bukti.

Salah satu arah praktik keperawatan saat ini adalah *Evidence-Based Nursing Practice* (EBNP). Melalui kasus kelolaan, mahasiswa didorong untuk:

- a. Mencari dan menganalisis literatur ilmiah atau pedoman praktik klinik yang relevan dengan masalah pasien.
- b. Menggunakan hasil penelitian terkini sebagai dasar dalam menyusun intervensi keperawatan.
- c. Mengadaptasi intervensi yang terbukti efektif ke dalam kondisi klinis pasien dengan pendekatan individual.

Penguasaan prinsip EBNP membentuk sikap ilmiah mahasiswa, meningkatkan akurasi pengambilan keputusan, serta berkontribusi dalam peningkatan mutu pelayanan keperawatan di masa depan.

5. Mengintegrasikan nilai-nilai etika dan profesionalisme dalam pelayanan pasien.

Selain aspek ilmiah dan teknis, praktik keperawatan juga menuntut integritas moral dan komitmen etika. Dalam praktik kasus kelolaan, mahasiswa dibimbing untuk:

- a. Menjunjung tinggi hak dan martabat pasien, seperti hak atas informasi, hak privasi, dan hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

- b. Bertindak berdasarkan prinsip-prinsip etika keperawatan, seperti beneficence (berbuat baik), non-maleficence (tidak merugikan), justice (keadilan), dan autonomy (kemandirian pasien).
- c. Menunjukkan profesionalisme, seperti disiplin waktu, berpakaian rapi, bersikap sopan, dan jujur dalam pelaporan serta dokumentasi.

Integrasi nilai-nilai etis ini membentuk karakter mahasiswa menjadi perawat yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara emosional dan bermoral tinggi.

C. Tahapan Praktik Manajemen Asuhan Keperawatan

1. Pengkajian Keperawatan

Pengkajian keperawatan adalah tahap awal dalam proses keperawatan yang berfungsi sebagai pondasi utama dalam menyusun diagnosa keperawatan, intervensi, dan evaluasi. Pada praktik kasus kelolaan, pengkajian menjadi tanggung jawab penuh mahasiswa, karena dari sinilah seluruh perencanaan dan pelaksanaan asuhan keperawatan dimulai. Pengkajian tidak hanya berfokus pada aspek biologis, tetapi juga mencakup pendekatan holistik, yaitu bio-psiko-sosio-kultural dan spiritual, agar keperawatan yang diberikan bersifat menyeluruh dan kontekstual.

Pengkajian dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan bio-psiko-sosio-kultural dan spiritual:

a. Data subjektif dan objektif

- 1) Data subjektif: Informasi yang diperoleh langsung dari pasien atau keluarga tentang perasaan, persepsi, atau keluhan yang dirasakan pasien. Contohnya: nyeri, mual, kecemasan, kelelahan.
- 2) Data objektif: Informasi yang diperoleh dari pemeriksaan langsung oleh perawat, observasi, atau hasil pemeriksaan penunjang. Contohnya: tanda-tanda vital, kondisi luka, hasil lab, hasil radiologi.

Pengumpulan data dilakukan dengan metode:

- 1) Wawancara terstruktur/semi-terstruktur
- 2) Observasi langsung
- 3) Pemeriksaan fisik
- 4) Review rekam medis

b. Riwayat penyakit sekarang dan dahulu

- 1) Riwayat penyakit sekarang: Fokus pada masalah kesehatan yang sedang dialami, termasuk:
 - a) Awal munculnya gejala
 - b) Lokasi, intensitas, durasi, dan faktor yang memperberat/meringankan

- c) Pengobatan yang telah dilakukan
- d) Dampak terhadap fungsi aktivitas harian
- 2) Riwayat penyakit dahulu: Mengetahui kemungkinan komorbiditas atau faktor predisposisi, seperti:
 - a) Hipertensi, diabetes, tuberkulosis
 - b) Riwayat operasi atau rawat inap sebelumnya
 - c) Alergi obat atau makanan
- 3) Tujuan dari pengumpulan riwayat ini adalah untuk:
 - a) Mengidentifikasi faktor penyebab atau pemicu masalah kesehatan saat ini
 - b) Memperkirakan kemungkinan komplikasi atau prognosis
- c. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik dilakukan secara sistematis dan head-to-toe, meliputi:

 - 1) Inspeksi: Pengamatan terhadap penampilan umum, warna kulit, postur, ekspresi wajah, luka, pembengkakan.
 - 2) Palpasi: Pemeriksaan melalui perabaan untuk menilai suhu, tekstur, nyeri tekan, edema.
 - 3) Perkusi: Digunakan untuk menilai organ dalam, misalnya paru atau abdomen.
 - 4) Auskultasi: Mendengarkan suara tubuh, misalnya suara napas, bunyi usus, dan denyut jantung.

Setiap sistem tubuh perlu diperiksa:

 - 1) Sistem kardiovaskular
 - 2) Sistem respirasi
 - 3) Sistem pencernaan
 - 4) Sistem muskuloskeletal
 - 5) Sistem integumen (kulit)
 - 6) Sistem saraf
 - 7) Sistem reproduksi (jika relevan)
- d. Hasil pemeriksaan penunjang

Hasil pemeriksaan penunjang digunakan untuk memperkuat pengkajian klinik dan mendukung perumusan diagnosa keperawatan. Pemeriksaan yang dikaji antara lain:

 - 1) Laboratorium: Hemoglobin, leukosit, glukosa darah, elektrolit, fungsi hati/ginjal.
 - 2) Radiologi: X-ray, CT scan, USG, MRI.
 - 3) Pemeriksaan khusus: EKG, spirometri, kultur luka, tes kehamilan, swab.

e. Pola fungsi kesehatan (Gordon)

Pengkajian berdasarkan **11 pola fungsi kesehatan Gordon** membantu mahasiswa mengidentifikasi aspek-aspek holistik kehidupan pasien. Pola ini mencakup:

Tabel 6.1 Pola fungsi Kesehatan

No	Pola	Deskripsi Singkat
1	Persepsi kesehatan – pemeliharaan kesehatan	Bagaimana pasien menjaga kesehatannya
2	Pola nutrisi dan metabolisme	Asupan makan dan hidrasi
3	Pola eliminasi	Frekuensi BAK dan BAB
4	Pola aktivitas dan latihan	Kemampuan mobilisasi, ADL
5	Pola tidur dan istirahat	Kualitas dan kuantitas tidur
6	Pola persepsi dan kognitif	Kemampuan berpikir, bicara, dan rasa sakit
7	Pola persepsi diri	Harga diri, konsep diri
8	Pola peran dan hubungan	Hubungan sosial dan keluarga
9	Pola seksual dan reproduksi	Masalah seksual, kehamilan, atau menopause
10	Pola koping dan toleransi stres	Respons terhadap stres atau krisis
11	Pola nilai dan kepercayaan	Keyakinan spiritual dan religiusitas

Setiap pola ditelusuri melalui wawancara dan observasi untuk menggali potensi masalah keperawatan. Model ini membantu mahasiswa melihat pasien secara utuh, bukan sekadar sebagai objek perawatan fisik.

2. Diagnosa Keperawatan

Diagnosa keperawatan merupakan langkah kedua dalam proses keperawatan yang sangat penting, karena menjadi dasar dalam menentukan intervensi keperawatan yang tepat dan efektif. Diagnosa keperawatan adalah keputusan klinis yang dibuat oleh perawat berdasarkan hasil analisis data pengkajian, yang menggambarkan respons individu, keluarga, atau komunitas terhadap masalah kesehatan yang aktual atau potensial.

Dalam konteks praktik kasus kelolaan, kemampuan mahasiswa dalam menyusun diagnosa keperawatan mencerminkan tingkat pemahaman dan kompetensi klinisnya. Diagnosa yang akurat akan menghasilkan rencana tindakan yang terarah, hemat waktu, serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pasien. Menentukan masalah keperawatan berdasarkan hasil pengkajian:

a. Menggunakan standar **NANDA-I**

Dalam praktik profesional, penentuan diagnosa keperawatan wajib mengacu pada standar NANDA-I (North American Nursing Diagnosis Association International) yang diakui secara global. Standar ini menyediakan:

- 1) Definisi diagnosa keperawatan
- 2) Ciri-ciri definisi (defining characteristics)
- 3) Faktor yang berhubungan atau risiko (related or risk factors)
- 4) Kategori diagnosa: aktual, risiko, kesejahteraan (wellness), sindrom

Jenis-jenis Diagnosa NANDA-I:

- 1) Diagnosa aktual: Masalah yang telah terjadi, dibuktikan oleh gejala dan tanda (misal: nyeri akut, gangguan pola tidur).
- 2) Diagnosa risiko: Masalah yang belum terjadi tetapi memiliki faktor risiko kuat (misal: risiko infeksi, risiko jatuh).
- 3) Diagnosa promosi kesehatan: Berfokus pada peningkatan status kesehatan (misal: kesiapan meningkatkan nutrisi).
- 4) Diagnosa sindrom: Kumpulan beberapa diagnosa yang muncul bersamaan (misal: sindrom disfungsi mobilitas fisik).

Contoh Diagnosa NANDA-I:

- 1) Gangguan pertukaran gas
- 2) Risiko ketidakseimbangan cairan
- 3) Ansietas
- 4) Ketidakefektifan perfusi jaringan perifer

b. Menentukan prioritas masalah dengan skala urgensi (ABCDE atau Maslow)

Setelah mengidentifikasi beberapa diagnosa keperawatan, mahasiswa harus mampu menentukan prioritas tindakan, karena tidak semua masalah dapat ditangani secara bersamaan. Penentuan prioritas dilakukan dengan metode pendekatan klinis seperti:

1) Pendekatan ABCDE

ABCDE adalah singkatan dari:

- a) **A: Airway** (jalan napas)
- b) **B: Breathing** (pernapasan)
- c) **C: Circulation** (sirkulasi)
- d) **D: Disability** (neurologis/kesadaran)
- e) **E: Exposure** (faktor lingkungan atau luka terbuka)

Skala ini digunakan untuk menentukan masalah paling mengancam jiwa. Masalah yang menyangkut jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi harus ditangani terlebih dahulu karena berhubungan langsung dengan keselamatan pasien.

Contoh penggunaan ABCDE:

- a) Gangguan pertukaran gas → prioritas 1 (B)
 - b) Risiko jatuh → prioritas lebih rendah dibandingkan gangguan sirkulasi
- 2) Hirarki Maslow

Maslow menyusun kebutuhan manusia dalam lima tingkat prioritas. Dalam konteks keperawatan, ini membantu menyusun urutan masalah dari yang paling dasar hingga ke psikososial dan spiritual.

Tabel 6.2 Hirarki Maslow

Tingkat Maslow	Kategori	Contoh Diagnosa
I	Kebutuhan fisiologis	Gangguan nutrisi, nyeri akut, gangguan tidur
II	Keamanan dan perlindungan	Risiko infeksi, risiko jatuh
III	Cinta dan rasa memiliki	Isolasi sosial
IV	Harga diri	Gangguan citra tubuh, ansietas
V	Aktualisasi diri	Kesiapan meningkatkan kesehatan

Mahasiswa harus menyusun daftar masalah keperawatan, lalu menyusun urutannya berdasarkan tingkat kebutuhan Maslow dan ABCDE (jika kondisi akut). Prioritas ini menjadi acuan dalam menentukan:

- a) Urutan intervensi harian
- b) Penjadwalan tindakan
- c) Evaluasi keberhasilan asuhan

3. Perencanaan Keperawatan

Perencanaan keperawatan merupakan tahap ketiga dalam proses keperawatan, setelah pengkajian dan penetapan diagnosa. Perencanaan keperawatan adalah suatu rangkaian keputusan sistematis yang dibuat oleh perawat untuk menentukan arah dan bentuk intervensi keperawatan yang akan dilakukan terhadap pasien berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi. Tujuannya adalah untuk mencapai hasil yang optimal dan terukur sesuai dengan kebutuhan pasien, dalam rentang waktu tertentu. Perencanaan harus mencerminkan:

- a. Tujuan yang SMART (Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)
Penyusunan tujuan dalam perencanaan keperawatan harus mengikuti prinsip **SMART**, yaitu:

Tabel 6.3 Smart

Unsur SMART	Penjelasan	Contoh Tujuan
S – Spesifik	Tujuan harus jelas dan fokus pada satu masalah	"Pasien akan melaporkan nyeri berkurang setelah diberikan analgetik"
M – Measurable	– Harus dapat diukur secara objektif	"Skor nyeri menurun dari 7 menjadi ≤ 3 dalam 1 jam"
A – Achievable	– Tujuan harus dapat dicapai sesuai kondisi pasien dan sumber daya	"Pasien dapat berjalan dengan bantuan dalam 2 hari"
R – Relevant	Tujuan harus relevan dengan diagnosa keperawatan	"Meningkatkan perfusi jaringan sesuai masalah gangguan sirkulasi"
T – Time-bound	Dibatasi waktu pencapaiannya	"Dalam 24 jam" atau "setelah 3 hari perawatan"

Jenis Tujuan

- 1) Tujuan jangka pendek: dicapai dalam waktu ≤ 24 jam, relevan untuk tindakan harian.
- 2) Tujuan jangka panjang: dicapai dalam beberapa hari atau minggu, sesuai dengan target pemulihan total.

Mahasiswa harus menetapkan **minimal satu tujuan utama** untuk setiap diagnosa keperawatan, serta menjelaskan kriteria keberhasilannya secara rinci.

b. Kriteria hasil yang dapat diobservasi dan diukur

Kriteria hasil adalah indikator spesifik yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan tindakan keperawatan. Kriteria ini harus:

- 1) Berorientasi pada pasien (patient-centered)
- 2) Dapat diamati langsung atau diukur dengan instrumen
- 3) Menggambarkan perubahan status kesehatan atau respon terhadap intervensi

Jenis kriteria hasil:

- 1) Fisiologis: tanda vital stabil, luka mengering, peningkatan kadar Hb
- 2) Psikologis: pasien tampak tenang, menurunnya kecemasan
- 3) Perilaku: pasien mengikuti anjuran terapi, melakukan latihan napas
- 4) Pengetahuan: pasien dapat mengulang informasi edukasi dengan benar

Contoh:

- 1) "Pasien melaporkan nyeri ≤ 3 pada skala 0–10 dalam 30 menit setelah intervensi"

2) "Luka operasi kering, tanpa eksudat, dan tidak ada tanda infeksi dalam 48 jam"

c. Intervensi yang berbasis NIC (Nursing Intervention Classification)

Intervensi keperawatan adalah tindakan-tindakan spesifik yang dilakukan perawat untuk mengatasi masalah keperawatan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk menjaga standarisasi praktik dan akuntabilitas profesional, perawat harus menggunakan acuan dari NIC (Nursing Interventions Classification).

4. Implementasi Keperawatan

Implementasi keperawatan adalah tahap keempat dalam proses keperawatan, yaitu pelaksanaan dari rencana tindakan yang telah disusun secara sistematis pada tahap perencanaan. Pada tahap ini, perawat atau mahasiswa praktik klinik secara aktif melakukan berbagai tindakan keperawatan sesuai dengan tujuan dan intervensi yang telah ditetapkan, guna membantu pasien mencapai tingkat kesehatan yang optimal.

Implementasi merupakan wujud nyata tanggung jawab perawat dalam memberikan asuhan kepada pasien. Dalam praktik kasus kelolaan, implementasi tidak hanya menuntut keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan manajerial seperti perencanaan harian, kolaborasi lintas profesi, serta pendokumentasian yang akurat dan tepat waktu.

Pelaksanaan intervensi dilakukan sesuai jadwal tindakan harian:

a. Tindakan mandiri: edukasi, pemantauan, perawatan mandiri

Tindakan mandiri adalah intervensi keperawatan yang dilakukan atas inisiatif perawat, tanpa memerlukan instruksi dari tenaga medis lainnya. Tindakan ini merupakan bentuk dari kewenangan profesional perawat dalam melaksanakan asuhan berdasarkan kompetensinya.

b. Tindakan kolaboratif: pemberian obat, terapi fisik, dan rujukan

Tindakan kolaboratif adalah tindakan keperawatan yang dilakukan dengan berdasarkan instruksi medis atau melalui kerja sama dengan tim kesehatan lainnya. Kolaborasi ini penting untuk memastikan bahwa asuhan yang diberikan bersifat terpadu dan berorientasi pada kebutuhan pasien secara menyeluruh.

c. Koordinasi antarprofesi: dokter, farmasi, ahli gizi, fisioterapi

Implementasi keperawatan dalam konteks praktik klinik tidak dapat berdiri sendiri. Mahasiswa harus mampu berkoordinasi secara aktif dengan anggota tim kesehatan lainnya, baik secara formal (dalam ronde atau diskusi tim) maupun informal (diskusi antar shift, melalui komunikasi lisan atau tertulis).

Profesi yang sering diajak berkoordinasi meliputi:

- 1) Dokter: Untuk klarifikasi instruksi medis, diskusi kondisi klinis pasien, pelaporan tanda bahaya.
- 2) Apoteker: Untuk mengecek efek samping obat, interaksi obat, atau penggantian sediaan obat.
- 3) Ahli gizi: Untuk menyusun menu pasien, terutama pasien dengan penyakit metabolik (DM, gagal ginjal).
- 4) Fisioterapis: Untuk memfasilitasi latihan fisik sesuai kemampuan pasien.
- 5) Pekerja sosial atau psikolog: Untuk membantu pasien yang memiliki masalah psikoemosional, keterbatasan finansial, atau gangguan adaptasi sosial.

Koordinasi yang baik akan:

- 1) Meningkatkan efektivitas asuhan
- 2) Menghindari duplikasi tindakan
- 3) Mempercepat waktu pemulihan
- 4) Meningkatkan kepuasan pasien

Mahasiswa harus berperan aktif dalam tim interdisipliner, dengan menunjukkan kemampuan komunikasi profesional dan penghormatan terhadap kompetensi masing-masing profesi.

5. Evaluasi

Evaluasi keperawatan adalah tahap terakhir dalam proses keperawatan yang berfungsi untuk menilai sejauh mana tujuan dan kriteria hasil yang telah direncanakan sebelumnya telah tercapai. Evaluasi memberikan dasar untuk memutuskan apakah rencana asuhan keperawatan perlu dilanjutkan, dimodifikasi, atau dihentikan. Evaluasi bertujuan menilai efektivitas asuhan:

a. Evaluasi formatif (harian)

Evaluasi formatif adalah evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus selama proses praktik berlangsung, biasanya dilakukan setiap shift atau setiap hari. Tujuannya adalah untuk memantau:

- 1) Perkembangan kondisi pasien dari hari ke hari
- 2) Respons pasien terhadap intervensi
- 3) Efektivitas pendekatan yang digunakan
- 4) Masalah baru yang mungkin muncul

Ciri khas evaluasi formatif:

- 1) Bersifat dinamis, fleksibel, dan berkelanjutan
- 2) Mengarah pada penyesuaian rencana asuhan harian
- 3) Mendukung pengambilan keputusan klinis segera

b. Evaluasi sumatif (akhir rotasi)

Evaluasi sumatif adalah evaluasi komprehensif yang dilakukan pada akhir periode praktik atau setelah mahasiswa menyelesaikan satu siklus proses keperawatan. Evaluasi ini menilai:

- 1) Apakah **tujuan jangka pendek dan panjang telah tercapai**
- 2) Konsistensi mahasiswa dalam melakukan dokumentasi dan pelaporan
- 3) Keterampilan mahasiswa dalam mengambil keputusan berdasarkan hasil evaluasi

Komponen evaluasi sumatif:

- 1) Rekap perkembangan klinis pasien selama periode kelolaan
- 2) Analisis keberhasilan atau kegagalan intervensi
- 3) Refleksi mahasiswa terhadap proses asuhan yang telah dijalankan
- 4) Penilaian akhir dari dosen pembimbing terhadap kompetensi mahasiswa

c. Hasil dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan

Langkah inti dalam evaluasi adalah membandingkan hasil aktual dengan tujuan dan kriteria hasil yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Analisis ini dilakukan berdasarkan:

Tabel 6.4

Unsur	Pertanyaan yang Dijawab
Tujuan	Apakah tujuan SMART tercapai?
Kriteria hasil	Apakah indikator hasil tercapai secara terukur?
Respon pasien	Apa perubahan subjektif dan objektif pasien?
Dokumentasi	Apakah tindakan dan hasil dicatat dengan benar?

Kategori hasil evaluasi:

- 1) Tercapai sepenuhnya
Semua indikator dan kriteria hasil terpenuhi. Tidak memerlukan intervensi lanjutan.
- 2) Tercapai sebagian
Ada perbaikan, tetapi belum sesuai target. Intervensi dapat dilanjutkan atau dimodifikasi.
- 3) Tidak tercapai
Tidak ada perubahan signifikan. Perlu kaji ulang pengkajian dan rencana intervensi.

D. Prinsip Manajemen dalam Praktik Kasus Kelolaan

1. Perencanaan Harian

Perencanaan harian atau Daily Activity Plan (DAP) adalah suatu jadwal sistematis yang disusun oleh mahasiswa untuk mengatur pelaksanaan intervensi keperawatan secara terstruktur, terukur, dan efisien dalam kurun waktu tertentu (biasanya per 24 jam). Perencanaan ini merupakan bagian penting dari manajemen asuhan keperawatan, khususnya dalam praktik kasus kelolaan, di mana mahasiswa bertanggung jawab penuh terhadap kontinuitas pelayanan pasien. Mahasiswa menyusun jadwal harian tindakan (daily activity plan) berdasarkan:

a. Jadwal medis

Perencanaan harian harus disusun dengan memperhatikan jadwal tindakan medis yang telah ditetapkan oleh dokter atau tim medis. Ini meliputi:

- 1) Waktu pemberian obat: apakah obat diberikan sebelum makan, sesudah makan, atau berdasarkan jam tertentu (misalnya pukul 08.00 dan 20.00)
- 2) Pemeriksaan penunjang: seperti X-ray, laboratorium, EKG, yang membutuhkan persiapan pasien
- 3) Tindakan medis khusus: misalnya tindakan invasif (pemasangan kateter, debridement luka), transfusi, pemasangan infus, dll

b. Kebutuhan keperawatan

Penyusunan perencanaan harian juga harus berdasarkan:

- 1) Diagnosa keperawatan yang telah ditetapkan
- 2) Tujuan SMART yang ingin dicapai
- 3) Kriteria hasil yang terukur

Setiap diagnosa keperawatan harus memiliki intervensi harian spesifik yang direncanakan waktunya. Kebutuhan keperawatan dapat meliputi:

- 1) Pemantauan klinis: seperti pemantauan tanda vital, nyeri, status neurologis
- 2) Pemberian edukasi: tentang pengobatan, diet, mobilisasi, teknik batuk napas dalam
- 3) Asuhan dasar: perawatan luka, kebersihan diri, mobilisasi pasien, penggantian balutan
- 4) Tindakan preventif: seperti pencegahan dekubitus, senam kaki, latihan ROM (range of motion)
- 5) Dukungan psikososial dan spiritual

Semua kebutuhan tersebut harus dirancang waktunya agar tidak saling tumpang tindih, dan dilakukan dengan pendekatan yang empatik dan holistik.

Contoh:

Untuk diagnosa "Risiko infeksi berhubungan dengan luka operasi", tindakan harian bisa meliputi:

- 1) Pukul 08.00: observasi kondisi luka dan ganti balutan
- 2) Pukul 11.00: edukasi kebersihan tangan dan perawatan luka di rumah
- 3) Pukul 16.00: kolaborasi pemberian antibiotik

c. Ketersediaan sumber daya (alat, waktu, dan SDM)

Penyusunan perencanaan harian juga harus mempertimbangkan sumber daya yang tersedia, yaitu:

- 1) Waktu: Mahasiswa harus menyadari waktu praktik yang tersedia per shift, serta waktu luang pasien (misal, waktu istirahat, waktu makan).
- 2) Alat dan fasilitas: Seperti availability alat pengukur tekanan darah, peralatan luka, termometer, alat bantu mobilisasi, tempat tidur pasien, dan ruangan tindakan.
- 3) Sumber daya manusia (SDM):
 - a) Kolaborasi dengan perawat ruangan
 - b) Koordinasi dengan dokter, fisioterapis, ahli gizi, dll
 - c) Dukungan dari keluarga pasien (jika terlibat dalam perawatan)

2. Delegasi dan Koordinasi

- a. Mahasiswa dapat mendelegasikan tugas-tugas non-kompleks dengan supervisi (jika diperkenankan)
- b. Melibatkan kolaborasi aktif dengan perawat ruangan dan tim lainnya

3. Supervisi dan Tanggung Jawab

- a. Setiap tindakan harus dilakukan dengan supervisi bila menyangkut pasien dengan kondisi kompleks
- b. Mahasiswa wajib bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan dan pencatatan tindakan

4. Dokumentasi

- a. Menggunakan format SOAP, SOAPIE, atau ADPIE
- b. Dokumentasi harus lengkap, akurat, legal, dan dilakukan segera setelah tindakan
- c. Digunakan sebagai bukti pertanggungjawaban dan alat komunikasi antar profesi

E. Studi Kasus

Tn. A, seorang laki-laki berusia 57 tahun, dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis medis *Diabetes Mellitus (DM) Tipe 2* disertai komplikasi **ulkus diabetikum** pada ekstremitas bawah. Berdasarkan hasil pengkajian awal yang dilakukan secara menyeluruh, diketahui bahwa pasien telah menderita DM selama lebih dari 10 tahun dan tidak rutin melakukan kontrol glukosa darah. Luka ditemukan di kaki kanan bagian punggung, dengan diameter 3x4 cm, tampak nekrotik di bagian tengah, berbau ringan, dan mengeluarkan eksudat seropurulen.

Berdasarkan analisis data yang diperoleh dari hasil pengkajian subjektif dan objektif, perawat menetapkan **tiga diagnosa keperawatan utama**. Pertama, *integritas kulit tidak efektif* yang berhubungan dengan keberadaan ulkus diabetikum. Kondisi ini menunjukkan adanya kerusakan jaringan permukaan kulit yang disebabkan oleh gangguan sirkulasi mikro serta neuropati perifer yang lazim ditemukan pada penderita diabetes kronis. Kedua, *risiko infeksi* ditetapkan karena adanya luka terbuka yang berpotensi menjadi pintu masuk mikroorganisme, diperparah oleh keadaan hiperglikemia yang menurunkan daya tahan tubuh terhadap infeksi. Ketiga, *ketidakefektifan coping individu* ditentukan berdasarkan temuan bahwa pasien merasa putus asa, cemas terhadap kemungkinan amputasi, dan menunjukkan ketidakinginan untuk melibatkan diri dalam perawatan luka yang dianjurkan.

Sebagai tindak lanjut dari diagnosa tersebut, disusun **rencana asuhan keperawatan** yang bersifat holistik dan sistematis. Untuk mengatasi masalah gangguan integritas kulit, tindakan utama yang dirancang adalah **pemantauan kondisi luka setiap shift**. Pemantauan ini mencakup pengukuran panjang, lebar, dan kedalaman luka serta karakteristik eksudat dan tanda-tanda inflamasi lokal seperti eritema, edema, atau peningkatan suhu lokal. Dokumentasi luka dilakukan menggunakan alat ukur luka (wound ruler) dan skala klasifikasi seperti Wagner atau PEDIS (Perfusion, Extent, Depth, Infection, Sensation). Hal ini penting untuk mengetahui progres penyembuhan atau memburuknya kondisi luka.

Selanjutnya, pasien diberikan **edukasi terkait teknik perawatan luka mandiri** yang dapat dilakukan di rumah setelah pasien diperbolehkan pulang. Edukasi meliputi cara mencuci tangan yang benar, teknik mengganti balutan, pengenalan tanda-tanda infeksi, dan pentingnya menjaga kadar gula darah tetap terkontrol agar proses penyembuhan luka berlangsung optimal. Edukasi juga disesuaikan dengan tingkat pendidikan dan kemampuan literasi pasien, serta disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan empatik.

Tindakan kolaboratif dilakukan dengan **tim medis**, terutama dalam hal pemberian **antibiotik dan insulin**. Pemberian antibiotik dilakukan sesuai dengan

kultur dan sensitivitas jika tersedia, atau berdasarkan protokol infeksi luka diabetikum. Sementara insulin diberikan untuk mengontrol glukosa darah pasien dengan regimen yang disesuaikan berdasarkan pemeriksaan glukosa darah harian. Kolaborasi ini sangat penting karena kendali glikemik yang baik secara langsung mempengaruhi kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan mencegah infeksi lanjutan.

Setelah serangkaian intervensi dilaksanakan selama masa perawatan, dilakukan **evaluasi keperawatan** untuk menilai pencapaian tujuan. Hasil evaluasi menunjukkan adanya **perbaikan kondisi luka** yang ditandai dengan munculnya jaringan granulasi merah muda di dasar luka, penurunan eksudat, dan tidak adanya bau. Proses epitelisasi mulai terlihat di tepi luka, yang menandakan tahap awal regenerasi jaringan. Selain itu, pasien juga menunjukkan **kemampuan dalam melakukan perawatan mandiri** secara tepat dan teratur setelah beberapa kali diberi edukasi serta dilakukan demonstrasi ulang oleh perawat. Dalam aspek psikologis, pasien tampak lebih menerima kondisi penyakitnya, mulai menyampaikan keinginan untuk lebih rutin kontrol, serta mengajak anggota keluarganya berdiskusi tentang pengaturan pola makan dan gaya hidup sehat.

Secara keseluruhan, praktik manajemen asuhan keperawatan pada kasus Tn. A menunjukkan bahwa pendekatan sistematis, kolaboratif, dan edukatif dalam praktik keperawatan mampu menghasilkan **perubahan signifikan pada status kesehatan pasien**, baik dari segi fisik maupun psikologis. Mahasiswa yang terlibat dalam kasus kelolaan ini tidak hanya belajar melakukan prosedur klinis, tetapi juga mengasah kemampuan komunikasi terapeutik, kolaborasi interprofesional, dan pemberdayaan pasien melalui pendekatan edukatif yang berbasis empati dan penghargaan terhadap nilai-nilai personal pasien.

F. Latihan Soal

1. Apa tujuan utama dari praktik manajemen asuhan keperawatan (MAK) pada kasus kelolaan?
 - A. Mengembangkan kurikulum akademik berbasis simulasi
 - B. Melatih mahasiswa agar mampu melakukan intervensi keperawatan tanpa supervisi
 - C. Memberikan pengalaman klinik yang menekankan tanggung jawab manajerial dan klinis secara komprehensif
 - D. Menilai kemampuan dokter dalam supervisi keperawatan
 - E. Melatih penggunaan alat medis berteknologi tinggi
- Kunci Jawaban: C

2. Prinsip utama yang mendasari praktik kasus kelolaan adalah...

- A. Learning by memorizing
- B. Student-centered learning dan experiential learning
- C. Rigid instruction and task delegation
- D. Skill-based task repetition
- E. Top-down supervision

Kunci Jawaban: B

3. Dalam praktik kasus kelolaan, apa tanggung jawab utama mahasiswa terhadap pasien?

- F. Melaksanakan instruksi medis tanpa modifikasi
- G. Mengikuti perawat ruangan setiap shift
- H. Menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi proses keperawatan secara mandiri dengan supervisi
- I. Memberikan terapi invasif tanpa pengawasan
- J. Menjadi pembimbing praktik bagi mahasiswa lainnya

Kunci Jawaban: C

4. Salah satu manfaat praktik kasus kelolaan adalah mahasiswa mampu menerapkan EBNP. Hal ini berarti mahasiswa harus mampu...

- A. Membaca semua buku teks keperawatan
- B. Membuat jurnal sendiri untuk semua pasien
- C. Mencari dan menerapkan intervensi berdasarkan bukti ilmiah terbaru
- D. Menghindari semua praktik lama yang sudah tidak digunakan
- E. Mengandalkan intuisi dalam mengambil keputusan

Kunci Jawaban: C

5. Apa bentuk evaluasi yang dilakukan secara harian untuk memantau kondisi pasien dan respons terhadap intervensi keperawatan?

- A. Evaluasi formatif
- B. Evaluasi sumatif
- C. Ujian OSCE
- D. Laporan akhir kasus
- E. Refleksi kelompok

Kunci Jawaban: A

G. Rangkuman Materi

Praktik manajemen asuhan keperawatan (MAK) pada kasus kelolaan merupakan pendekatan pembelajaran klinik yang terintegrasi, berorientasi pada pengalaman nyata, serta dirancang untuk menciptakan lulusan keperawatan yang kompeten secara klinis dan manajerial. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diberikan tanggung jawab penuh dalam mengelola asuhan keperawatan secara menyeluruh kepada pasien tertentu, mulai dari tahap pengkajian hingga evaluasi, sekaligus menerapkan fungsi-fungsi manajemen keperawatan seperti perencanaan, koordinasi, delegasi, dan pengawasan.

Landasan filosofis dari praktik ini berakar pada experiential learning dan student-centered learning, yang memfokuskan proses pembelajaran pada pengalaman langsung mahasiswa dan mendorong keterlibatan aktif, tanggung jawab individu, serta pengembangan karakter profesional yang kuat. Praktik ini juga mengedepankan asuhan keperawatan holistik, yang mencakup aspek bio-psiko-sosio-kultural dan spiritual, sehingga mahasiswa tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga peka terhadap nilai dan kebutuhan manusiawi pasien.

Dengan keterlibatan penuh dalam praktik kasus kelolaan, mahasiswa tidak hanya belajar menerapkan proses keperawatan secara sistematis (pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi), tetapi juga mengembangkan kemampuan manajerial dan kepemimpinan klinis, seperti menyusun prioritas harian, mendokumentasikan tindakan secara legal dan etis, serta berkomunikasi dan berkolaborasi dengan tim kesehatan secara profesional. Praktik ini secara langsung membentuk kesiapan mahasiswa menghadapi dinamika dunia kerja di lingkungan klinik yang kompleks dan interdisipliner.

Di sisi lain, mahasiswa juga dibimbing untuk menerapkan prinsip Evidence-Based Nursing Practice (EBNP) dalam penyusunan intervensi, serta mengintegrasikan nilai-nilai etika, tanggung jawab profesional, dan sikap empatik dalam setiap aspek tindakan keperawatan. Semua ini membentuk perawat yang tidak hanya cakap berpikir kritis dan bertindak tepat, tetapi juga memiliki karakter yang kuat dalam menjunjung tinggi martabat dan hak pasien.

Melalui pembimbingan yang terstruktur oleh dosen dan preceptor klinik, evaluasi formatif dan sumatif yang berkelanjutan, serta pengalaman menangani kasus nyata seperti ulkus diabetikum pada pasien dengan DM tipe 2, praktik ini menjadi sarana belajar yang tidak tergantikan. Mahasiswa memperoleh wawasan mendalam tentang realitas pelayanan keperawatan, termasuk bagaimana mengelola kasus dengan pendekatan kolaboratif, memberdayakan pasien, dan melakukan edukasi kesehatan berbasis kebutuhan individual pasien.

Dengan demikian, praktik MAK pada kasus kelolaan bukan sekadar kegiatan rutin di lahan klinik, melainkan merupakan jembatan penting yang menghubungkan dunia akademik dengan dunia praktik, sekaligus menjadi fondasi pembentukan perawat yang kritis, terampil, komunikatif, profesional, dan manusiawi.

H. Glosarium

Manajemen Asuhan Keperawatan (MAK)

Proses pengorganisasian dan pengelolaan kegiatan asuhan keperawatan yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, supervisi, dan evaluasi untuk memastikan kualitas pelayanan.

NANDA-I

Singkatan dari North American Nursing Diagnosis Association – International, organisasi yang menyusun klasifikasi standar internasional untuk diagnosa keperawatan.

Pola Fungsi Kesehatan Gordon

Model pengkajian keperawatan yang terdiri dari 11 pola yang mencakup dimensi bio-psiko-sosial-spiritual, digunakan untuk memahami kebutuhan pasien secara komprehensif.

Proses Keperawatan

Kerangka sistematis yang terdiri dari lima tahap: pengkajian, diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi, yang digunakan untuk memberikan asuhan keperawatan secara profesional.

SOAP / SOAPIE

Format dokumentasi keperawatan: Subjective, Objective, Assessment, Plan, Intervention, Evaluation. Digunakan untuk mencatat alur tindakan dan respons pasien.

Student-Centered Learning

Pendekatan pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat proses belajar, yang bertanggung jawab terhadap pencapaian dan refleksi atas pembelajaran yang dilakukan.

Supervisi Klinik

Bimbingan langsung oleh pembimbing praktik (preceptor atau dosen klinik) terhadap mahasiswa dalam pelaksanaan tindakan keperawatan di lapangan, untuk menjamin keamanan dan mutu asuhan.

Tindakan Keperawatan

Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perawat atau mahasiswa untuk mencapai tujuan keperawatan yang telah direncanakan sebelumnya.

Tujuan SMART

Acuan dalam menyusun tujuan asuhan keperawatan yang harus: Spesifik, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound (terukur dan terbatas waktu).

I. Daftar Pustaka

- American Nurses Association. (2015). *Nursing: Scope and standards of practice* (3rd ed.). American Nurses Association.
- Bulechek, G. M., Butcher, H. K., Dochterman, J. M., & Wagner, C. (2016). *Nursing Interventions Classification (NIC)* (7th ed.). Elsevier.
- Doenges, M. E., Moorhouse, M. F., & Murr, A. C. (2019). *Nursing care plans: Guidelines for individualizing client care across the life span* (10th ed.). F.A. Davis Company.
- Gordon, M. (1994). *Manual of nursing diagnosis* (10th ed.). Mosby-Year Book.
- NANDA International. (2021). *NANDA International nursing diagnoses: Definitions and classification 2021–2023*. Thieme Medical Publishers.
- Potter, P. A., & Perry, A. G. (2021). *Fundamentals of nursing* (11th ed.). Elsevier.
- Smeltzer, S. C., Bare, B. G., Hinkle, J. L., & Cheever, K. H. (2010). *Brunner & Suddarth's textbook of medical-surgical nursing* (12th ed.). Lippincott Williams & Wilkins.
- Swan, B. A., Conway-Phillips, R., & Griffin, K. F. (2006). Demonstrating the value of the RN in ambulatory care. *Nursing Economics*, 24(6), 315–322.
- Wilkinson, J. M. (2016). *Nursing process and critical thinking* (6th ed.). Pearson Education.

BAB 7

PRAKTIK MANAJEMEN ASUHAN KEPERAWATAN SEBAGAI ANGGOTA TIM KESEHATAN/KEPERAWATAN

Tujuan Intruksional:

Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu:

1. Memahami Konsep Manajemen keperawatan:

Peserta didik diharapkan mampu memahami konsep manajemen keperawatan sebagai dasar untuk mengelola pelayanan keperawatan secara efektif dan efisien. Pemahaman ini mencakup kemampuan untuk mengenali prinsip-prinsip, proses, dan elemen-elemen manajemen yang diperlukan dalam pengelolaan sumber daya keperawatan, baik manusia maupun material, untuk memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas.

2. Memahami Konsep Manajemen Asuhan keperawatan:

Peserta didik diharapkan mampu memahami konsep manajemen asuhan keperawatan sebagai bagian integral dari praktik keperawatan yang efektif. Pemahaman ini mencakup pengetahuan tentang prinsip-prinsip manajemen, proses keperawatan, serta penerapan konsep-konsep manajemen dalam konteks asuhan keperawatan

Capaian Pembelajaran:

1. Mahasiswa Mampu Memahami Konsep Dasar Manajemen Keperawatan
2. Mahasiswa Mampu Menganalisis konsep dasar manajemen keperawatan
3. Mahasiswa Mampu Memahami Konsep Dasar Manajemen Asuhan Keperawatan
4. Mahasiswa Mampu Menerapkan Manajemen Asuhan Keperawatan

Pendahuluan:

Judul: Praktik Manajemen asuhan keperawatan sebagai anggota tim kesehatan/Keperawatan

Pengantar Penulis:

Manajemen asuhan keperawatan merupakan salah satu kemampuan yang perlu dipenuhi oleh perawat dalam menyiapkan pelayanan kesehatan berkualitas. Sebagai anggota tim kesehatan, perawat tidak hanya bertanggung jawab dalam memberikan asuhan keperawatan kepada pasien, tetapi juga dalam mengelola sumber daya, berkolaborasi dengan profesi lain, dan memastikan tercapainya tujuan pelayanan kesehatan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, buku ini disusun untuk membantu pembaca memahami prinsip-prinsip manajemen asuhan keperawatan serta mengaplikasikannya dalam konteks kerja tim di lingkungan pelayanan kesehatan.

Buku ini dirancang sebagai panduan praktis bagi mahasiswa keperawatan, perawat profesional, serta tenaga kesehatan lainnya yang ingin memahami dan menerapkan konsep manajemen asuhan keperawatan dalam praktik klinis.

Tujuan Buku:

Memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Konsep Manajemen keperawatan
Memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Konsep Manajemen Asuhan keperawatan

Sasaran Pembaca:

Berikut adalah beberapa kelompok pembaca yang diharapkan dapat memanfaatkan buku ini:

1. Mahasiswa Keperawatan

Buku ini disusun untuk membantu mahasiswa dalam memahami konsep manajemen asuhan keperawatan dan mengaplikasikannya dalam praktik klinis. Dengan pengetahuan yang diperoleh, diharapkan mereka dapat memberikan kontribusi yang efektif dalam tim kesehatan.

2. Perawat Profesional

Perawat yang telah berpengalaman dapat menjadikan buku ini sebagai referensi untuk meningkatkan keterampilan manajerial dalam mengelola tim keperawatan dan perawatan pasien. Hal ini sangat penting bagi perawat yang memiliki peran dalam supervisi, koordinasi, dan peningkatan mutu pelayanan keperawatan di berbagai unit atau fasilitas kesehatan.

3. Dosen Keperawatan

Buku ini juga ditujukan kepada dosen keperawatan yang mengajar mata kuliah manajemen keperawatan. Mereka dapat memanfaatkan materi dalam buku ini untuk menyusun kurikulum dan bahan ajar yang relevan dan terkini.

4. Anggota Tim Kesehatan Lainnya

Buku ini bermanfaat bagi anggota tim kesehatan lainnya, seperti dokter, apoteker, dan profesional kesehatan lainnya, untuk memahami peran manajemen dalam asuhan keperawatan dan memperkuat kolaborasi antarprofesi.

5. Manajer atau Administrator Kesehatan

Buku ini juga dapat digunakan oleh manajer atau administrator di rumah sakit dan institusi kesehatan lainnya sebagai panduan untuk mengelola sumber daya keperawatan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

6. Peneliti di Bidang Manajemen Keperawatan

Peneliti yang tertarik pada topik manajemen keperawatan dapat menemukan wawasan baru dalam buku ini yang dapat memperkaya penelitian mereka.

Uraian Materi

Uraian materi dalam buku ajar adalah deskripsi atau penjelasan tentang topik atau subjek tertentu yang disusun secara sistematis dan terstruktur. Materi tersebut dapat mencakup konsep, teori, prinsip, fakta, contoh, dan aplikasi dari subjek yang dibahas. Uraian materi dalam buku ajar biasanya disesuaikan dengan target audiens dan tujuan pembelajaran, serta disusun dengan cara yang mudah dipahami oleh pembaca. Tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi dengan jelas, lengkap, dan terorganisir sehingga pembaca dapat memahami dan menguasai materi yang diajarkan.

A. Manajemen Keperawatan

Manajemen keperawatan pada dasarnya adalah upaya untuk mengelola semua sumber daya yang ada di lapangan keperawatan. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk menyediakan pelayanan keperawatan profesional dan berkualitas bagi pasien. Proses ini melibatkan beberapa fungsi manajemen yang dikenal dengan POAC, yaitu perencanaan (*planning*); pengorganisasian (*organizing*); pengarahan (*actuating*); pengawasan (*controlling*).

1. Definisi Manajemen Keperawatan

Menurut Endang Shyta Triana dan Feriyanto (2015), manajemen adalah inti dari administrasi, di mana manajemen berfungsi sebagai alat pelaksana administrasi yang memiliki peran atau kemampuan untuk mencapai tujuan melalui tenaga kerja. Definisi ini menekankan pentingnya manajemen dalam mengatur dan mengarahkan sumber daya manusia untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam organisasi.

Menurut Nursalam (2013), manajemen keperawatan adalah suatu proses yang melibatkan kerja sama antara anggota tim keperawatan untuk memberikan asuhan keperawatan secara profesional. Proses ini selaras dengan langkah-langkah dalam proses keperawatan, seperti pengumpulan data, identifikasi masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi hasil. Karena itu, manajemen keperawatan berperan sebagai wadah untuk koordinasi dan integrasi sumber daya keperawatan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam pemberian asuhan keperawatan.

Menurut Bakri (2017), manajemen keperawatan merupakan proses delegasi tugas kepada anggota staf keperawatan untuk menyediakan layanan asuhan keperawatan dengan cara yang profesional. Seorang manajer keperawatan diharapkan mampu menjalankan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan evaluasi sarana serta prasarana yang

tersedia. Tujuannya adalah untuk memberikan pelayanan asuhan keperawatan yang efektif dan efisien bagi individu, keluarga, dan masyarakat

Secara umum, manajemen adalah salah satu komponen utama di administrasi dengan tujuan untuk mencapai hasil organisasi melalui pengelolaan sumber daya manusia. Manajemen keperawatan dalam perawatan melibatkan tim kerja bersama untuk menyerahkan asuhan yang terkoordinir dan profesional, melalui tahap-tahap seperti pengumpulan informasi, analisis masalah, perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil. Selain itu, manajemen keperawatan juga mencakup delegasi tugas kepada staf untuk memastikan pelayanan berkualitas, dengan kepala keperawatan bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan evaluasi sumber daya guna mencapai pelayanan yang efektif dan efisien.

2. Fungsi Manajemen Keperawatan

Manajemen keperawatan memiliki peran penting dalam pengelolaan layanan kesehatan, yang terkait dengan beberapa aktivitas untuk menjaga layanan yang efektif dan efisiensi. Berikut ini adalah penjabaran fungsi-fungsi manajemen keperawatan:

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan dalam manajemen keperawatan dapat dipahami sebagai proses kognitif yang melibatkan pengambilan keputusan dan perencanaan masa depan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Proses ini mencakup penetapan arah dan strategi yang akan diikuti oleh organisasi keperawatan.

Langkah-langkah Perencanaan:

- 1) Penetapan Tujuan: Menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ingin dicapai oleh unit keperawatan.
- 2) Identifikasi Kebutuhan: Mengidentifikasi kebutuhan pasien dan sumber daya yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
- 3) Pengembangan Rencana: Merumuskan rencana aktivitas kerja yang mencakup intervensi keperawatan yang tepat, serta kriteria hasil yang diharapkan
- 4) Penetapan Prioritas: Mengurutkan prioritas berdasarkan urgensi dan pentingnya kebutuhan pasien, serta sumber daya yang tersedia

Faktor-Faktor Pendukung Perencanaan:

- 1) Analisa Situasi: Melakukan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk memahami kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelayanan keperawatan

- 2) Keterlibatan Tim: Melibatkan seluruh anggota tim keperawatan dalam proses perencanaan untuk memastikan bahwa semua perspektif dan kebutuhan pasien diperhatikan
- 3) Evaluasi Berkelanjutan: Melakukan evaluasi terhadap rencana yang telah dibuat untuk menyesuaikan dengan perubahan situasi atau kebutuhan pasien.

b. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian dalam manajemen keperawatan dapat dijelaskan sebagai proses pengaturan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun materi, untuk melaksanakan rencana yang telah disusun. Proses ini mencakup pembagian tugas, penetapan tanggung jawab, serta pengaturan struktur organisasi yang efektif agar setiap anggota tim dapat memberikan kontribusi secara optimal.

Langkah-langkah Pengorganisasian:

- 1) Pembentukan Struktur Organisasi: menetapkan hierarki dan jalur komunikasi yang jelas di dalam tim keperawatan, termasuk peran dan tanggung jawab masing-masing anggota. Struktur ini biasanya dimulai dari manajemen puncak (seperti kepala bidang keperawatan) hingga kepala ruangan.
- 2) Pengelompokan Tugas: Mengelompokkan aktivitas keperawatan berdasarkan fungsi atau spesialisasi untuk meningkatkan efisiensi. Ini juga mencakup penentuan metode pengawasan yang tepat untuk setiap kelompok kerja.
- 3) Penugasan Tanggung Jawab: Menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas setiap tugas atau kegiatan, sehingga ada kejelasan mengenai siapa yang melapor kepada siapa dan tanggung jawab masing-masing individu.
- 4) Koordinasi Kegiatan: Membangun mekanisme untuk memastikan bahwa semua bagian dari tim keperawatan bekerja sama dengan baik, baik secara horizontal (antar tim) maupun vertikal (antara manajemen dan staf).
- 5) Monitoring dan Evaluasi: Melakukan evaluasi berkala terhadap struktur organisasi dan pembagian tugas untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana dan melakukan penyesuaian jika diperlukan

c. Pengarahan (Directing)

Pengarahan merupakan proses pelaksanaan perencanaan layanan keperawatan guna mencapai tujuan pelayanan yang optimal. Proses ini melibatkan pengelolaan sumber daya manusia melalui motivasi, manajemen konflik, pendelegasian, komunikasi, serta fasilitasi kolaborasi. Pengarahan juga

mencakup upaya untuk memimpin kelompok, menciptakan semangat kerja yang tinggi, dan mendorong untuk bekerja dengan penuh dedikasi.

Elemen-Elemen dalam Pengarahan:

- 1) Motivasi: Memberikan motivasi dan semangat kepada staf agar dapat mencapai kinerja yang optimal.
- 2) Komunikasi: Menjamin adanya komunikasi yang efektif untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan pemahaman yang seragam di antara anggota tim.
- 3) Kepemimpinan: Mengarahkan dan memotivasi staf untuk mencapai tujuan organisasi, yang melibatkan kemampuan untuk bersikap adil, bijaksana, dan terampil dalam kepemimpinan.
- 4) Delegasi: Mendelegasikan tugas kepada anggota tim sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
- 5) Supervisi: Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas untuk memastikan kualitas pelayanan yang diberikan.

d. Pengawasan (*Controlling*)

Pengendalian adalah proses yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan rencana serta tindakan yang telah direncanakan, dengan tujuan memastikan bahwa tujuan perawatan tercapai secara efektif dan efisien. Pengendalian juga mencakup penilaian kinerja, pengelolaan risiko, serta perbaikan berkelanjutan dalam pelayanan keperawatan.

Langkah-Langkah dalam Pengendalian:

- 1) Penetapan Standar: Menetapkan tolok ukur atau standar kinerja yang diharapkan, seperti kualitas layanan, kepuasan pasien, dan efisiensi biaya.
- 2) Pengukuran Kinerja: Mengukur kinerja aktual dengan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan, termasuk evaluasi hasil pelayanan keperawatan dan pengumpulan data terkait.
- 3) Pelaporan Hasil: Mengkomunikasikan hasil pengukuran kepada manajemen dan tim keperawatan untuk memberikan informasi tentang kinerja yang telah dicapai.
- 4) Tindakan korektif: Apabila terdapat perbedaan antara kinerja aktual dan standar, tindakan korektif harus dilakukan, seperti penyesuaian proses kerja, pelatihan tambahan untuk staf, atau perubahan kebijakan.
- 5) Reorientasi dan Penyesuaian: Menyesuaikan rencana dan strategi berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan di masa yang akan datang.

Fungsi pengendalian sangat penting dalam manajemen keperawatan karena:

- 1) Menjamin Kualitas Pelayanan: dengan melaksanakan pengendalian, manajer keperawatan dapat memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan.
- 2) Mengelola Risiko: Pengendalian juga berperan dalam mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko yang mungkin muncul selama proses perawatan, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien.
- 3) Perbaikan Berkelanjutan: Proses pengendalian mendorong evaluasi yang berkelanjutan terhadap praktik keperawatan, memungkinkan terjadinya perbaikan yang terus-menerus dalam pelayanan

e. Ketenagaan (*Staffing*)

Ketenagaan merujuk pada aktivitas manajer keperawatan dalam proses perekrutan, pelatihan, penempatan, dan pengembangan staf keperawatan untuk memastikan pelayanan kesehatan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Menurut Marquis dan Huston (2010), ketenagaan mencakup evaluasi kebutuhan tenaga kerja, pengaturan jadwal, serta pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi.

Langkah-Langkah dalam Ketenagaan:

- 1) Analisis Kebutuhan Tenaga: Menilai jumlah dan jenis tenaga keperawatan yang diperlukan berdasarkan beban kerja, jumlah pasien, serta kompleksitas perawatan yang dibutuhkan.
- 2) Perekrutan dan Seleksi: Melakukan perekrutan untuk mencari kandidat yang memenuhi kualifikasi, diikuti dengan proses seleksi yang ketat untuk memastikan bahwa hanya perawat yang berkualitas dan terampil yang diterima.
- 3) Orientasi dan Pelatihan: Memberikan orientasi kepada staf baru terkait kebijakan, prosedur, dan budaya organisasi, serta menyediakan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan perawat.
- 4) Penjadwalan: Mengatur jadwal kerja yang efisien guna memastikan setiap shift terisi dengan staf yang cukup, sambil mempertimbangkan kebutuhan pasien dan kesejahteraan staf.
- 5) Pengawasan dan Evaluasi: Melakukan pengawasan terhadap kinerja staf serta melakukan evaluasi secara berkala untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut.

3. Prinsip-Prinsip Manajemen Keperawatan

Prinsip dapat didefinisikan sebagai pernyataan dasar atau kebenaran umum yang menjadi pedoman dalam berpikir dan bertindak. Menurut Fransiska (2021), prinsip-prinsip manajemen dalam keperawatan meliputi:

a. Pembagian Kerja

Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan dan keahlian agar pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan efektif. Pembagian kerja yang baik adalah kunci keberhasilan dalam pekerjaan, sedangkan pembagian yang ceroboh dapat berisiko menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan tugas.

b. Disiplin

Disiplin adalah kepatuhan terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawab. Disiplin sangat terkait dengan wewenang; jika wewenang tidak dijalankan dengan baik, disiplin akan hilang. Oleh karena itu, pemegang wewenang harus menanamkan disiplin pada dirinya untuk bertanggung jawab terhadap pekerjaan sesuai dengan wewenang yang dimilikinya.

c. Wewenang dan Tanggung Jawab

Wewenang dan tanggung jawab harus seimbang. Setiap tugas harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan wewenang yang ada. Oleh karena itu, semakin kecil wewenang, semakin kecil pula tanggung jawab yang harus diemban, dan sebaliknya.

d. Kesatuan Perintah

Dalam melaksanakan tugas, perawat harus mengikuti prinsip kesatuan perintah agar pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan baik.

e. Kesatuan Pengarahan

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, perawat perlu diarahkan menuju tujuan yang jelas. Kesatuan pengarahan erat kaitannya dengan pembagian kerja dan kesatuan perintah, yang mencegah adanya perintah yang bertentangan dalam pelaksanaan kerja.

f. Penggajian

Gaji atau upah bagi perawat adalah kompensasi yang sangat penting untuk kelancaran pekerjaan. Oleh karena itu, prinsip penggajian harus mempertimbangkan cara untuk membuat perawat dapat bekerja dengan tenang dan fokus.

g. Pemusatan

Pemusatan wewenang dapat menyebabkan pemusatan tanggung jawab dalam suatu kegiatan. Pemusatan ini bertujuan untuk menghindari kebingungan dalam wewenang dan tanggung jawab, bukan untuk menciptakan kekuasaan yang berlebihan.

h. Hierarki

Hierarki mengatur urutan wewenang, dimulai dari manajer puncak dan terus ke bawah. Dengan adanya hierarki, setiap perawat dapat mengetahui kepada siapa mereka harus bertanggung jawab dan dari siapa mereka menerima perintah.

i. Ketertiban

Ketertiban dalam melaksanakan pekerjaan adalah syarat utama karena tidak ada orang yang bisa bekerja dengan baik dalam keadaan kacau atau tegang. Oleh karena itu, ketertiban dan disiplin sangat diperlukan untuk mencapai tujuan.

j. Keadilan dan Kejujuran

Keadilan dan kejujuran adalah syarat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keadilan dan kejujuran berhubungan dengan moral perawat dan tidak dapat dipisahkan, serta harus ditegakkan mulai dari atas hingga ke bawah.

k. Prakarsa

Prakarsa atau inisiatif berarti menghargai orang lain, karena setiap individu memerlukan penghargaan. Penolakan terhadap prakarsa perawat dapat mengurangi semangat kerja.

l. Semangat Kesatuan

Setiap perawat harus memiliki rasa kesatuan dan saling mendukung, yang menciptakan semangat kerja sama yang baik. Semangat kesatuan muncul ketika perawat menyadari bahwa mereka saling membutuhkan dan bekerja untuk tujuan yang sama.

m. Stabilitas

Stabilitas kerja perawat tercapai melalui disiplin kerja yang baik dan ketertiban dalam kegiatan, yang mendukung kelancaran dan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas.

B. Konsep Asuhan Manajemen Keperawatan

1. M1 (MAN)

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia (SDM) mengacu pada potensi yang dimiliki individu untuk memenuhi peran sosialnya yang adaptif dan transformatif. SDM mampu mengelola dirinya sendiri serta seluruh potensi yang ada untuk mencapai kesejahteraan dalam suatu tatanan yang seimbang dan berkelanjutan. Manajemen SDM merupakan suatu ilmu atau cara yang digunakan untuk mengatur hubungan serta peran tenaga kerja secara efisien dan efektif,

sehingga tujuan bersama antara perusahaan, karyawan, dan klien dapat tercapai dengan maksimal.

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah pola hubungan yang menggambarkan bagaimana kompetensi dan bagian-bagian organisasi berinteraksi. Dalam organisasi formal, struktur ini dirancang untuk menetapkan pola hubungan antar berbagai komponen agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif.

c. Visi dan Misi

Visi adalah pernyataan yang menggambarkan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh organisasi di masa depan. Sebaliknya, misi adalah pernyataan yang menggambarkan tindakan atau tujuan yang ingin dicapai dalam waktu dekat atau saat ini.

2. M2 (MATERIAL)

Material adalah salah satu metode dalam manajemen keperawatan yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Kebutuhan material sering kali tidak pasti.
- b. Material berpengaruh besar terhadap kelancaran proses pelayanan.
- c. Keberadaan atau kekurangan material dapat berdampak pada biaya.
- d. Material sering kali memiliki porsi terbesar dalam neraca.

Material terdiri dari bahan setengah jadi (raw material) dan bahan jadi. Dalam dunia usaha, selain membutuhkan tenaga kerja yang ahli, penggunaan bahan atau materi yang tepat sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Tanpa materi, hasil yang diharapkan tidak akan tercapai.

3. M3 (METHODE)

a. **Model Asuhan Keperawatan Profesional (MAKP)**

Terdapat lima metode pemberian asuhan keperawatan profesional yang terus berkembang untuk menghadapi tren pelayanan keperawatan, baik untuk perawat privat maupun untuk perawatan khusus seperti isolasi atau perawatan intensif. Kelebihannya, perawat dapat lebih memahami kasus per kasus, dan evaluasi manajerial menjadi lebih mudah. Namun, kekurangannya adalah kesulitan dalam mengidentifikasi perawat yang bertanggung jawab dan membutuhkan jumlah tenaga perawat yang cukup banyak dengan kemampuan dasar yang setara. Metode MAKP terbagi menjadi beberapa jenis:

- 1) Metode Primer Dalam metode ini, seorang perawat profesional bertanggung jawab penuh terhadap asuhan keperawatan pasien selama 24 jam. Tanggung jawab tersebut mencakup pengkajian, perencanaan, implementasi, dan evaluasi asuhan keperawatan dari awal pasien masuk hingga pasien keluar rumah sakit.

- 2) Metode Modular Model ini mirip dengan model keperawatan tim, di mana tenaga profesional dan non-profesional bekerja sama dalam memberikan asuhan keperawatan kepada beberapa pasien, dengan arahan dari perawat profesional.
- 3) Metode Fungsional Dalam metode ini, perawat melaksanakan tugas tertentu berdasarkan jadwal yang telah ditentukan. Metode ini digunakan ketika jumlah perawat terbatas.
- 4) Metode Kasus Metode ini biasanya diterapkan di ruang perawatan seperti ruang intensif atau isolasi, di mana perawat tidak bertanggung jawab penuh terhadap asuhan keperawatan pasien. Setiap perawat hanya bertanggung jawab selama shift mereka, dan pasien dirawat oleh perawat yang berbeda setiap shift.
- 5) Metode Tim Dalam metode tim, perawat di unit rawat inap dibagi menjadi beberapa grup kecil yang terdiri dari tenaga profesional dan teknis, yang saling membantu dalam memberikan pelayanan. Model ini digunakan untuk memastikan pelayanan yang menyeluruh dan komunikasi antar anggota tim yang efektif.

Kelebihan dan Kekurangan Metode Tim:

Kelebihan: Memungkinkan pelayanan yang menyeluruh dan mendukung pelaksanaan proses keperawatan. Tim juga dapat berkomunikasi lebih baik, sehingga konflik lebih mudah diselesaikan dan anggota tim merasa puas.

Kekurangan: Komunikasi antar anggota tim dapat terbentuk terutama melalui konferensi tim, yang memerlukan waktu dan sulit dilaksanakan saat waktu sibuk.

C. Latihan Soal

1. Kepala Ruang unit penyakit dalam sedang menyusun jadwal dinas perawat untuk minggu depan. Kepala ruang mempertimbangkan jumlah pasien dengan berbagai tingkat ketergantungan serta jumlah perawat dengan kompetensi yang berbeda. Kepala Ruang berupaya memastikan setiap shift memiliki jumlah perawat yang adekuat dan sesuai dengan kebutuhan pasien. Fungsi manajemen keperawatan yang sedang diterapkan oleh Kepala Ruang adalah...
 - A. Perencanaan (*Planning*)
 - B. Pengorganisasian (*Organizing*)
 - C. Pengarahan (*Directing*)
 - D. Ketenagaan (*Staffing*)
 - E. Pengawasan (*Controlling*)

2. Di unit gawat darurat, jumlah pasien seringkali tidak terduga dan membutuhkan tindakan yang cepat. Perawat ditugaskan berdasarkan jenis tindakan yang harus dilakukan, seperti pemasangan infus, pemberian obat injeksi, atau pemantauan tanda vital. Setiap perawat fokus pada keterampilan tertentu untuk menangani berbagai situasi kegawatdaruratan. Model MAKP yang diterapkan di unit ini adalah...
- A. Primer
 - B. Tim
 - C. Kasus
 - D. Modular
 - E. Fungsional
3. Kepala Bidang Keperawatan melakukan evaluasi terhadap implementasi standar asuhan keperawatan di seluruh unit rawat inap. Kepala ruang membandingkan catatan asuhan dengan standar yang telah ditetapkan, mengumpulkan data kepuasan pasien, dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan mutu pelayanan keperawatan. Fungsi manajemen keperawatan yang sedang dijalankan oleh Kepala Bidang Keperawatan adalah...
- A. Perencanaan (*Planning*)
 - B. Pengorganisasian (*Organizing*)
 - C. Pengarahan (*Directing*)
 - D. Pengawasan (*Controlling*)
 - E. Ketenagaan (*Staffing*)
4. Dalam tim keperawatan di unit rawat inap anak, setiap perawat memiliki pemahaman yang sama mengenai tujuan perawatan pasien dan alur kerja yang telah ditetapkan. Semua tindakan keperawatan yang dilakukan oleh setiap anggota tim selalu mengacu pada rencana asuhan yang telah disepakati bersama. Prinsip manajemen keperawatan yang tampak dominan dalam situasi ini adalah...
- A. Pembagian Kerja
 - B. Disiplin
 - C. Wewenang dan Tanggung Jawab
 - D. Kesatuan Pengarahan
 - E. Hierarki
5. Kepala Bidang Keperawatan mengadakan pertemuan rutin dengan seluruh Kepala Ruang untuk membahas kebijakan baru terkait dokumentasi asuhan keperawatan. Dalam pertemuan tersebut, Kepala Bidang Keperawatan menjelaskan secara rinci alur dokumentasi yang baru dan memastikan semua Kepala Ruang memahami dan akan menerapkannya di unit masing-masing.

Prinsip manajemen keperawatan yang diterapkan oleh Kepala Bidang Keperawatan adalah...

- A. Penggajian
- B. Pemusatan
- C. Kesatuan Perintah
- D. Hierarki
- E. Ketertiban

6. Puskesmas Harapan di daerah terpencil memiliki keterbatasan jumlah perawat. Untuk menjangkau lebih banyak pasien di komunitas, beberapa perawat senior berinisiatif membuka praktik keperawatan mandiri di jam tertentu di luar jam kerja puskesmas. Model praktik keperawatan yang diterapkan oleh perawat senior tersebut adalah...

- A. Praktik Keperawatan di Rumah Sakit
- B. Praktik Keperawatan di Rumah (Home Care)
- C. Praktik Keperawatan Berkelompok
- D. Praktik Keperawatan Individual
- E. Model Keperawatan Tim

7. Tim keperawatan di sebuah klinik berencana mengembangkan layanan perawatan di rumah bagi pasien pasca operasi. Mereka akan berkolaborasi dengan perawat profesional dari rumah sakit dan juga melibatkan perawat lain yang memiliki minat dalam home care. Model praktik keperawatan yang akan dikembangkan oleh tim ini adalah...

- A. Praktik Keperawatan Individual
- B. Praktik Keperawatan di Rumah Sakit
- C. Praktik Keperawatan di Rumah (Home Care) melalui kolaborasi
- D. Praktik Keperawatan Fungsional
- E. Model Manajemen Kasus

8. Sebelum memutuskan model asuhan keperawatan yang baru, Kepala Bidang Keperawatan Rumah Sakit melakukan analisis biaya dan manfaat dari beberapa opsi model. Kepala Bidang mempertimbangkan alokasi sumber daya perawat, potensi pengurangan hari rawat pasien, dan efisiensi. Prioritas utama dalam pemilihan model adalah dampaknya terhadap anggaran rumah sakit dan efisiensi operasional. Dasar pertimbangan pemilihan MAKP yang paling menonjol adalah...

- A. Keselarasan dengan Visi dan Misi Institusi
- B. Implementasi Proses Keperawatan

- C. Efisiensi dan Efektivitas Biaya
 - D. Pemenuhan Kepuasan Klien, Keluarga, dan Masyarakat
 - E. Kepuasan Kinerja Perawat
9. Ketua tim keperawatan di ruang penyakit dalam memimpin diskusi tim setiap pagi setelah menerima laporan shift. Dalam diskusi tersebut, setiap anggota tim menyampaikan perkembangan kondisi pasien yang menjadi tanggung jawabnya, mengidentifikasi masalah keperawatan, dan merencanakan intervensi selanjutnya secara bersama-sama. Kegiatan ini menunjukkan pentingnya... dalam metode tim.
- A. Pembagian tugas yang rigit
 - B. Supervisi langsung oleh Kepala Ruang
 - C. Komunikasi yang efektif antar anggota tim
 - D. Otonomi penuh setiap anggota tim
 - E. Fokus pada tugas-tugas teknis
10. Seorang perawat vokasi merasa kurang yakin dalam melakukan perawatan luka yang kompleks pada pasien di timnya dan kemudian berkonsultasi dengan ketua tim yang merupakan perawat profesional. Ketua tim memberikan penjelasan, demonstrasi, dan supervisi langsung saat perawat vokasi tersebut melakukan tindakan. Tanggung jawab ketua tim yang ditunjukkan dalam situasi ini adalah...
- A. Memberikan supervisi dan mengembangkan kompetensi anggota tim
 - B. Memberikan asuhan keperawatan langsung kepada semua pasien
 - C. Mengatur jadwal dinas seluruh anggota tim
 - D. Melakukan audit dokumentasi keperawatan
 - E. Memimpin serah terima pasien antar shift

Kunci Jawaban

- 1. D
- 2. E
- 3. D
- 4. D
- 5. C
- 6. D
- 7. C
- 8. C
- 9. C
- 10. A

D. Rangkuman Materi

Manajemen Keperawatan merupakan fondasi penting dalam dunia pelayanan kesehatan, esensinya adalah pengelolaan seluruh sumber daya di ranah keperawatan demi terwujudnya pelayanan yang profesional dan berkualitas bagi pasien. Proses ini terstruktur melalui fungsi-fungsi manajemen yang dikenal luas dengan akronim POAC: perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling).

Definisi Manajemen Keperawatan dari berbagai ahli mengerucut pada inti yang sama. Manajemen dipandang sebagai ruh dari administrasi, alat pelaksana yang memberdayakan tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks keperawatan, ini adalah proses kolaboratif antar anggota tim untuk memberikan asuhan yang profesional, selaras dengan tahapan proses keperawatan itu sendiri: mulai dari pengumpulan data hingga evaluasi hasil. Manajemen Keperawatan juga mencakup pendelegasian tugas yang efektif oleh seorang manajer keperawatan yang cakap dalam merencanakan, mengorganisir, memimpin, dan mengevaluasi sumber daya demi pelayanan yang efektif dan efisien bagi individu, keluarga, dan masyarakat.

Fungsi-fungsi Manajemen Keperawatan memegang peranan krusial dalam menjaga efektivitas dan efisiensi layanan kesehatan. Perencanaan adalah proses kognitif dalam pengambilan keputusan dan perancangan masa depan, meliputi penetapan tujuan, identifikasi kebutuhan pasien dan sumber daya, pengembangan rencana tindakan keperawatan, dan penetapan prioritas. Keberhasilannya didukung oleh analisis situasi yang komprehensif (SWOT), keterlibatan seluruh tim, dan evaluasi berkelanjutan.

Pengorganisasian adalah penataan sumber daya, baik manusia maupun materi, untuk merealisasikan rencana. Ini melibatkan pembentukan struktur organisasi yang jelas, pengelompokan tugas berdasarkan fungsi, penugasan tanggung jawab yang terukur, koordinasi kegiatan antar tim dan tingkatan manajemen, serta monitoring dan evaluasi struktur organisasi secara berkala.

Pengarahan adalah implementasi rencana keperawatan untuk mencapai tujuan pelayanan yang optimal. Proses ini berfokus pada pengelolaan sumber daya manusia melalui motivasi, manajemen konflik, pendelegasian tugas sesuai kompetensi, komunikasi yang efektif, kepemimpinan yang adil dan bijaksana, serta supervisi untuk memastikan kualitas pelayanan.

Pengawasan adalah proses pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan tindakan, memastikan tujuan perawatan tercapai secara efektif dan efisien. Langkah-langkahnya meliputi penetapan standar kinerja, pengukuran kinerja aktual, pelaporan hasil, tindakan korektif jika ada penyimpangan, serta reorientasi dan

penyesuaian rencana untuk perbaikan berkelanjutan. Fungsi ini esensial dalam menjamin kualitas pelayanan, mengelola risiko, dan mendorong perbaikan berkelanjutan dalam praktik keperawatan.

Selain POAC, fungsi Ketenagaan (Staffing) juga memegang peranan vital. Ini mencakup serangkaian aktivitas mulai dari analisis kebutuhan tenaga, perekrutan dan seleksi staf yang kompeten, orientasi dan pelatihan, penjadwalan kerja yang efisien, hingga pengawasan dan evaluasi kinerja staf. Tujuannya adalah memastikan ketersediaan tenaga keperawatan yang tepat untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien.

Dalam menjalankan fungsi-fungsi tersebut, Manajemen Keperawatan berpegang pada sejumlah Prinsip. Prinsip-prinsip ini menjadi pedoman dalam berpikir dan bertindak, meliputi pembagian kerja yang sesuai keahlian, disiplin dalam menjalankan tanggung jawab, keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab, kesatuan perintah dan pengarahan untuk menghindari kebingungan, sistem penggajian yang adil, pemusatan wewenang yang terukur, hierarki yang jelas, ketertiban dalam bekerja, keadilan dan kejujuran, pemberian ruang untuk prakarsa, semangat kesatuan tim, serta stabilitas kerja.

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dalam konteks keperawatan adalah pendekatan sistematis dalam merekrut, mengembangkan potensi, memotivasi, dan mengevaluasi staf keperawatan untuk mencapai target organisasi. Konsep ini menekankan penempatan individu yang tepat pada posisi yang tepat (*the man on the right place*) serta pengembangan kompetensi berkelanjutan. Fungsi utama MSDM meliputi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia (*staffing*), pengarahan (*directing*), dan pengawasan (*controlling*).

Konsep Manajemen Asuhan Keperawatan (MAK) secara spesifik merujuk pada serangkaian kegiatan kolaboratif dengan staf keperawatan untuk memberikan pelayanan asuhan yang profesional, sejalan dengan proses keperawatan. Ini adalah tanggung jawab pengelola layanan keperawatan dalam merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengawasi sumber daya untuk pelayanan yang efektif dan berkualitas bagi pasien, keluarga, dan masyarakat. Esensinya adalah proses kolaboratif dan terstruktur yang bertujuan memberikan asuhan keperawatan yang profesional, efektif, dan berkualitas, dengan penekanan pada pengelolaan sumber daya yang tersedia.

Implementasi praktik keperawatan profesional memerlukan pertimbangan empat elemen fundamental yang saling terkait: standar praktik keperawatan, proses keperawatan sebagai kerangka kerja, pendidikan keperawatan berkelanjutan, dan Sistem Manajemen Asuhan Keperawatan Profesional (MAKP). Keempat unsur ini tidak terpisahkan dalam mewujudkan praktik keperawatan yang berkualitas.

Perubahan dalam MAKP dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah Kualitas Pelayanan Keperawatan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan harapan pasien, Standar Praktik Keperawatan yang menjadi acuan dalam memberikan asuhan, dan Model Praktik Keperawatan yang merupakan sistem pengorganisasian pemberian asuhan profesional. Beberapa model praktik keperawatan meliputi praktik di rumah sakit, perawatan di rumah (home care), praktik berkelompok, dan praktik individual.

Pemilihan Model Asuhan Keperawatan (MAKP) didasari oleh beberapa pertimbangan penting, seperti keselarasan dengan visi dan misi institusi, implementasi proses keperawatan yang sistematis, efisiensi dan efektivitas biaya, pemenuhan kepuasan klien, keluarga, dan masyarakat, kepuasan kinerja perawat, serta terjalinnya komunikasi yang adekuat antar perawat dan tim kesehatan lain.

Terdapat beberapa Model Asuhan Keperawatan Profesional (MAKP) yang terus berkembang, di antaranya adalah Metode Primer di mana satu perawat bertanggung jawab penuh selama 24 jam, Metode Modular yang melibatkan kerja sama tim profesional dan non-profesional, Metode Fungsional di mana perawat melaksanakan tugas tertentu berdasarkan jadwal, Metode Kasus yang umum diterapkan di ruang intensif atau isolasi dengan perawat berganti setiap shift, dan Metode Tim di mana perawat dibagi menjadi kelompok kecil untuk memberikan pelayanan yang menyeluruh. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sesuai dengan konteks pelayanan.

Secara keseluruhan, Manajemen Keperawatan adalah disiplin ilmu dan praktik yang kompleks dan dinamis, berfokus pada pengelolaan sumber daya secara efektif dan efisien demi tercapainya pelayanan keperawatan yang profesional dan berkualitas, yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan pasien dan kepuasan seluruh pihak terkait.

E. Glosarium

Administrasi: Proses pengelolaan dan pengorganisasian sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi.

Analisis Situasi: Proses pemahaman kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan ancaman) yang mempengaruhi pelayanan keperawatan, sering menggunakan metode SWOT.

Anggaran: Rencana keuangan yang merinci perkiraan pendapatan dan pengeluaran untuk periode waktu tertentu.

Asuhan Keperawatan: Rangkaian intervensi keperawatan yang diberikan kepada pasien untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya.

Delegasi: Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada staf untuk melaksanakan tugas tertentu.

Disiplin: Kepatuhan terhadap peraturan, kebijakan, dan tanggung jawab pekerjaan.

Efektif: Kemampuan untuk menghasilkan hasil yang diinginkan atau mencapai tujuan.

Efisien: Kemampuan untuk mencapai tujuan dengan penggunaan sumber daya yang minimal (waktu, biaya, tenaga).

Evaluasi Berkelanjutan: Proses penilaian yang dilakukan secara terus-menerus terhadap rencana atau tindakan yang telah dibuat untuk mengidentifikasi area perbaikan atau penyesuaian

Fasilitasi Kolaborasi: Upaya untuk mempermudah dan mendukung kerja sama antar anggota tim atau dengan pihak lain.

Fungsi Manajemen: Kegiatan dasar dalam manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan ketenagaan.

Hierarki: Struktur organisasi yang menunjukkan tingkatan wewenang dan tanggung jawab, dari manajemen puncak hingga staf pelaksana.

Holistik: Pendekatan dalam asuhan keperawatan yang mempertimbangkan seluruh aspek pasien (fisik, psikologis, sosial, dan spiritual).

Home Care (Praktik Keperawatan di Rumah): Model praktik keperawatan yang memberikan pelayanan di lingkungan rumah pasien sebagai kelanjutan dari layanan di rumah sakit.

Identifikasi Kebutuhan: Proses mengenali dan memahami keperluan pasien serta sumber daya yang dibutuhkan untuk memenuhinya.

Implementasi: Pelaksanaan rencana asuhan keperawatan atau tindakan yang telah direncanakan.

Inisiatif (Prakarsa): Kemauan untuk bertindak atau mengambil langkah tanpa menunggu perintah.

Intervensi Keperawatan: Tindakan spesifik yang dilakukan oleh perawat sebagai bagian dari rencana asuhan keperawatan.

Keadilan: Prinsip memperlakukan semua orang secara sama dan sesuai dengan haknya.

Kejujuran: Prinsip bertindak dan berbicara secara benar dan apa adanya.

Kepala Bidang Keperawatan: Posisi manajemen puncak dalam struktur organisasi keperawatan di suatu institusi.

Kepala Ruang/Bangsar: Perawat yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan koordinasi kegiatan keperawatan di suatu unit perawatan.

Kepemimpinan: Kemampuan untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan memotivasi staf untuk mencapai tujuan organisasi.

Kerja Sama Interprofesional: Kolaborasi dan komunikasi yang efektif antara perawat dengan profesional kesehatan lain.

Ketertiban: Kondisi lingkungan kerja yang teratur, rapi, dan kondusif.

Ketenagaan (Staffing): Fungsi manajemen yang berkaitan dengan perekrutan, pelatihan, penempatan, dan pengembangan staf.

Kriteria Hasil: Ukuran spesifik yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan intervensi keperawatan.

Kualitas Pelayanan Keperawatan: Tingkat optimalisasi asuhan keperawatan yang diberikan sesuai standar profesi dan pelayanan, berorientasi pada kepuasan pasien.

Komunikasi: Proses penyampaian dan penerimaan informasi antar individu atau kelompok.

Kompetensi: Kemampuan dan keterampilan yang dimiliki oleh perawat untuk melaksanakan tugasnya secara profesional.

Koordinasi Kegiatan: Upaya untuk memastikan semua bagian tim keperawatan bekerja sama dengan baik.

Legislasi Keperawatan: Proses pembuatan undang-undang atau peraturan yang mengatur praktik keperawatan.

Loyalitas Konsumen/Pelanggan: Tingkat kepercayaan dan kesetiaan pasien atau masyarakat terhadap layanan keperawatan.

Manajer Keperawatan: Individu yang bertanggung jawab atas perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya keperawatan.

Manajemen: Proses merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengawasi sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi.

Manajemen Konflik: Strategi untuk mengatasi perbedaan pendapat atau perselisihan antar individu atau kelompok.

Manajemen Keperawatan: Proses pengelolaan sumber daya keperawatan untuk menyediakan pelayanan keperawatan profesional dan berkualitas.

Manajemen Risiko: Proses identifikasi, analisis, dan pengendalian potensi bahaya atau kerugian.

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM): Serangkaian proses dan tindakan sistematis dalam merekrut, mengembangkan, memotivasi, dan mengevaluasi staf.

Metode Fungsional: Metode pemberian asuhan keperawatan di mana perawat melaksanakan tugas tertentu berdasarkan jadwal.

Metode Kasus: Metode pemberian asuhan keperawatan di mana setiap perawat bertanggung jawab selama shift mereka untuk pasien tertentu.

Metode Modular: Model pemberian asuhan keperawatan di mana tim profesional dan non-profesional bekerja sama untuk sekelompok pasien.

Metode Primer: Metode pemberian asuhan keperawatan di mana satu perawat bertanggung jawab penuh selama 24 jam untuk asuhan seorang pasien.

Metode Tim: Metode pemberian asuhan keperawatan di mana perawat dibagi menjadi kelompok kecil (tim) yang saling membantu.

Monitoring: Proses pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu kegiatan atau kondisi.

Moral Perawat: Prinsip-prinsip etika dan nilai-nilai yang mendasari perilaku perawat.

Motivasi: Dorongan atau semangat yang membuat staf bekerja dengan optimal.

Mutu Asuhan Keperawatan: Tingkat kesempurnaan pelayanan keperawatan yang sesuai dengan standar dan harapan.

Orientasi Staf: Proses pengenalan staf baru terhadap kebijakan, prosedur, dan budaya organisasi.

Otonomi Perawat: Kewenangan dan kebebasan perawat dalam mengambil keputusan terkait praktik keperawatannya sesuai dengan kompetensi.

Pelaporan Hasil: Penyampaian informasi mengenai hasil pengukuran kinerja kepada manajemen dan tim.

Pelatihan: Proses pengembangan pengetahuan dan keterampilan staf.

Pemusatan Wewenang: Kondisi di mana sebagian besar keputusan dan tanggung jawab berada di tingkat manajemen yang lebih tinggi.

Penetapan Prioritas: Proses mengurutkan tugas atau kebutuhan berdasarkan urgensi dan kepentingan.

Penetapan Sasaran: Proses menentukan hasil spesifik yang ingin dicapai oleh unit keperawatan.

Penetapan Standar: Proses menentukan tolok ukur atau kriteria kinerja yang diharapkan.

Penugasan Tanggung Jawab: Proses menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas setiap tugas atau kegiatan.

Pengarahan (Directing): Fungsi manajemen yang melibatkan pemberian instruksi, motivasi, dan bimbingan kepada staf.

Pengawasan (Controlling): Fungsi manajemen yang melibatkan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana serta tindakan.

Pengelompokan Tugas: Proses mengorganisir aktivitas keperawatan berdasarkan fungsi atau spesialisasi.

Penggajian: Sistem pemberian kompensasi (gaji atau upah) kepada perawat.

Pengkajian Kebutuhan Pasien: Proses pengumpulan data dan analisis informasi untuk mengidentifikasi kebutuhan pasien.

Pengorganisasian (Organizing): Fungsi manajemen yang melibatkan pengaturan sumber daya dan pembentukan struktur organisasi.

Penguatan Keyakinan dan Loyalitas Konsumen/Pelanggan: Upaya untuk meningkatkan kepercayaan dan kesetiaan pasien terhadap layanan.

Penilaian Kinerja: Proses evaluasi hasil kerja staf berdasarkan standar yang ditetapkan.

Perbaikan Berkelanjutan: Upaya terus-menerus untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan.

Perencanaan (Planning): Fungsi manajemen yang melibatkan penetapan tujuan dan strategi untuk mencapainya.

Perencanaan Penempatan Staf: Proses mengatur penugasan staf sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi.

Perawat Asisten: Tenaga non-profesional yang membantu perawat primer dalam memberikan asuhan.

Perawat Junior: Perawat dengan pengalaman kerja yang relatif sedikit.

Perawat Profesional: Perawat yang memiliki pendidikan dan kompetensi sesuai standar profesi.

Perawat Profesional Teregistrasi (Ners): Perawat profesional yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan dan memiliki izin praktik.

Perawat Primer: Perawat profesional yang bertanggung jawab penuh terhadap asuhan keperawatan seorang pasien selama 24 jam.

Proses Keperawatan: Metode sistematis dalam memberikan asuhan keperawatan yang meliputi pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Produktivitas Kerja Perawat: Tingkat efisiensi dan efektivitas perawat dalam melaksanakan tugasnya.

Program Pengembangan Staf: Kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi staf.

Prosedur: Langkah-langkah yang harus diikuti dalam melaksanakan suatu kegiatan atau tugas.

Prakarsa (Inisiatif): Kemauan untuk bertindak atau mengambil langkah tanpa menunggu perintah.

Praktik Keperawatan Berkelompok: Model praktik di mana beberapa perawat profesional membentuk kelompok untuk memberikan layanan.

Praktik Keperawatan Individual: Praktik keperawatan mandiri yang dilakukan oleh perawat profesional senior.

Proses Kognitif: Proses mental yang terlibat dalam berpikir, memahami, dan mengambil keputusan.

R

Rasio Beban Kerja: Perbandingan antara jumlah pasien yang harus dilayani dengan jumlah tenaga perawat yang tersedia.

Registrasi Keperawatan: Proses pendaftaran dan pencatatan perawat yang memenuhi syarat untuk melakukan praktik keperawatan.

Regulasi: Aturan atau ketentuan yang mengatur suatu kegiatan atau profesi.

Reorientasi dan Penyesuaian: Proses mengubah rencana atau strategi berdasarkan hasil evaluasi.

Rencana Asuhan Keperawatan: Dokumen yang berisi intervensi keperawatan yang spesifik untuk mengatasi masalah pasien dan mencapai kriteria hasil yang diharapkan.

Rujukan: Proses pengiriman pasien ke fasilitas kesehatan atau profesional lain untuk penanganan lebih lanjut.

Sasaran: Tujuan spesifik dan terukur yang ingin dicapai.

Seleksi Staf: Proses pemilihan kandidat yang paling memenuhi kualifikasi untuk mengisi posisi yang tersedia.

Semangat Kesatuan: Rasa kebersamaan dan saling mendukung antar anggota tim.

Skrining Pasien: Proses awal pemeriksaan pasien untuk mengidentifikasi kebutuhan atau masalah kesehatan.

Spesialisasi: Fokus pada area praktik keperawatan tertentu.

Stabilitas Kerja: Kondisi kerja yang aman, nyaman, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Standar Kinerja: Tolok ukur yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pelaksanaan tugas.

Standar Pelayanan: Pedoman atau ketentuan mengenai kualitas pelayanan yang harus dipenuhi.

Standar Praktik Keperawatan: Pernyataan yang menggambarkan tingkat kinerja profesional yang diharapkan dari perawat.

Strategi: Rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi.

Struktur Organisasi: Kerangka kerja formal yang menunjukkan pembagian kerja, hierarki wewenang, dan jalur komunikasi dalam organisasi.

Supervisi: Proses pengawasan dan bimbingan terhadap pelaksanaan tugas staf.

SWOT: Analisis kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman (Threats).

Sistem: Sekumpulan elemen yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

Sistem Manajemen Asuhan Keperawatan Profesional (MAKP): Kerangka kerja yang mengorganisasikan pemberian asuhan keperawatan profesional.

Sistem Penggajian: Metode dan aturan yang digunakan untuk memberikan kompensasi kepada karyawan.

Target: Hasil spesifik yang ingin dicapai dalam jangka waktu tertentu.

Tanggung Jawab: Kewajiban untuk melaksanakan tugas dan menerima akibat dari tindakan.

Tenaga Non-Profesional: Staf pendukung dalam pelayanan keperawatan yang tidak memiliki pendidikan keperawatan formal (misalnya, perawat asisten).

Tindakan Korektif: Langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi penyimpangan antara kinerja aktual dan standar.

Tujuan: Hasil akhir yang ingin dicapai oleh organisasi atau unit kerja.

Wewenang: Hak untuk mengambil keputusan dan memberikan perintah terkait tugas dan tanggung jawab.

F. Daftar Pustaka

Bakri. (2017). Manajemen Keperawatan (Konsep dan Aplikasi Dalam Praktik Keperawatan Profesional). Pustaka Baru Press.

Feriyanto, A., & Triana, E. S. (2015). Pengantar Manajemen. Media Tera.

Fransiska, F. (2021). Penelitian Manajemen Keperawatan. 1–3.

Marquis, B. L., & Huston, C. J. (2013). Leadership Roles and Management Functions in Nursing: Theory and Application: Seventh Edition.

Nursalam. (2013). Manajemen Keperawatan: Teori dan Aplikasi dalam Praktik. Salemba Medika.

Ricardianto, P. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia. Pengaruh Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan dengan Komitmen Organisasional Sebagai Variabel Intervening. Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM), 1–15.

Simamora, R. H. (2013). UPAYA PEMBINAAN PERAWAT DI RUMAH SAKIT NGESTI WALUYO PARAKAN TEMANGGUNG JAWA TENGAH Roymond H Simamora Staf Pengajar PSIK Universitas Jember. Jurnal Keperawatan Soedirman, 8(2), 105–119.

<http://www.jks.fikes.unsoed.ac.id/index.php/jks/article/view/482%0Ahttp://www.jks.fikes.unsoed.ac.id/index.php/jks/article/download/482/249>

Sureskiati. (2019). Hubungan Lingkungan Kerja dan Masa Kerja dengan Kepatuhan Perawat dalam Melaksanakan Tindakan Pencegahan Pasien Jatuh di RSUD A. Muis Samarinda. 53(9).

PROFIL PENULIS



Uun Kurniasih, lahir di Cirebon pada tanggal 17 September 1977, menyelesaikan Pendidikan Diploma III Keperawatan di AKper Yapkesbi Cirebon Lulus tahun 1998, melanjutkan Pendidikan S1 Keperawatan di STIKes Cirebon tamat tahun 2003, melanjutkan pendidikan profesi Ners di STIKes Cirebon tamat tahun 2011, melanjutkan Pendidikan Magister Manajemen Kesehatan di IMNI Jakarta tamat tahun 2012 Sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang sebagai tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Cirebon. Pada tahun 2018 , menerbitkan buku ajar keperawatan dasar, keperawatan anak, manajemen keperawatan menulis buku panduan pratikum keperawatan maternitas 1 dengan ISN;978-602-451-187-6.dan menerbitkan beberapa jurnal dibidang Kesehatan yang diterbitkan di jurnal nasional terakreditasi/internasional.



Mokhamad Nurhadi

Mokhamad Nurhadi, S.Kep., Ns., M.Kep., MM. Lahir di Tuban tanggal 22 April 1980. Riwayat pendidikan: D-3 Keperawatan Politeknik Kesehatan Surabaya Prodi Keperawatan Tuban (2004), S-1 Keperawatan Stikes NU Tuban (2011), S-2 Manajemen Sumberdaya Manusia STIE Mahardika (2013), S-2 Manajemen Keperawatan Universitas Airlangga (2018). Saat ini bekerja sebagai staf dosen di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Ds. Sumberjo RT. 002 RW. 005 Kec. Merakurak Kab. Tuban Jawa Timur.

Karya tulis yang pernah dihasilkan diantaranya: Karya artikel penelitian "Laporan Hasil Aplikasi Klinik Pengembangan Instrumen Case Management Berdasarkan Research and Development Di Ruang Bedah Cempaka RSUD Dr. Soetomo Surabaya".



Ns. Fitra Mayenti, S.Kep., M.Kep Lahir di Teratak Pauh, 19 November 1983. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Andalas Padang tahun 2006 dan profesi Ners 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Universitas Andalas Padang dan lulus tahun pada tahun 2016 Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009-2010 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Indonesia Padang, tahun 2011-2012 di Akademi Keperawatan Dharma Husada Pekanbaru. Saat ini penulis bekerja di Institut Kesehatan dan Teknologi Al Insyirah Pekanbaru, mengampu mata kuliah Manajemen Keperawatan dan Konsep Dasar Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: fitramayenti19@gmail.com

PROFIL PENULIS



Didi Taswidi S.Kep., Ners., M.Kep. lahir di Indramayu, 14 Juni 1994. Lulusan S1-Keperawatan Sekolah Ilmu Kesehatan (STIKes) Cirebon, lulusan Profesi Ners Sekolah Ilmu Kesehatan (STIKes) Cirebon dan lulusan Magister Keperawatan Universitas Jendral Achmad Yani tahun (Unjani).

Pengalaman pekerjaan penulis di antaranya sebagai Staff LPK STIKes Cirebon, Staff Prodi Profesi Ners STIKes Cirebon, Staff Prodi S1 Keperawatan STIKes Cirebon, Sekpro S1 Keperawatan STIKes Cirebon, dan Dosen Keperawatan STIKes. Saat ini penulis aktif sebagai Pengurus Himpunan Perawat Holistik Indonesia PW Jabar.



Syaiful, S.Pd., S.Kep., Ns., M.Pd., M.Kes.

Syaiful, Seorang dosen dan praktisi keperawatan berdedikasi, lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat, pada 23 Mei 1968. Beliau menyelesaikan pendidikan tinggi S1 di Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Airlangga, Surabaya, pada tahun 2002. Selanjutnya, ia meraih gelar Magister Pendidikan (M.Pd.) di Universitas Adibuwana Surabaya pada tahun 2009, dan melengkapi pendidikan Magister Kesehatan (M.Kes) di Universitas Qamarul Huda Badaruddin Bagu, Lombok Tengah, NTB, pada tahun 2023.

Karier profesionalnya dimulai pada tahun 2000 di Program Studi Keperawatan Bima Akper Depkes Mataram NTB, yang kini menjadi bagian dari Poltekkes Kemenkes Mataram. Saat ini, beliau mengajar di Poltekkes Kemenkes Mataram-NTB dengan mata kuliah utama meliputi Metodologi Penelitian, Konsep Dasar Keperawatan, Manajemen Keperawatan, Keperawatan Jiwa, dan Keperawatan Keluarga/Komunitas.

Sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, Syaiful aktif menulis buku, mempublikasikan karya ilmiah, menjadi narasumber di berbagai seminar, serta berkontribusi dalam lokakarya dan pelatihan. Kepakarannya mencakup bidang manajemen keperawatan, pendidikan keperawatan, serta penerapan praktik keperawatan berbasis bukti. Dengan motto hidupnya, "Jangan biarkan matahari terbenam tanpa makna", Syaiful terus berkomitmen untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu keperawatan dan mendukung profesionalisme di bidang kesehatan. Beliau dapat dihubungi melalui email di syaiful6823@gmail.com.

PROFIL PENULIS



Ns. Sasteri Yuliyanti, S.Kep.,M.Kep. Lahir di Apitaik, 08 Juni 1985. Pendidikan yang telah ditempuh penulis yaitu jenjang S1 dan Ners pada program studi ilmu keperawatan Universitas Brawijaya lulus pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Muhammadiyah Jakarta dan lulus pada tahun 2017. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2011 pada STIKES Hamzar Memben Lombok Timur sebagai dosen biasa, kemudian menjabat sebagai ketua program studi pada tahun 2017 s.d 2022.

Saat ini penulis bekerja di Program Studi Ilmu Kesehatan Universitas Dehasen Bengkulu. Mengampu mata kuliah Manajemen Keperawatan, Keperawatan Kesehatan Jiwa, Keperawatan Kegawatdaruratan Maternitas, dan Keperawatan Kegawatdaruratan Anak. Penulis aktif dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku dan publikasi. Berikut judul buku dan publikasi; Kumpulan Latihan Soal Ukom Profesi Ners, Bookchapter Keperawatan Jiwa, Analysis of factors that influence nurse career development In dr. Soedjono selong hospital, Analisis Faktor Yang Berhubungan Dengan Tingkat Kecemasan Perawat Pasca Pandemi Covid-19 Di Puskesmas Selong, Hubungan Tingkat Pendidikan Dengan Perilaku Kepatuhan 3M Dalam Upaya Pencegahan Penularan Covid-19 Pada Era New Normal Di Puskesmas Sakra, Pengetahuan Ibu Berhubungan Dengan Perkembangan Motorik Kasar Pada Anak Usia 12-24 Bulan, Pengaruh Story Telling Tentang Kesiapan Menghadapi Bencana Gempa Bumi Terhadap Self Efficacy Anak Prasekolah, Pengaruh Beban Kerja Terhadap Perilaku Caring Perawat di Rawat Inap Interna I dan II RSUD DR. R. Soedjono Selong, Penulis dapat dihubungi melalui email: yuliantisatri@gmail.com.



Mei Widyawati, S. Kep., Ns., M. Kep Lahir di Tuban, 05 Mei 1992. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 dan Profesi Ners pada Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan dan Pendidikan Profesi Ners, STIKES Nahdlatul Ulama Tuban tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas Airlangga Surabaya dan lulus tahun pada tahun 2018. Sejak tahun 2015, saya mengawali karier di dunia pendidikan tinggi sebagai Asisten Dosen di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Saat ini penulis bekerja di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban mengampu mata kuliah Manajemen keperawatan, keperawatan anak, dan

Pemenuhan Kebutuhan dasar Manusia. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, seminar, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang selalu berupaya membangun sinergi dengan berbagai pihak, baik institusi, pemerintah, organisasi masyarakat, maupun sektor swasta. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: widyawatimei05@gmail.com

Motto: "Beruntunglah seseorang yang menjadikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin"

Sinopsis

Buku ajar "Manajemen Keperawatan" ini disusun sebagai referensi penting dalam memahami konsep, prinsip, dan praktik manajerial yang diterapkan dalam pelayanan keperawatan. Di tengah dinamika sistem kesehatan yang terus berkembang, perawat dituntut tidak hanya mahir dalam keterampilan klinis, tetapi juga kompeten dalam mengelola sumber daya, memimpin tim, serta mengambil keputusan yang berorientasi pada mutu pelayanan.

Buku ini membahas secara komprehensif berbagai aspek manajemen yang relevan dalam praktik keperawatan, mulai dari konsep dasar manajemen, fungsi-fungsi manajerial (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian), peran manajer keperawatan, pengelolaan sumber daya manusia, komunikasi organisasi, manajemen konflik, hingga peningkatan mutu pelayanan keperawatan.

Dengan pendekatan teoritis yang kuat dan disertai dengan contoh-contoh aplikatif di lapangan, buku ini dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran mahasiswa keperawatan pada jenjang diploma, sarjana, maupun profesi. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi panduan praktis bagi para perawat klinis, kepala ruangan, dan manajer keperawatan dalam menghadapi tantangan manajerial di lingkungan kerja.

Disusun berdasarkan standar kompetensi keperawatan dan referensi ilmiah terkini, buku ini diharapkan dapat memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan manajerial, serta mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin keperawatan yang mampu membawa perubahan positif dalam dunia kesehatan.

Buku ajar "Manajemen Keperawatan" ini disusun sebagai referensi penting dalam memahami konsep, prinsip, dan praktik manajerial yang diterapkan dalam pelayanan keperawatan. Di tengah dinamika sistem kesehatan yang terus berkembang, perawat dituntut tidak hanya mahir dalam keterampilan klinis, tetapi juga kompeten dalam mengelola sumber daya, memimpin tim, serta mengambil keputusan yang berorientasi pada mutu pelayanan.

Buku ini membahas secara komprehensif berbagai aspek manajemen yang relevan dalam praktik keperawatan, mulai dari konsep dasar manajemen, fungsi-fungsi manajerial (perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian), peran manajer keperawatan, pengelolaan sumber daya manusia, komunikasi organisasi, manajemen konflik, hingga peningkatan mutu pelayanan keperawatan.

Dengan pendekatan teoritis yang kuat dan disertai dengan contoh-contoh aplikatif di lapangan, buku ini dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran mahasiswa keperawatan pada jenjang diploma, sarjana, maupun profesi. Selain itu, buku ini juga dapat menjadi panduan praktis bagi para perawat klinis, kepala ruangan, dan manajer keperawatan dalam menghadapi tantangan manajerial di lingkungan kerja.

Disusun berdasarkan standar kompetensi keperawatan dan referensi ilmiah terkini, buku ini diharapkan dapat memperluas wawasan, meningkatkan keterampilan manajerial, serta mendorong lahirnya pemimpin-pemimpin keperawatan yang mampu membawa perubahan positif dalam dunia kesehatan.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan
Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-96049-8-7



9

786349

604987